



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JANUARI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI	
Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi	2
2.2 Misi	2
2.3 Motto	2
2.4 7 Nilai Budi Utama	2
2.5 Struktur Organisasi	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan	5
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada	6
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan	6
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik	19
3.3.2 Rawat Inap	21
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)	29
3.3.4 High Care Unit (HCU)	30
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)	31
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO)	33
3.4 Kinerja Bidang Penunjang	34
3.4.1 Instalasi Farmasi	34
3.4.2 Laboratorium	55
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran	57
3.4.4 Radiologi	63
3.4.5 Gizi	68
3.4.6 CSSD - Laundry	76
3.5 Kinerja Bidang Umum	79
3.5.1 SDM	79
3.5.2 IPSRS	88
3.5.3 Security	97
3.5.4 Parkir	100
3.5.5 Humas Marketing	100
3.5.6 Penjaminan	116
3.5.7 PIPP – MOD – MPP	117
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	125
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum	126
3.5.10 IT - SIMRS	128
3.5.11 Driver	138
3.5.12 PRIMANTARA	138
3.6 Komite dan Tim	139
3.6.1 Komite Mutu	139
3.6.2 Komite PPI	155
3.6.3 Tim PKRS	169
3.6.4 Tim Prognas	170
3.6.5 Tim PPRA	210
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT	213
3.7 Permasalahan Rumah Sakit	215
3.8 Profil SDM	219
Bab IV Kesimpulan dan Saran	223
Bab V Penutup	223
Lampiran	224

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Januari Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



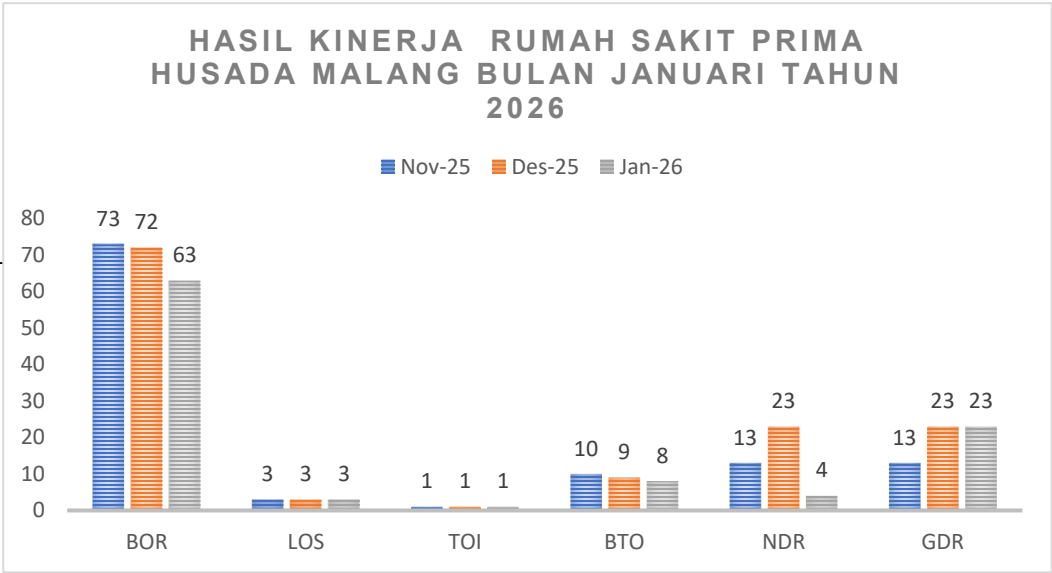
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
BOR	73%	72%	63%
LOS	3 hari	3 hari	3 hari
TOI	1 hari	1 hari	1 hari
BTO	10 kali	9 hari	8 hari

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

3.1.3.1 Analisa

- BOR mengalami penurunan signifikan** dari 73% (Nov) menjadi 63% (Jan).
Menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur menurun.
- BTO menurun bertahap** dari 10 kali menjadi 8 kali.
Frekuensi penggunaan tiap tempat tidur semakin rendah.
- LOS tetap stabil (3 hari)**
Lama perawatan pasien tidak berubah, pelayanan medis berjalan konsisten.
- TOI tetap 1 hari**
Waktu kosong tempat tidur antar pasien masih efisien.
- LOS : stabil 3 hari**
 - LOS yang stabil menunjukkan lama perawatan pasien konsisten.
 - Hal ini menunjukkan bahwa lama perawatan rata-rata pasien stabil dan tidak ada gangguan signifikan dalam alur pelayanan.
- TOI: tetap 1 hari
 - TOI yang konsisten menunjukkan waktu tunggu tempat tidur sebelum digunakan kembali berada pada kondisi optimal.
 - Kapasitas tempat tidur yang tersedia dapat langsung digunakan kembali tanpa jeda yang terlalu Panjang menandakan manajemen bed berjalan baik

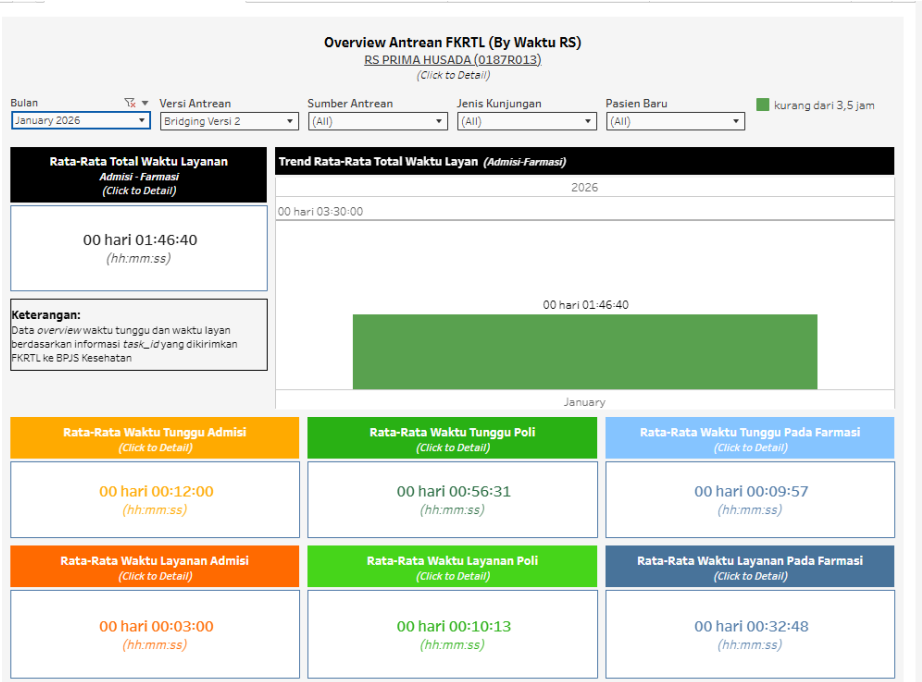
3.1.3.2 Masalah

- Penurunan pendapatan rawat inap
- Utilisasi sarana dan SDM tidak optimal
- Biaya operasional per pasien meningkat
- Efisiensi layanan rumah sakit menurun

3.1.3.3 Tindak Lanjut

- 1. Evaluasi kebutuhan jumlah tempat tidur bila tren berlanjut
- 2. Pengembangan layanan spesialis dengan kebutuhan rawat inap tinggi
- 3. Strategi pemasaran layanan rawat inap

6.1.1 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN	BULAN (2025)							
		Rata-Rata Tahun 2024	Rata-rata semester 2 2025	1	2	3	4	5	6
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	01:46:32	1:46:40					
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	0:08:14	0:12:00					
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	0:06:01	0:03:00					
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	0:58:16	00:56:31					
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	0:09:55	0:10:13					
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	0:09:02	0:09:57					
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	0:36:47	0:32:48					

Analisis :

Pada bulan ini masih dalam batas normal Lebih rendah dari rata-rata tahun 2024 dan tahun 2025. Sudah sesuai target.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer

Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

6.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

6.2.1 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRJA-IRNA	Peningkatan kompetensi dan skill perawat yang belum mandiri	1. Untuk perawat yang belum mandiri terkait skill phlebotomi, infus, pasang kateter dan NGT, dari komite keperawatan memfasilitasi untuk tindakan tersebut 2. Setiap perawat ada target dalam satu bulan untuk menyelesaikan prasad nya	1. Untuk saat ini, masih ada 1 pasien yang komplain karena gagal infus oleh perawat poli 2. Perawat supervisor wajib mendampingi saat tindakan 3. Pastikan pasien yang akan dilakukan tindakan bukan pasien yang potensi komplain
2	IRJA	Review Alur vaksin	1. Untuk penanggungjawab vaksin Faizatul Muawanah,yang sebelumnya di IGD, di rotasi ke poli per tanggal 2 januari 2026 untuk handel dan prioritas poli vaksin dan MCU 2. PJ vaksin harus mempunyai back up jika faiza cuti atau sakit sehingga tidak menghambat pelayanan vaksin dan tidak lempar-lempar tanggungjawab	Selama pelaksanaan vaksin 1 bulan oleh PIC faiza ditemukan evaluasi sbb : 1. ada kesalahan penginputan NIK - 2. ada pembetulan e-icv 4x 3. travel komplain karena form nya tidak dituliskan atau dibantu seperti biasa 4. beberapa ada yang tidak ada lampiran foto KTP, atau paspornya, kadang foto paspor terpotong Dengan adanya evaluasi diatas, maka mereview alur vaksin dan emngadakan rapat dengan Kabid penunjang, Kabid

				Umum, tim PDF, Tim Humas, Tim IRJA, Tim Apotik untuk membuat alur yang lebih baik
4	IGD	Morning report	Morning report seminggu sekali dengan melihat jumlah pasien rawat jalan dan mengidentifikasi apakah ada case yang bisa di MRS kan untuk meningkatkan kunjungan	Morning report kedepannya akan dilakukan seminggu 2x, di siang hari pukul 14.00. dihadiri dokter IGD shift pagi, karu/perawat PJ, yanmed,spi dan dir bila diperlukan Untuk morning report akan di selenggarakan lagi bulan february. Karena sempat kosong di bulan desember
5	IKO	Rencana permintaan alat Endoscopi	1. Mengidentifikasi diagnosa yang dirujuk dengan alasan endoscopi 2. Koordinasi dengan KMKB untuk perhitungan tarif endoscopi terutama BPJS kesehatan 3. Membuat FS (<i>feasibility study</i>) alat endoscopi koordinasi dengan IPSRS untuk penggunaan alat dan bagian umum untuk perhitungan keuangan	Proses pengajuan FS

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS.	Dalam antrian programmer

			d. Jumlah KPO tertinggal : 155 e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025,	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i> .

			sudah tersedia cctv dan smart door lock.	
		5. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	a. Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara. b. Belum ada penanda resep obat siap dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap di SIMRS. c. Perubahan alur pendaftaran primantara oleh farmasi. a. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.
		6. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		7. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.

			terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	
		8. Pelayanan retriksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		9. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama	Pengajuan fitur ke progamer.

			pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		10. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP “Pasien tidak ambil obat”	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP “Pasien tidak ambil obat” untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
		11. Ruang handrub	a. Penambahan ruang handrub pada tanggal 28 mei 2025 untuk pengisian botol cairan handrub yang habis di ruangan agar meminimalkan mikroorganisme. b. Pengisian handrub dilakukan oleh apoteker. c. Sudah dilakukan sosialisasi pengisian botol handrub oleh komite PPI.	Monitoring dan Evaluasi.
		12. Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik	Alur pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik : a. Melakukan edukasi ke pasien terkait harga vaksin dan biaya jasa dokter kemudian dibuatkan copy resep manual (yang berisi identitas pasien, nama vaksin, jumlah dan no telfon pasien) b. Pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. c. Order vaksin ke gudang farmasi. d. Ketika vaksin datang akan dihubungi oleh marketing. e. Farmasi melakukan cetak nota pasien dan follow up kepada kasir untuk pelunasan berdasarkan kwitansi manual sebelumnya.	Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik

			d. Pasien melakukan suntik di poli vaksin.	
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok. 2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer. a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Rencana trial menunggu Programmer PT Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3.	Floorstok IKO	Perbaikan sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok.	Monitoring dan Evaluasi.

			- Perbaiki alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi	
--	--	--	---	--

			oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstock IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstock IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstock ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstock iko. - Jumlah stok di sistem Floorstock IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan	
--	--	--	--	--

			operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi”	
--	--	--	---	--

			bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih di sistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada di depo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep	
--	--	--	--	--

			manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar	
--	--	--	--	--

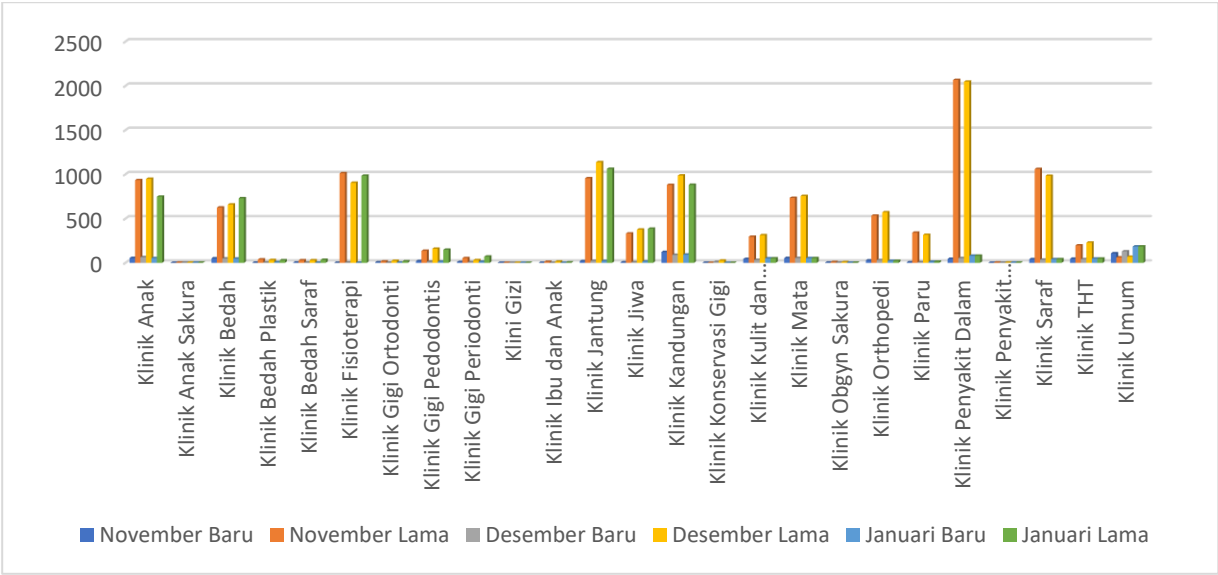
			Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	Poli gizi dan kia belum menjalankan ERM	1. Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM. 2. Beberapa kendala teknis dan keterbatasan SDM dalam penggunaan sistem.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Formulir rekapitulasi kegiatan pelayanan laboratorium pada SIMRS	Rekapitulasi jumlah pemeriksaan lab dengan kriteria jenis kelamin dan hasil nilai rata-rata pemeriksaan lab	Keterlambatan pengisian pada web SIRS online → Follow up ke Programmer untuk update fitur di SIMRS

6.3 Kinerja Bidang Pelayanan

6.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

6.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

No	Nama Unit	November 2025			Desember 2025			Januari 2026		
		Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total
1	Klinik Anak	54	934	988	63	948	1011	53	747	800
2	Klinik Anak Sakura	0	2	2	2	2	4	2	2	4
3	Klinik Bedah	50	624	674	48	658	706	47	729	776
4	Klinik Bedah Plastik	1	38	39	4	31	35	7	28	35
5	Klinik Bedah Saraf	3	28	31	2	28	30	1	33	34
6	Klinik Fisioterapi	0	1012	1012	4	904	908	1	984	985
7	Klinik Gigi Ortodonti	5	14	19	1	22	23	3	16	19
8	Klinik Gigi Pedodontis	19	135	154	12	158	170	13	147	160
9	Klinik Gigi Periodonti	8	53	61	7	30	37	12	70	82
10	Klini Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Klinik Ibu dan Anak	0	10	10	0	13	13	0	4	4
12	Klinik Jantung	17	955	972	21	1137	1158	20	1061	1081
13	Klinik Jiwa	5	331	336	7	375	382	15	384	399
14	Klinik Kandungan	122	880	1002	89	986	1075	92	881	973
15	Klinik Konservasi Gigi	0	0	0	9	25	34	0	0	0
16	Klinik Kulit dan Kelamin	43	294	337	32	311	343	50	50	100
17	Klinik Mata	54	733	787	54	755	809	52	52	104
18	Klinik Obgyn Sakura	2	8	10	2	7	9	1	1	2
19	Klinik Orthopedi	27	533	560	30	571	601	21	21	42
20	Klinik Paru	5	340	345	6	316	322	12	12	24
21	Klinik Penyakit Dalam	44	2066	2110	52	2047	2099	80	80	160
22	Klinik Penyakit Dalam Sakura	0	2	2	1	2	3	2	2	4
23	Klinik Saraf	40	1059	1099	35	983	1018	40	40	80
24	Klinik THT	46	196	242	41	228	269	47	47	94
25	Klinik Umum	107	60	167	129	68	197	184	184	368



Analisis :

- 1. Kunjungan pasien rawat jalan Desember 2025 ke Januari 2026 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 2%
- 2. Kunjungan tertinggi : Poli Penyakit Dalam dengan kunjungan 2253 pasien
- 3. Kenaikan tertinggi : Poli Gigi Periodonti dengan peningkatan sebesar 122%

4. Penurunan tertinggi : Poli Anak dengan penurunan signifikan sebesar 21%

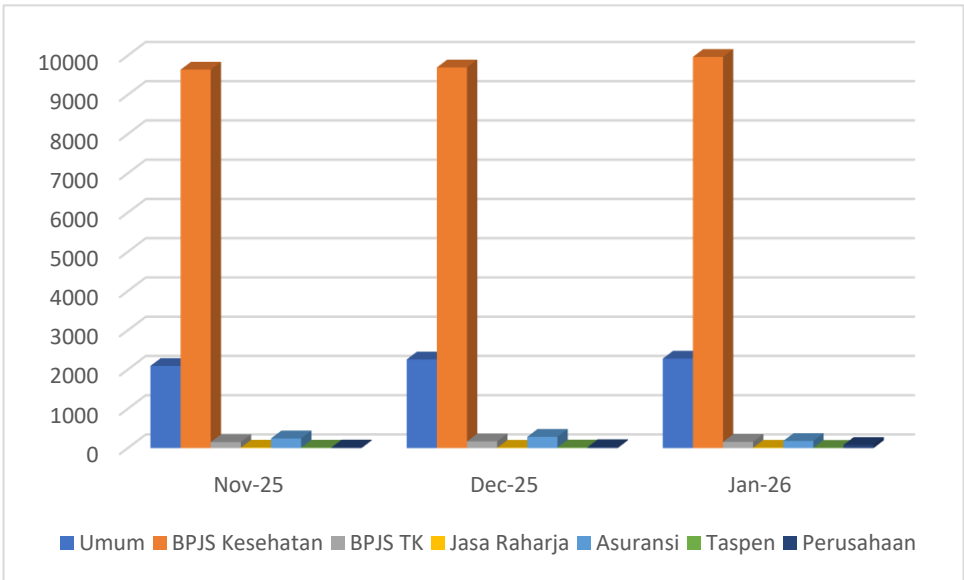
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
- 2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli Sakura
- 3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- 4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- 5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

No	Jenis Pembayaran	Nov-25	%	Dec-25	%	Jan-26	%
1	Umum	2092	17,19%	2258	18,12%	2279	17,97%
2	BPJS Kesehatan	9641	79,22%	9696	77,83%	9966	78,60%
3	BPJS TK	153	1,26%	170	1,36%	158	1,25%
4	Jasa Raharja	12	0,10%	8	0,06%	9	0,07%
5	Asuransi	246	2,02%	287	2,30%	181	1,43%
6	Taspen	12	0,10%	15	0,12%	7	0,06%
7	Perusahaan	14	0,12%	24	0,19%	80	0,63%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

Kunjungan pasien baru tertinggi yaitu di instalasi gawat darurat 319 pasien diikuti dari klinik umum dengan jumlah pasien baru sebesar 184 pasien, untuk persentase pasien baru sebesar (8,73%), pasien lama sebesar (91,27%)

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan

beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

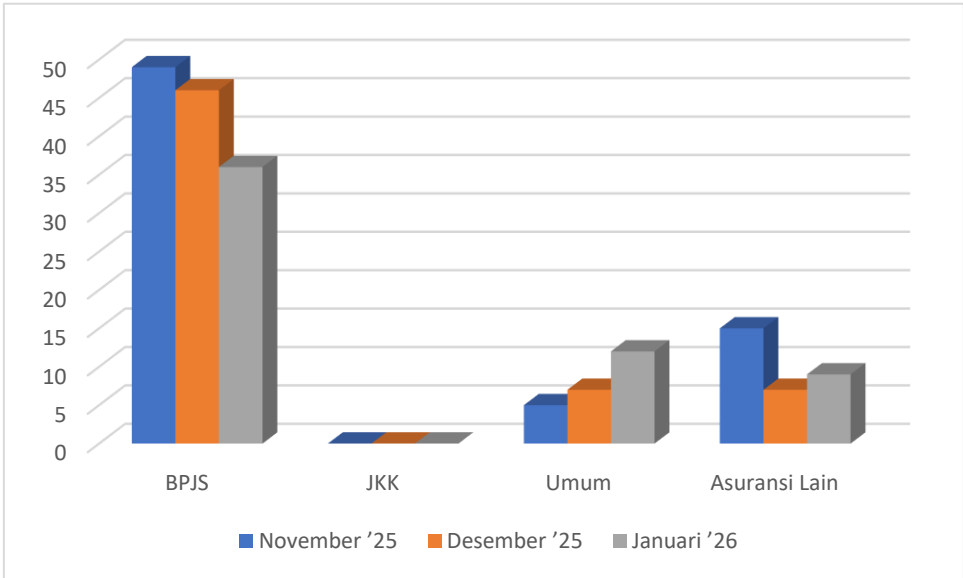
6.3.2 Rawat Inap

6.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)

NO	Hal	November '25	Desember '25	Januari '26	Persentaser terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	49	46	36	↓21,73%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	5	7	12	↑71,42%
4	Asuransi Lain	15	7	9	↑28,57%
Total Pasien		69	60	57	↓5

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (November 2025 – Januari 2026)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Bulan	RAWAT INAP				Total Pasien
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Nov. 2025	49	5	0	15	69
	Analisa	Bulan November pasien BPJS mengalami kenaikan dari 35 menjadi 49	Bulan November pasien umum stabil diangka 5	Pasien JKK bulan November kosong. Karena tidak	Pasien asuransi di bulan November mengalami penurunan karena pasien banyak yg memakai BPJS dan COB dengan	Bulan November total pasien mengalami kenaikan yg segnifkan dari 64 menjadi 69

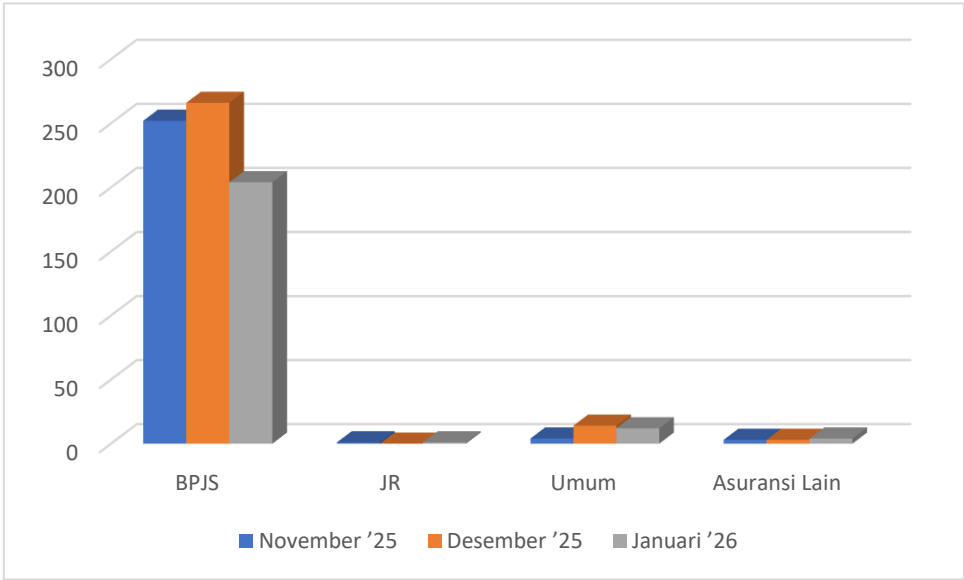
					asuransi	
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
2	Des. 2025	46	7	0	7	60
	Analisa	Bulan Desember pasien BPJS mengalami penurunan dari 49 menjadi 46	Bulan Desember pasien Umum naik dari 5 menjadi 7	Pasien JKK bulan Desember kosong. Karena tidak ada pasien JKK yg naik kelas	Untuk pasien asuransi di bulan desember bertahan di 7. Tidak ada kenaikan/ pun penurunan	Total bulan Desember jumlah pasien mengalami penurunan dari 69 menjadi 60
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
3	JANUARI 2026	36	12	0	8	57
	Analisa	Bulan JANUARI pasien BPJS mengalami penurunan dari 49 menjadi 36	Bulan JANUARI pasien Umum naik dari 7 menjadi 12	Pasien JKK bulan JANUARI kosong. Karena tidak ada pasien JKK yg naik kelas	Untuk pasien asuransi di bulan mengalami penurunan karena pasien banyak yg memakai BPJS dan COB	Total bulan JANUARI jumlah pasien mengalami penurunan dari 60 menjadi 57
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar
(November 2025 – Januari 2026)

NO	Hal	November '25	Desember '25	Januari '26	Persentaser terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	252	266	204	↓ 30%
2	JR	1	0	1	↑100%
3	Umum	4	14	12	↓16%
4	Asuransi Lain	3	3	4	↑25%
Total Pasien		260	283	221	↓28%

3.1.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2025 – Januari 2026)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

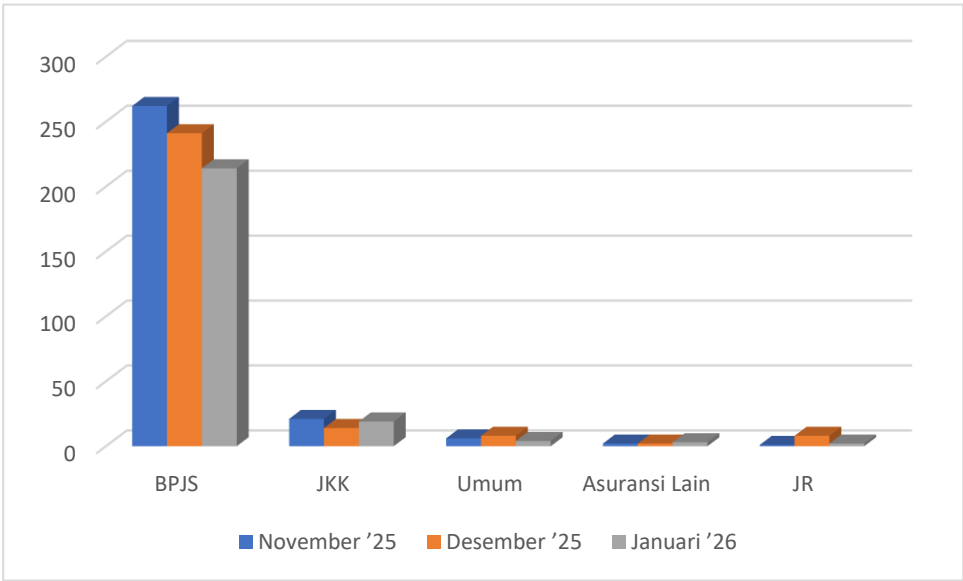
No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR	Asuransi	
	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peurunan di bulan Januari sebesar 30%	Pasien umum mengalami penurunan 16% pada bulan januari	Pasien JR dari 3 bulan terakhir mengalami peningkatan di bulan januari Sebesar 100%	Pasien Asuransi mengalami peningkatan 25%, karena semua orang mulai beralih ke asuransi meskipun memiliki BPJS	Pada bulan januari kunjungan pasien mengalami penurunan sebesar 28 %
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)

NO	HAL	November '25	Desember '25	Januari '26	Persentaser terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	262	241	214	10,1 %
2	JKK	21	14	19	↑33,3 %
3	Umum	6	8	4	↓50 %
4	Asuransi Lain	2	2	3	100 %
5	JR	1	8	2	↓ 87,2 %
Total Pasien		292	273	242	↓ 11,25 %

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2025 – Januari 2026)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

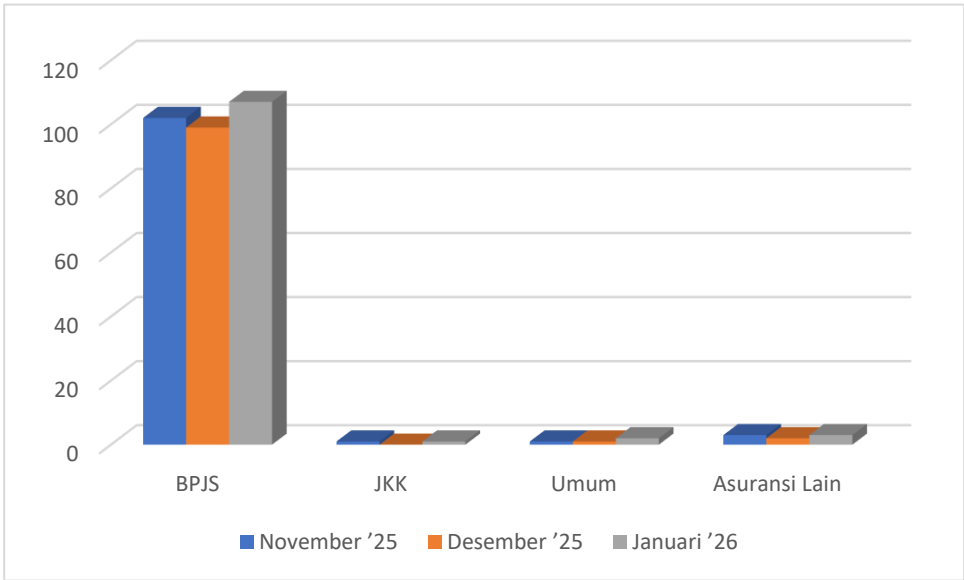
No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Januari 2026	Pasien BPJS mengalami penurunan pada bulan Januari 2026 sebesar penurunan 10,1 %	Pasien Umum pada bulan Jnauari 2026 mengalami penurunan yaitu sebanyak 33,3 %	Jumlah Pasien JKK pada bulan Januari 2026 mengalamai peningkatan yaitu sebanyak 35,7 %	Jumlah Pasien JR pada bulan Januari mengalami penurunan 87, 5% dan pasien asuransi prosentase sama dengan bulan sebelumnya	Penurunan jumlah pasien di bulan Januari 2026 sebanyak 11,27 % dibandingkan dengan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Untuk Irna 3A sementara tutup dan dialihkan ke Irna 2A dikarenakan TT dilantai 2A 15 TT serta terdapat ruang transit 6. Lantai 3A dibuka jika memang disemua lantai penuh.				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2025 – Januari 2026)

NO	HAL	November '25	Desember '25	Januari '26	Persentaser terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	102	99	107	↑7,47
2	JKK	1	0	1	↑100%
3	Umum	1	1	2	↑100%
4	Asuransi Lain	3	2	3	↑50%
Total Pasien		107	101	113	↑11,88%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2025 – Januari 2026)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian November 2025	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↓1,96% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑100% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓83,33% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak ↓40% dari bulan sebelumnya	Pada bulan November untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↓7,47%.
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

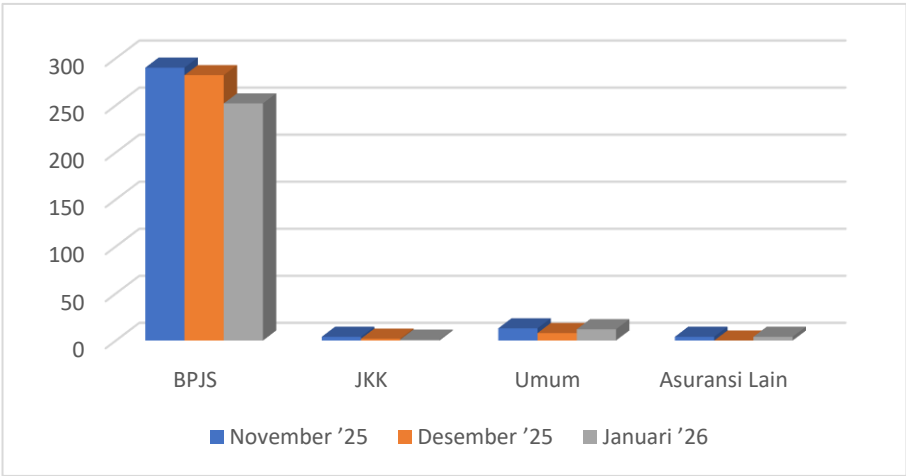
2	Analisis capaian Desember 2025	Total Pasien BPJS mengalami penurunan sebanyak ↓3% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum sama dengan kunjungan bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓100% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓33% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Desember untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↓5,6%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
3	Analisis capaian Januari 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑7,47% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑100% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami peningkatan ↑100% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak ↑50% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Januari 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑11,88%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)

NO	HAL	November '25	Desember '25	Januari '26	Persentaser terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	290	282	252	↓11,9%
2	JKK	4	2	1	↓100%
3	Umum	13	8	12	↑ 33,3%
4	Asuransi Lain	4	0	4	↑ 100%
Total Pasien		311	292	268	↓8,9%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

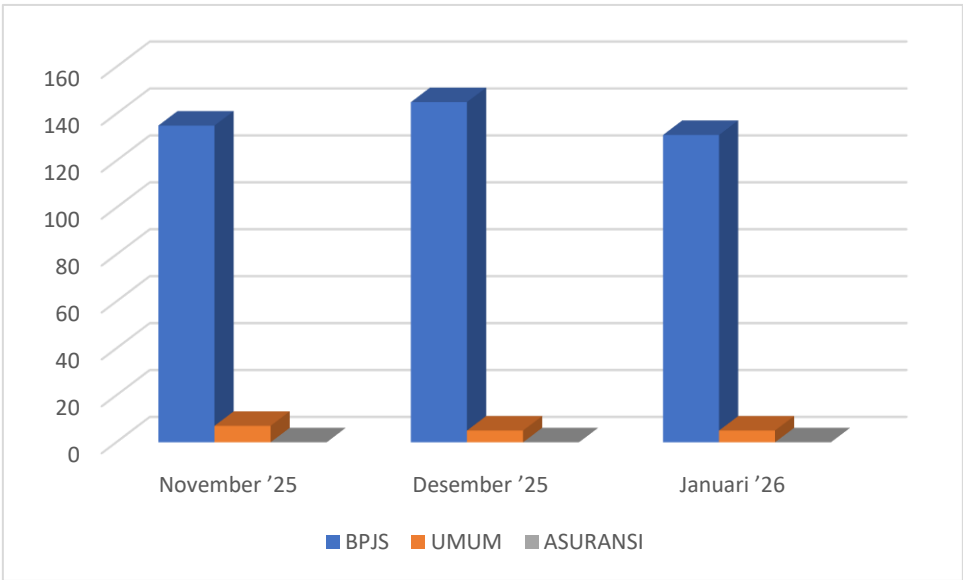
Bulan	Rawat Inap				Kesimpulan
	BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami penurunan pada bulan Januari 2026 yaitu sebanyak 30 pasien	Pasien Umum mengalami peningkatan pada bulan Januari 2026 yaitu sebanyak 4 pasien	Pasien JKK mengalami penurunan pada bulan Januari 2026 yaitu sebanyak 1	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan 100% pada bulan Januari 2026	Penurunan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan Januari dengan jumlah pasien sebanyak 24 pasien
RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)

NO	HAL	November '25	Desember '25	Januari '26	Persentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	135	145	131	9,6%
2	UMUM	7	5	5	0%
3	ASURANSI	0	0	0	0%
Total Pasien		163	143	150	137

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

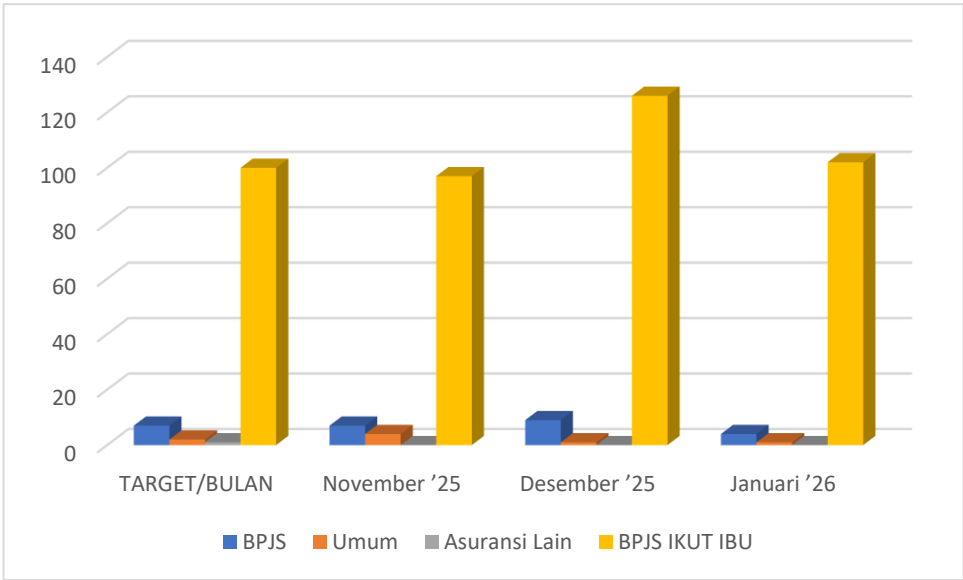
No	Bulan	RAWAT INAP			Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR/Asuransi	
	Analisis capaian Bulan November - Januari	Pasien BPJS pada bulan Januari mengalami Penurunan 9,6%	Pasien umum pada bulan Januari Sama dengan bulan sebelumnya	Tidak ada Pasien Asuransi pada bulan Januari	Kunjungan naik dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)

NO	HAL	TARGET/BULAN	November '25	Desember '25	Januari '26	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	7	9	4	↓0,03%
2	Umum	2	4	1	1	↑0,2%
3	Asuransi Lain	1	0	0	0	0
4	BPJS IKUT IBU	100	97	126	102	↓2,68%
Total Pasien		110	108	136	107	↓21,32%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

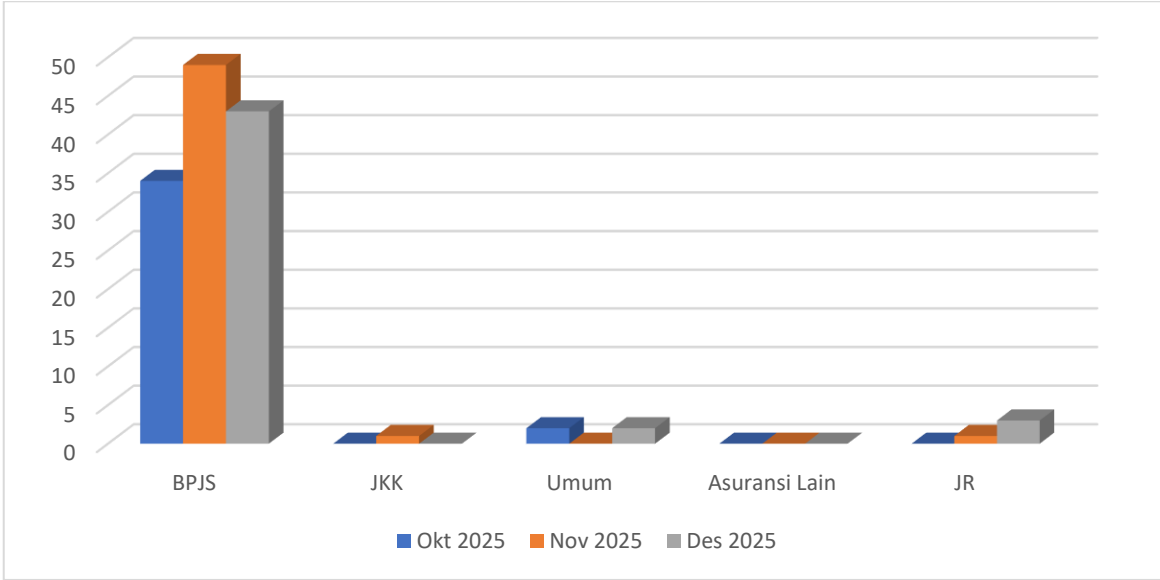
No	Bulan	Rawat Inap				Total Pasien
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	
1	Januari 2026	4	1	0	102	107
	Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,03%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,2%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 2,68%	Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,03%	
	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)

NO	PENJAMIN	November '25	Desember '25	Januari '26	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	34	49	43	↓0,12%
2	JKK	0	1	0	↓100%
3	Umum	2	0	2	↑100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	1	3	↑2%
Total Pasien		36	51	48	↓0,05%

3.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

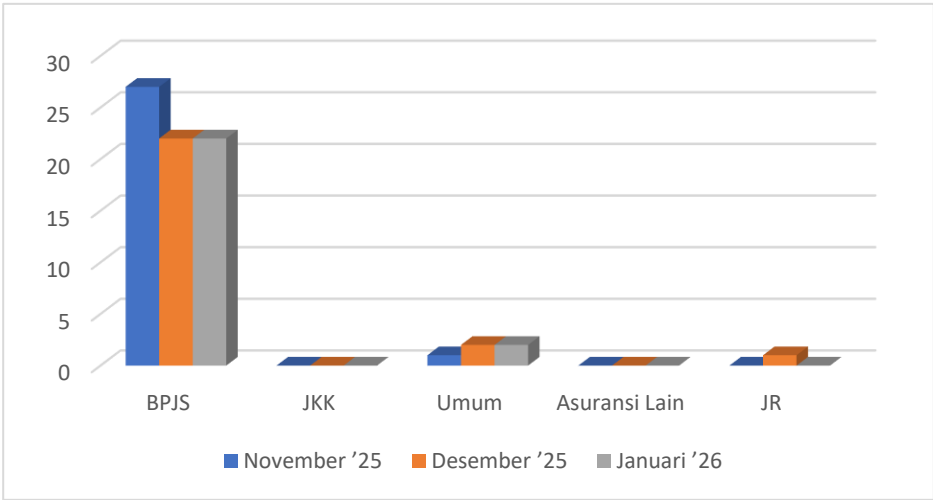
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Desember 2025 mengalami penurunan 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan 100% bulan Desember dibandingkan dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir ada 1 di bulan Desember	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil , mengalami peningkatan 2% di Bulan januari 2025. Tidak ada pasien penjamin asuransi lain selama 3 bulan terakhir	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami penurunan sebesar 0,05% dibandingkan dari bulan sebelumnya karena pasien yang perawatan di ruang ICU adalah sebagian pasien jantung
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)

NO	HAL	November '25	Desember '25	Januari '26	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	27	22	22	Tetap
2	JKK	0	0	0	Tetap
3	Umum	1	2	2	Tetap
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	1	0	↓100%
Total Pasien		28	25	24	↓0,04%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan januari 2026 sama bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 tetap sama 2 pasien dibandingkan bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan terakhir	Tidak ada Pasien JR/ Asuransi bulan januari 2025	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada menurun dari bulan sebelumnya 0,10%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HCU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

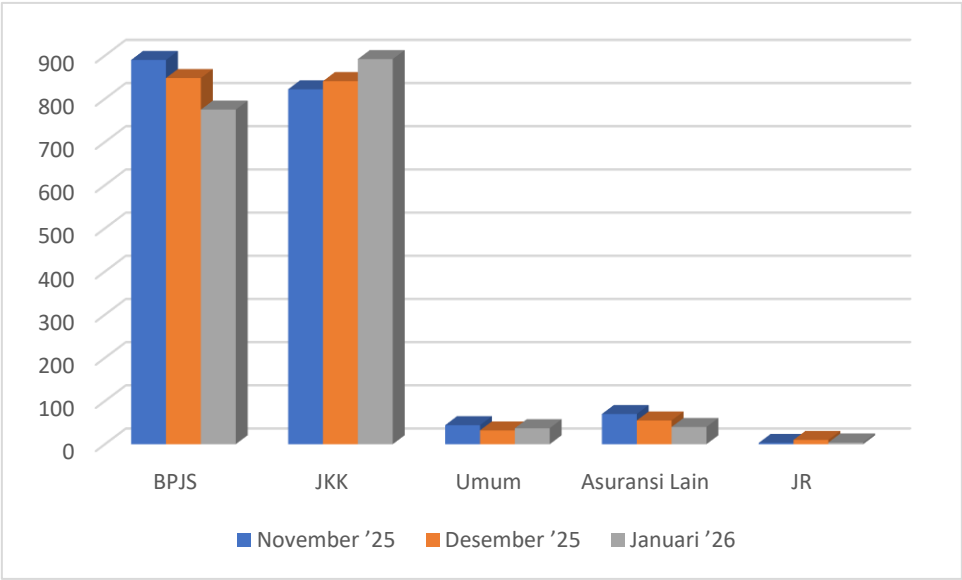
NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan januari 2026 sama bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 tetap sama 2 pasien dibandingkan bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan terakhir	Tidak ada Pasien JR/ Asuransi bulan januari 2025	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada menurun dari bulan sebelumnya 0,10%
2	RTL	5. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 6. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HCU 7. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 8. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)

NO	HAL	November '25	Desember '25	Januari '26	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	890	848	775	↓8,6 %
2	JKK	822	841	892	↑ 6 %
3	Umum	44	32	37	↑13,5 %
4	Asuransi Lain	70	55	40	↓ 27,2%
5	JR	3	10	4	↓25%
Total Pasien		1805	1.786	1.748	↓0,11 %

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2025 – Januari 2026)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

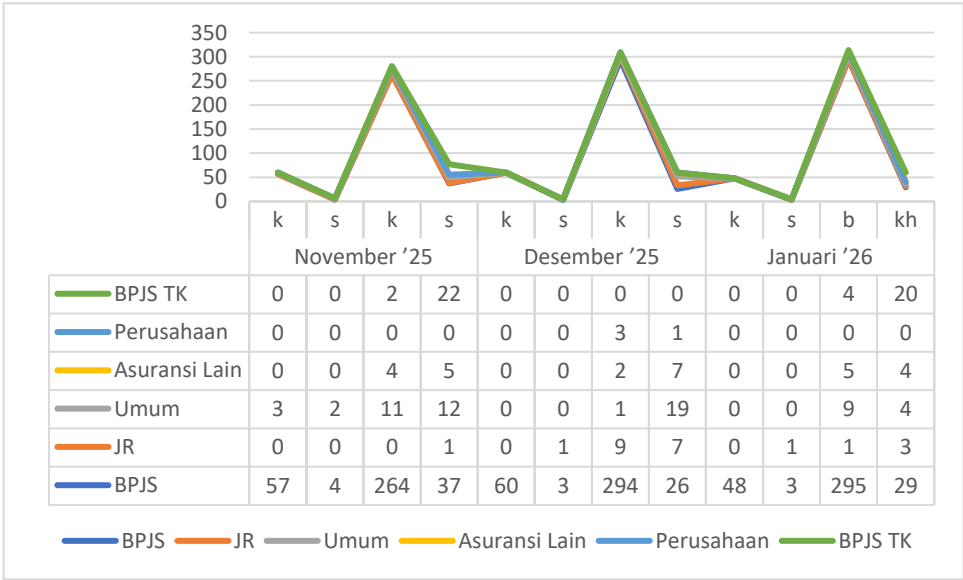
No	BULAN	INSTALASI GAWAT DARURAT					
1	Januari	BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	JR	TOTAL PASIEN
	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari bulan Desember mengalami penurunan 8,6%	Kunjungan pasien UMUM dari bulan Desember mengalami peningkatan 6%	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK mengalami peningkatan sebanyak 13,5% dari bulan Desember 2025	Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain mengalami penurunan 27,2% dari bulan Desember 2025	Kunjungan pasien dengan jaminan JR mengalami penurunan 25%	Total kunjungan pasien IGD semua jaminan dari bulan November ke Desember mengalami peningkatan ↑6,8 %
	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (November 2025 – Januari 2026)

NO	HAL	November '25				Desember '25				Januari '26			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	57	4	264	37	60	3	294	26	48	3	295	29
2	JR	0	0	0	1	0	1	9	7	0	1	1	3
3	Umum	3	2	11	12	0	0	1	19	0	0	9	4
4	Asuransi Lain	0	0	4	5	0	0	2	7	0	0	5	4
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
6	BPJS TK	0	0	2	22	0	0	0	0	0	0	4	20
Total Pasien		424				433				426			

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (November 2025 – Januari 2026)



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	BULAN	Instalasi Kamar Operasi			
1	januari	Kecil	Sedang	Besar	Khusus
	Analisis	Jumlah pasien ODC Pacho masih sedikit karena baru awal tahun.	Pasien Iridectomy tetap	Berdasarkan grafik di atas pasien dengan kategori besar selalu mendapatkan urutan terbanyak, hal ini dikarenakan jumlah operasi kecil dibatasi dan jumlah operasi khusus jenisnya lebih sedikit juga	Jumlah pasien jkk meningkat
	RTL	Tingkatkan capaian dengan mengawal pasien-pasien yang diobati dulu.	Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan	Memilah pasien-pasien di IGD yang benar-benar bisa dilakukan tindakan di sini agar	Pertahankan capaian dengan memberikan pelayanan kepada pasien agar pasien-

			di IKO RSPHM	dikerjakan di sini dan tidak dirujuk	pasien kecelakaan kerja tetap dibawa ke RSPHM.
--	--	--	--------------	--------------------------------------	--

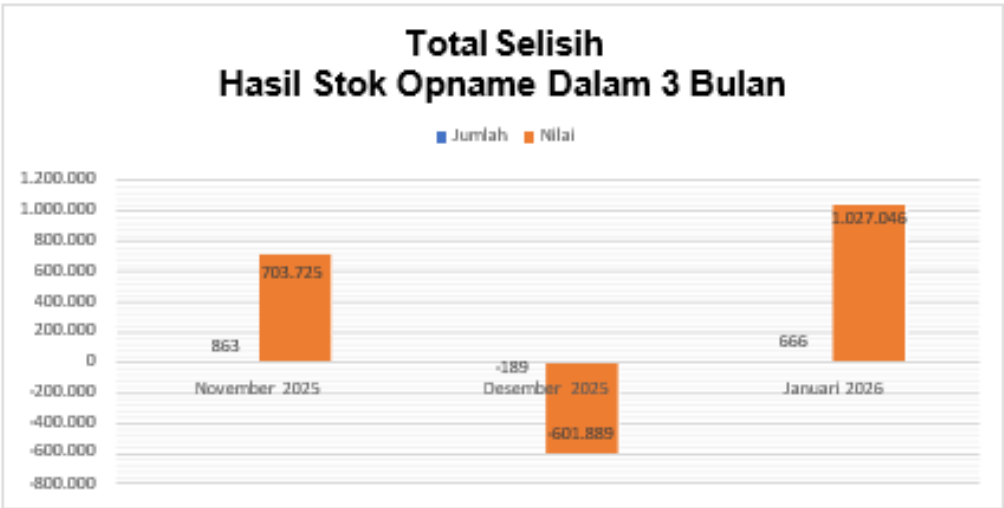
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi November 2025 – Januari 2026

Unit	Stok	November 2025		Desember 2025		Januari 2026	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
GUDANG	Fisik	837.290	1.658.488.290	1.078.515	2.192.546.257	1.014.860	1.930.830.190,08
	Sistem	837.289	1.658.452.110	1.078.515	2.192.546.257	1.014.860	1.930.830.190,08
	Selisih	+1	+36.180	0	0	0	0
DEPO FARMASI	Fisik	242.459	632.482.479	257.928	681.939.991	219.843	615.516.368,57
	Sistem	241.597	631.814.934	258.117	682.541.880	219.177	614.489.323
	Selisih	+862	+667.545	-189	-601.889	666	1.027.045,57
IKO	Fisik	2.640	89.254.399	2.686	85.715.895	3.431	87.123.387,25
	Sistem	2.640	89.254.399	2.686	85.715.895	3.431	87.123.387,25
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		+863	+703.725	-189	-601.889	666	+1.027.046

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi November 2025 – Januari 2026



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

No	Analisis	Rencana Tindak Lanjut
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :		
1	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan	Supervisi secara berkala
Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp +1.027.046 , hal ini disebabkan karena :		

1	Ketidaksesuaian saat proses double check oleh Petugas Input, Siap, Etiket, dan Penyerah terkait ketepatan obat dan jumlah obat sebelum di serahkan pada perawat atau pasien.	1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan. 2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
---	--	--

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan Januari – Juli 2026)

1. Depo Farmasi

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Jan 25 – Jan 26 (Depo+IKO)
							Nov 25	Des 25	Jan 26		
1.	F00893	Aquacel silver 10cmx10cm (420676) - convatec	Pcs	173.528	30/01/2026	4a03853	0	2	2	347.056	2
2.	F01395	Foley cath silicon no 12 - rusch	Pcs	77.000	28/02/2026	kme21c0415	8	6	5	385.000	0
3.	F00395	Isoniazid tab 300 mg (hibah) - kimia farma	Tab	0	28/02/2026	B40360N	24	43	193	0	203
4.	F00115	Cairan inf kaen mg3 500 ml - otsuka	Flash	13.656	30/03/2026	G87C54A	25	5	5	68.280	48
5.	F00450	Lixiana tab 30 mg - kalbe	Tab	25.000	30/03/2026	353698	75	75	73	1.825.000	0
6.	F00517	Neostigmine inj 0.5 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/03/2026	E23C0063A	6	6	6	65.406	12
7.	F00807	Vaksin synflorix 0,5 ml - gsk	Vial	616.801	30/04/2026	ASPNB362AF	1	1	1	616.801	3
8.	F00292	Ethambutol tab 400 mg (hibah)	Tab	0	30/05/2026	SL515	-	-	65	0	70
9.	F00378	Icunes inj 100 mcg 2 ml - novell	Vial	382.500	30/05/2026	260533	2	1	1	382.500	8
10.	F01314	Delta dry 10cmx2.4m - bsn	Pcs	140.400	30/06/2026	006	4	4	4	561.600	0
11.	F04921	Forixtra injeksi - kalbe	Syr	156.250	30/06/2026	AI250004	6	9	9	1.406.250	74
12.	F00527	Nimotop tab 30 mg - bayer	Tab	4.110	30/06/2026	CM24874	78	62	54	221.940	224
13.	F00812	Vaksin vaxigrip tetra - sanofi	Vial	149.625	30/06/2026	5dfn0d3	3	1	2	299.250	149
14.	F00606	Phenobarbital inj 50 mg/ml - phapros	Amp	1.5 32	30/07/2026	76803001	26	26	25	38.300	16
15.	F00628	Prednison tab 5 mg - triman	Tab	86	30/07/2026	H24080	0	802	6 72	57.516	3663
16.	F05100	Puspalin tab 500 mg - dipa pharmalab	Tab	2.000	30/07/2026	UX4A194	-	202	3 10	620.000	919
Sub Total Depo Farmasi										6.894.898	

2. Gudang Farmasi

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expi red	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga
							Nov 25	Des 25	Jan 26	
1.	F00395	Isoniazid tab 300 mg (hibah) - kimia farma	Tab	0	28/02/2026	P40360N	1.190	1.090	790	0
2.	F01372	Feeding tube fr no 3.5 - terumo	Pcs	19.250	30/04/2026	230520B	17	17	17	327.250

3.	F00517	Neostigmine inj 0.5 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/04/2026	E24D0116A	10	10	10	109.010
4.	F00292	Ethambutol tab 400 mg (hibah)	Tab	0	30/05/2026	SL515	308	308	112	0
5.	F00968	Benang t-vio 2-0 v9 - triton	Pcs	83.000	30/06/2026	230701BV	0	0	33	2.739.000
6.	F00672	Rifampicin tab 450 mg (hibah)	Tab	0	30/06/2026	TSG75153	1.370	1.370	1.170	0
7.	F00806	Vaksin rotateq - gsk	Vial	245.395	30/07/2026	z007996	9	9	9	2.208.5 55
8.	F05100	Puspalin tab 500 mg - dipa pharmlab	Tab	2.0 00	30/07/2026	UX4A194	-	360	570	1.140.000
9.	F00696	Sanprima forte kaps - sanbe	Tab	2.1 00	30/07/2026	CG2905	300	300	300	630.000
Sub Total Gudang Farmasi										7.153.815

3. IKO

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expi red	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga
							Nov 25	Des 25	Jan 26	
1.	F01382	Foley cath 3 way no 20 - rusch	Pcs	66.150	30/03/2026	183430	10	10	10	661.500
2.	F00517	Neostigmine inj 0.5 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/04/2026	E23D0069A	4	4	4	43.604
3.	F01389	Foley cath no 18 - rusch	Pcs	19.250	30/07/2026	T21H05	4	5	5	96.250
Sub Total IKO										801.534
Grand Total										14.850.067

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Januari - Juli 2026)

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Januari 2026 - Juli 2026 karena obat dan alkes slow moving: 1. Aquacel silver 10cmx10cm (420676) - convatec untuk mencegah pembentukan kembali biofilm pada dasar luka, diperlukan perlindungan antimikroba yang efektif dan tahan lama. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/12/2025 dari distributor sejumlah 2 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 2. Foley cath silicon no 12 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari distributor sejumlah 20 pcs. 3. Isoniazid tab 300 mg (hibah) - kimia farma untuk terapi tuberculosis. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 24/05/2025 sejumlah 300 tablet. 4. Cairan inf kaen mg3 500 ml – otsuka digunakan untuk membantu pengobatan ketidakseimbangan karbohidrat dan elektrolit pada keadaan insufisiensi asupan makanan per oral, prosedur pembedahan, neonatologi, dan asidosis diabetikum. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 13/01/2025 dari distributor sejumlah 20 flash. 5. Lixiana tab 30 mg – kalbe untuk gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah, penyumbatan pada paru-paru, serta mencegah stroke. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/09/2021 dari distributor sejumlah 84 tablet. 6. Neostigmine inj 0.5 mg/ml - ethica meringankan gejala myasthenia gravis, ileus paralitik, atau retensi urine pascaoperasi, serta menghilangkan efek obat bius pascaoperasi. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/11/2024 dari distributor sejumlah 10 amp. 7. Vaksin synflorix 0.5 ml – gsk mencegah infeksi pneumokokal. Vaksin sudah di bayar lunas oleh pasien namun belum disuntikkan. Faktur pembelian terakhir tanggal 03/07/2025 dari distributor sejumlah 1 vial. 8. Ethambutol tab 400 mg (hibah) untuk terapi tuberculosis. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 27/09/2025 sejumlah 308 tablet. 9. Icunes inj 100 mcg 2 ml – novell sebagai obat penenang dengan analgesik untuk penggunaan ICU dan sedasi pembedahan. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 13/10/2024 dari distributor sejumlah 5 vial. 10. Delta dry 10cmx2.4m – bsn sebagai bantalan pelindung bagi anggota tubuh yang akan digips dan membantu proses pengeringan pada pengaplikasian gips. Penggunaan alkes death moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 03/03/2023 dari distributor sejumlah 3 pcs.	1. Sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan near ED dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ bmhp/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS. 6. Floorstok IKO yang slow moving di tukar dengan ED jauh.

11. Forixtra injeksi – kalbe pencegahan Deep Vein Thrombosis (DVT). Faktur pembelian terakhir tanggal 02/12/2025 dari distributor sejumlah 9 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 12. Nimotop tab 30 mg – bayer untuk pencegahan dan terapi defisit Neurologik Iskhemik yang disebabkan vasospasme serebral yang terjadi setelah pendarahan subaraknoid akibat Aneurisma. Faktur pembelian terakhir tanggal 08/06/2025 dari distributor sejumlah 100 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 13. Vaksin vaxigrip tetra – Sanofi untuk mencegah penyakit Influenza yang disebabkan oleh 4 tipe virus influenza yaitu 2 tipe A dan 2 tipe B yang sangat mudah menular melalui air liur. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari RS PHS pada tanggal 30/01/2026 sebanyak 2 vial. 14. Phenobarbital inj 50 mg/ml – phapros untuk sedasi, status epilepticus. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 06/03/2025 dari distributor sejumlah 30 ampul. 15. Prednison tab 5 mg – triman untuk artritis reumatoid, asma bronkhial, lupus eritematosus sistemik, demam reumatik yang berhubungan dengan karditis. Faktur pembelian terakhir tanggal 17/07/2025 dari distributor sejumlah 1000 tablet. 16. Puspalin tab 500 mg - dipa pharmlab untuk kehilangan kesadaran karena kerusakan otak, cedera kepala atau bedah otak & infark serebri. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/01/2026 dari distributor sejumlah 600 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 17. Feeding tube fr no 3.5 – terumo digunakan untuk mengatasi masalah pemberian nutrisi atau makanan pada pasien yang mengalami kesulitan menelan ataupun pada pasien yang sedang dalam keadaan tidak sadar atau koma. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/03/2025 dari distributor sejumlah 20 pcs. 18. Benang t-vio 2-0 v9 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/03/2023 dari distributor sejumlah 48 pcs. 19. Rifampicin tab 450 mg (hibah) untuk terapi tuberculosis. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 07/02/2026 sejumlah 112 tablet. 20. Vaksin rotateq – gsk Mencegah infeksi saluran cerna akibat 5 strain Rotavirus (Pentavalen) yang menular lewat makanan terkontaminasi. Faktur pembelian terakhir tanggal 12/09/2025 dari distributor sejumlah 10 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 21. Sanprima forte kaps – sanbe nfeksi saluran kemih (UTI); Bronkitis akut/menahun; Otitis media; Shigellosis, gastroenteritis; Infeksi saluran empedu; Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) terapi & profilaksis; Infeksi kulit & jaringan lunak. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 29/11/2022 dari distributor sejumlah 400 tablet. 22. Foley cath 3 way no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/06/2024 dari distributor sejumlah 20 pcs. 23. Foley cath no 18 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/04/2025 dari distributor sejumlah 10 pcs.	
--	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah Tenaga Vokasi Farmasi/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

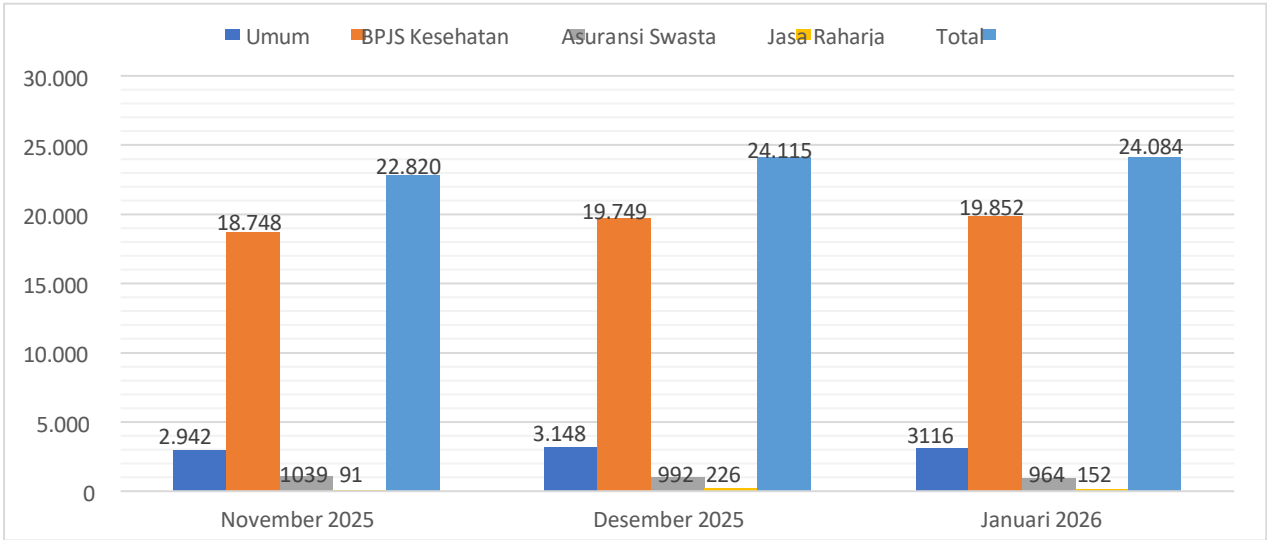
4	IFRS	Apoteker/ Tenaga	Pasien	Klinis	Obat tidak dिलengkapi <i>expired date/</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO	Meninjau ulang kemampuan
5	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
9	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

10	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
----	------	--	--------	--------	------------------------------------	--------------------------	---	---------	----------------------	-------	--------------------------	----------------------	---	--	--

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Januari 2026

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	14	209	0	0	0	223
	Jumlah Resep Obat Jadi	367	7290	0	351	71	8079
	Jumlah Resep Obat	381	7499	0	351	71	8302
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	86	23	0	0	0	109
	Jumlah Resep Obat Jadi	1251	2318	1	174	49	3793
	Jumlah Resep Obat	1337	2341	1	174	49	3902
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	295	1602	0	0	0	1897
	Jumlah Resep Obat Jadi	1071	7337	0	348	4	8760
	Jumlah Resep Obat	1366	8939	0	348	4	10.657
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	32	1073	0	90	28	1223
	Jumlah Resep Obat	32	1073	0	90	28	1223
TOTAL		3116	19.852	1	963	152	24.084

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Januari 2026



Analisis :

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan Januari 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, dengan total resep yaitu : bulan Desember 2025 sebanyak 3.148 resep umum dan bulan Januari 2026 sebanyak 3.116 resep umum.
2. Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan Januari 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, dengan total resep yaitu : bulan Desember 2025 sebanyak 19.749 resep BPJS Kesehatan dan bulan Januari 2026 sebanyak 19.852 resep BPJS Kesehatan.
3. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan Januari 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025 dengan total resep yaitu : bulan Desember 2025 sebanyak 1.218 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan Januari 2026 sebanyak 1.116 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja.
4. Secara keseluruhan total resep pada bulan Januari 2026 mengalami penurunan :
 - Adanya pembatasan kunjungan pasien per poli untuk pasien rawat jalan,
 - Adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil di poli,
 - Retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien di poli,
 - Kurangnya promo tarif vaksin di poli,
 - Kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain,
 - DPJP tidak praktek karena libur,
 - Adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat untuk pasien rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
3. Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
4. Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
6. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
7. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2025 – Januari 2026

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Nov 25	Des 25	Jan 26	
1	Pengkajian resep	100%	99,18%	99.37%	98,95%	Jumlah pengkajian resep yaitu November 2025 = 22.820 Desember 2025 = 24.115 Januari 2026 = 24.084 Jumlah ketidاكلengkapan penulisan resep yaitu November 2025 = 188 Desember 2025 = 151 Januari 2026 = 254
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.

4	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	1	Terdapat kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Tidak ada visite ronde besar
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.
10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	16	27	29	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

Analisa :

1. Pengkajian resep :

Penulisan resep yang lengkap bulan Januari 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Desember 2025 sebanyak 99,37% dan bulan Januari 2026 sebanyak 98,95%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep :

- Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS.
- Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 254 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi.
- Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.

2. Dispensing Sediaan Steril

- Staf yang melakukan dispensing sediaan obat steril non sitostatika terlatih dan kompeten. Apoteker yang memiliki sertifikat pelatihan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik tersertifikasi kemenkes yaitu 1 orang. Sedangkan Apoteker, TTK, bidan, dan perawat sudah memiliki sertifikat pelatihan dispensing sediaan obat steril non sitostatika di pelatihan internal.
- Tersedia bukti hasil pemantauan suhu, kelembaban, tekanan ruang, pemeliharaan LAF. Fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan.
- Kebersihan ruangan dispensing sediaan obat non steril dan obat steril selalu terjaga. Petugas melakukan desinfeksi sebelum melakukan dispensing obat non steril dan obat steril. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl. Tata letak ruang sudah di sekat dimana terdapat ruang persiapan dan ruang ganti APD, ruang antara, dan ruang steril (ada alat UV ruangan, pass box, LAF).

- Pencampuran obat IV dilakukan di LAF dengan dilengkapi APD sesuai ketentuan setiap pukul 13.00 WIB, untuk resep obat injeksi sore dan malam. Tidak ditemukan keterlambatan pengiriman obat ke ruangan.
- 3. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
Tersedia bukti pelaksanaan Pemantauan Terapi Obat dan sudah terisi lengkap oleh apoteker sesuai kriteria PTO.
- 4. Kejadian Efek Samping Obat
 - Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Januari 2026 ditemukan terjadinya efek samping obat yaitu Nospirinal tab pasien mengeluhkan gatal, sesak, bengkak.
 - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.
- 5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga
 - Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi.
 - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.
- 6. Konseling
Pelaksanaan konseling sudah dilakukan pada pasien di rawat jalan dan/ataupun rawat inap yang mendapatkan terapi polifarmasi dan penyakit kronis. Apoteker memanggil pasien, identifikasi, menyerahkan obat dan edukasi. Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
- 7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak dilakukan di RS.
- 8. Visite Ronde Besar
Visite ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta professional kesehatan lainnya tidak pernah dilakukan, hal ini disebabkan waktu visite DPJP dan tenaga kesehatan lainnya tidak secara bersamaan.
- 9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik
Visite dilakukan kepada setiap pasien rawat inap di RS dan di dokumentasikan di rekam medis pasien. Visite dilakukan untuk meminimalisir terjadinya medication error dan meningkatkan keberhasilan terapi pada pasien rawat inap
- 10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
- 11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien
Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien Januari 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Desember 2025 sebanyak 22 dan bulan Januari 2026 sebanyak 29. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.

Tindak lanjut :

1. Pengkajian resep :
 - Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi.
 - Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual).

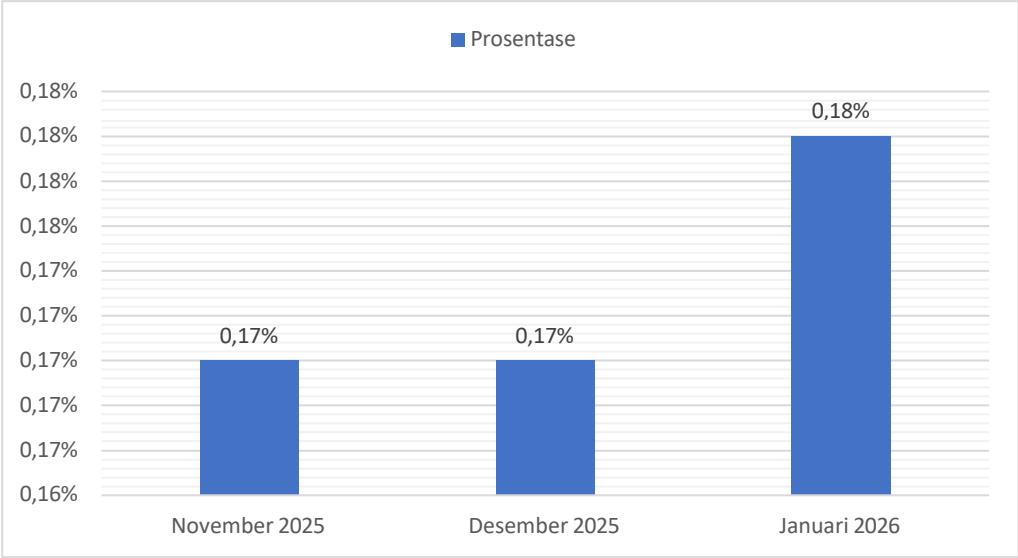
- Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.
- 2. Dispensing Sediaan Steril
 - Pelatihan penyiapan obat IV dan teknik aseptik tahun 2025 target peserta Apoteker, TTK, Perawat, Bidan di laksanakan pada tanggal 08 Desember 2025.
 - Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo farmasi, gudang farmasi, dan ruang pencampuran obat (LAF) oleh apoteker setiap hari.
 - Supervisi Kains secara berkala dan mempertahankan kinerja yang sudah berjalan dengan baik
- 3. Pemantauan Terapi Obat (PTO) : supervisi secara berkala
- 4. Kejadian Efek Samping Obat
 - Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
 - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
 - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
 - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
 - Menganalisa laporan ESO.
 - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
 - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
 - Konsul ke DPJP terkait keluhan pasien dan advice DPJP obat di stop.
- 5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
- 6. Konseling : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan konseling di rawat inap dan rawat jalan.
- 7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak dilakukan di RS.
- 8. Visite Ronde Besar
Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
- 9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan visite pasien di rawat inap.
- 10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di unit pelayanan, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
- 11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien
 - Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
 - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
 - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

1.2.1.11 **Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada November 2025 – Januari 2026**

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/11/2025-30/11/2025	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Tanpa saran substitusi
2	1/11/2025-30/11/2025	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Tanpa saran substitusi
Total prosentase November 2025 = 0.17%					
1	1/12/2025-31/12/2025	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria

2	1/12/2025-31/12/2025	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
Total prosentase Desember 2025 = 0.17%					

1.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada November 2025 – Januari 2026



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok Pramivex 0,125 mg di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Januari 2026

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	-	-	-	Tidak ada pemusnahan
2	BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	-	-	-	Tidak ada BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Januari 2026

No	Monitoring dan Evaluasi	Hasil	Tindak Lanjut
1	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP di gudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.
2	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/ hibah. Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP
3	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi. Form monitoring suhu depo farmasi dan ruang pencampuran obat : https://drive.google.com/drive/folders/1XYh_AQhMkHwhOGCJ76lK4TQ4sewn7MHR Form monitoring suhu Gudang farmasi : https://drive.google.com/drive/folders/1Afz8-tngWZOA01zotU7Ju6TrzEje6OMF	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari

4	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat dan alat kesehatan yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 1 pada Bulan Januari Tahun 2026 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu :		Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai
		No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED
		1	Box emergency poli lantai 1: 1) Atropin sulfat (2 amp) ED 9/27 2) Aspilet (5 tab) ED 7/26 3) Dobutamin (1 amp) ED 11/26 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 5) Epinephrine (4 amp) ED 3/27 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 11/26	1) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 2) Aspilet (5 tab) ED 8/27 3) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 4) Dopamin (1 amp) ED 7/27 5) Epinephrine (4 amp) ED 9/28 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27
			7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 8) Infus Gelafusal (1 buah) ED 7/26 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 10) Natrium phenytoin (1 amp) ED 11/25 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 7/28 12) Iv Cannul (1 buah) ED 06/28	7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 8) Infus Gelafusal (1 buah) ED 6/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27 10) Natrium phenytoin (1 amp) ED 10/27 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 06/30 12) Iv Cannul (1 buah) ED 01/30
		2	Box emergency poli treadmill: 1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Dexamethasone inj (1 amp) ED 10/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27	1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Dexamethasone inj (1 amp) ED 10/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27
		3	Box emergency poli lantai 2: 1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Amiodarone inj (4 amp) ED 01/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28	1) Nospirinal (5 tab) ED 8/27 2) Amiodarone inj (4 amp) ED 01/27 3) Atropin sulfat (2 amp) ED 3/28
				dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan. d. Tidak ada obat near ED < 6 bulan.

			4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27	4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Dobutamin (1 amp) ED 7/29 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 9/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 9/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 11/27	
		4	Box emergency poli vaksin: 1) Atropin sulfat (2 amp) ED 9/27 -> 3/28 2) Aspilet (5 tab) ED 7/26 -> 8/27 3) Amiodaron 3ml (4 amp) ED 08/26 -> 06/27 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Infus asering (1 buah) ED 9/27	1) Atropin sulfat (2 amp) ED 9/27 -> 3/28 2) Aspilet (5 tab) ED 7/26 -> 8/27 3) Amiodaron 3ml (4 amp) ED 08/26 -> 06/27 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Infus asering (1 buah) ED 9/27 6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 11/26 -> 9/27	
			6) Furosemid 2ml (2 amp) ED 11/26 -> 9/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 -> 9/27 8) Infus NS 0.9% (1 buah) ED 7/26 -> 7/28 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 -> 11/27 10) Infus Kaen 3B (1 amp) ED 07/26 -> 11/27	7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 -> 9/27 8) Infus NS 0.9% (1 buah) ED 7/26 -> 7/28 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 -> 11/27 10) Infus Kaen 3B (1 amp) ED 07/26 -> 11/27	
		5	Trolley emergency IGD: 1) Iv Cannul 20 (1 amp) ED 09/19 -> 06/29 2) Valisanbe inj (1 buah) ED 11/26 -> 11/27 3) Spuiit 10cc (1 buah) ED 06/27 -> 06/30	1) Iv Cannul 20 (1 amp) ED 09/19 -> 06/29 2) Valisanbe inj (1 buah) ED 11/26 -> 11/27 3) Spuiit 10cc (1 buah) ED 06/27 -> 06/30	
		6	Box emergency infant Ponek IGD: 1) Dexamethasone inj (1 amp) ED 6/26 -> 10/27 2) Handscoon (1 buah) ED 5/26 -> 8/26 3) WI (1 buah) ED 05/26 -> 08/27	1) Dexamethasone inj (1 amp) ED 6/26 -> 10/27 2) Handscoon (1 buah) ED 5/26 -> 8/26 3) WI (1 buah) ED 05/26 -> 08/27	
		7	Box HPP – Eklamsi IGD: 1) As. tranexamat (2 amp) ED 6/26 -> 3/28 2) Infus NS 0,9% (1 buah) ED 6/26 -> 12/27 3) WI (1 buah) ED	1) As. tranexamat (2 amp) ED 6/26 -> 3/28 2) Infus NS 0,9% (1 buah) ED 6/26 -> 12/27 3) WI (1 buah) ED 05/26	

			05/26 -> 08/27	-> 08/27	
		8	Kit emergency IGD 1: 1) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 6/26 -> 12/27 2) Norepinephrine (1 buah) ED 8/26 -> 8/27 3) Mayo putih (1 buah) ED 08/26 -> 03/28 4) Iv cannul no 22 (1 buah) ED 07/26 -> 10/30	1) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 6/26 -> 12/27 2) Norepinephrine (1 buah) ED 8/26 -> 8/27 3) Mayo putih (1 buah) ED 08/26 -> 03/28 4) Iv cannul no 22 (1 buah) ED 07/26 -> 10/30	
		9	Kit emergency IGD 2: 1) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 6/26 -> 12/27 2) Amiodaron 3ml (4 amp) ED 08/26 -> 06/27 3) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/272) 4) Norepinephrine (1 buah) ED 8/26 -> 8/27 5) MgSO4 (2 buah) ED 09/26 -> 10/27	1) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 6/26 -> 12/27 2) Amiodaron 3ml (4 amp) ED 08/26 -> 06/27 3) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/272) 4) Norepinephrine (1 buah) ED 8/26 -> 8/27 5) MgSO4 (2 buah) ED 09/26 -> 10/27	
		10	Box emergency ambulance: 1) Atropin sulfat (2 amp) ED 11/26 -> 4/27 2) Nospirinal (5 tab) ED 7/26 -> 8/27 3) Dobutamin (1 amp) ED 11/26 -> 7/29 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Epinephrine (4 amp) ED 3/27 -> 9/28 6) CPG (5 tab) ED 08/27 -> 11/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 -> 9/27 8) Dexamethasone inj (1 amp) ED 06/26 -> 10/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 -> 11/27 10) Amiodarone (1 amp) ED 6/26 -> 6/27 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 11/29 12) Iv Cannul no 22 (1 buah) ED 01/29 13) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 10/26 -> 12/27 14) lidokain (3 buah) ED 10/26 -> 10/30 15) Infuset (1 buah) ED 7/26 -> 12/27 16) Spuit 10 cc (2 buah) ED 01/29 -> 06/30 15) Spuit 5 cc (2 buah) ED 12/27 -> 10/29	1) Atropin sulfat (2 amp) ED 11/26 -> 4/27 2) Nospirinal (5 tab) ED 7/26 -> 8/27 3) Dobutamin (1 amp) ED 11/26 -> 7/29 4) Dopamin (1 amp) ED 9/26 -> 7/27 5) Epinephrine (4 amp) ED 3/27 -> 9/28 6) CPG (5 tab) ED 08/27 -> 11/27 7) Infus D5%t (1 buah) ED 11/26 -> 9/27 8) Dexamethasone inj (1 amp) ED 06/26 -> 10/27 9) Valisanbe 2ml (1 amp) ED 7/26 -> 11/27 10) Amiodarone (1 amp) ED 6/26 -> 6/27 11) Iv cannul no 20 (1 buah) ED 11/29 12) Iv Cannul no 22 (1 buah) ED 01/29 13) Infus NS 0,9% (2 buah) ED 10/26 -> 12/27 14) lidokain (3 buah) ED 10/26 -> 10/30 15) Infuset (1 buah) ED 7/26 -> 12/27 16) Spuit 10 cc (2 buah) ED 01/29 -> 06/30 15) Spuit 5 cc (2 buah) ED 12/27 -> 10/29	

			17) Spuit 3 cc (2 buah) ED 12/27 -> 04/30 18) Spuit 1 cc (2 buah) ED 11/27 -> 1/30	17) Spuit 3 cc (2 buah) ED 12/27 -> 04/30 18) Spuit 1 cc (2 buah) ED 11/27 -> 1/30	
		11	Trolley emergency IKO: Tidak ada near ED	-	
		12	Box emergency infant IKO: Tidak ada near ED	-	
		13	Box HPP-Eklamsi IKO: As. Tranexamat (3/26), Misoprostol (11/25), Kondom (3/26), Cairan WFI (5/26), Calcii gluconas (4/26), MgSO4 20 % (6/25), MgSO4 40% (5/25), Jarum no. 23 (8/26)	As. Tranexamat (10/26), Misoprostol (3/26), Kondom (12/26), Cairan WFI (9/26), Calcii gluconas (3/27), MgSO4 20 % (9/26), MgSO4 40% (11/26), Jarum no. 23 (11/27)	
		14	Box emergency 2C:		
			Amiodarone (9/25) dexametasone (5/25), Dopamine (9/25), valisanbe (3/25), Infus D5% (7/25) Infus gelafusal (6/25)	Amiodarone (6/26), Dexametasone (6/26), Dopamine (9/26), valisanbe (6/26), Infus D5% (11/26), Infus gelafusal (4/27)	
		15	Box emergency ICU: Amiodarone (11/25), Dopamine (9/25), Phenytoine (7/25), Infus D5% (7/25)	Amiodarone (5/26), Dopamine (9/26), Phenytoin (9/27), Infus D5% (11/26)	
		16	Box emergency ICU ventilator: Dexametasone (5/25), Norepinephrine (6/25).	Dexametasone (6/26), Norepinephrine (4/26).	
		17	Box emergency HCU: Amiodarone (8/25), Dopamine (9/25), Infus D5% (7/25), Spuit 1cc (8/25)	Amiodarone (6/26), Dopamine (9/26), Infus D5% (11/26), Spuit 1cc (5/29)	
		18	Box emergency 3C anak: Amiodarone (8/25), Dopamine (9/25), furosemide (9/25), infus D5 (7/25), Iv cannula no. 20 (10/25)	Amiodarone (6/26), Dopamine (2/26), furosemide (6/26), Infus D5% (11/26), Iv cannula no. 20 (6/26)	
		19	Box emergency PICU Ventilator: Tidak ada obat near ED	-	

		20	Box emergency PICU: ISDN (5/25), Ephineprine (10/25), Dexametasone (8/25), suction cath no. 8 (10/25)	ISDN (8/26), Ephineprine (8/26), Dexametasone (6/26), Suction cath no. 8 (2/28) - BE PICU Ventilator :
		21	Box emergency 2A: Tidak ada obat near ED	-
		22	Box emergency 3A: Amiodarone (9/25), Dexametasone (8/25), Dobutamine (8/25), Furosemide (9/25), Na phenytoin (7/25), Dopamine (9/25), Infus D5 (9/25), Clopidogrel (12/25)	Amiodarone (6/26), Dexametasone (6/26), Dobutamine (11/27), Furosemide (6/26), Na Phenytoin (9/27), Dopamine (2/26), Infus D5% (11/26), Clopidogrel (10/26)
		23	Box emergency 4A: Dobutamin (10/25), Dopamine (11/25), Dexametasone (6/25), Furosemide (9/25), Manitol (9/25)	Dobutamine (11/27), Dopamine (9/26), Dexametasone (6/26), Furosemide (6/26), Manitol (6/26)
		24	Box emergency infant Maternitas:	

			Tidak ada obat near ED	-	
		25	Trolley emergency Maternitas: Sput 3 cc (10/25), Blood set (8/25), Sput 20 cc (7/25), Oxyflow dewasa (10/25)	Sput 3 cc (6/29), Blood set (7/29), Sput 20 cc (10/29), Oxyflow dewasa (11/29)	
		26	Box emergency infant Perinatologi: tidak ada obat near ED	-	
		27	Box emergency 5C: Infus D5% (9/25), infus gelafusal (9/25), amiodarone (11/25), clopidogrel (11/25), dexamethasone (10/25), dopamin (4/26), ephineprine (8/25), na. phenytoin (7/25), furosemide (9/25), atropine sulfate (11/26), manitol (1/26)	Infus D5% (11/26), infus gelafusal (4/27), amiodarone (6/26), clopidogrel (10/26), dexamethasone (6/26), dopamin (9/26), ephineprine (7/27), na. phenytoin (9/27), furosemide (6/26), atropine sulfate (4/27), manitol (6/26)	
		28	Box emergency 6A: Infus D5% (7/25), Manitol (5/25), Dexametasone (6/25)	Infus D5% (11/26), Manitol (1/26), Dexametasone (6/26)	
		29	Box emergency 7A: Dexametasone (6/25), atropin sulfate (11/25), Infus D5% (8/25)	Dexametasone (6/26), Atropin sulfate (4/27), Infus D5% (11/26)	
		30	Box emergency 8A: Ephinephrine (8/25), spuit 10 cc terumo (10/25), spuit 3 cc terumo (10/25)	Ephinperine (7/27), Spuit 10 cc terumo (6/29), Spuit 3 cc terumo (6/29)	
		31	Box emergency Radiologi: Amiodaron (8/25), Aspilet (11/25), Atropin (11/26), Clopidogrel (2/26), Dexametason (10/25), Dopamine (9/25), Furosemide (9/25), Infus D5% (9/25), Manitol (1/26), Na phehytoin inj (1/26), Valisanbe Inj (12/25), IV cannula no. 22 (1/26)	Amiodarone (6/26), Aspilet (8/26), Atropin (4/27), Clopidogrel (10/26), Dexametason (6/26), Dopamine (9/26), Furosemide (6/26), Infus D5% (11/26), Manitol (6/26), Na phehytoin inj (9/27), Valisanbe Inj (6/26), IV cannula no. 22 (1/29)	
5	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.			- Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap

			menuliskan pada kartu stok - Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)
7	Penyimpanan produk steril di unit	- Ditemukan perawat menyimpan sisa infus NS 0.9% dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam

3.2.2. Laboratorium

Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

	Target	JAN 26	%				(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
HEMATOLOGI	1950	1684					
FAAL HEMOSTASIS	716	817					
HEMATOLOGI LAIN	1	2					
URINALISIS	418	272					
ANALISA FEACES	30	7					
FUNGSI HATI	611	393					
LEMAK DARAH	806	781					
GINJAL HIPERTENSI	1394	1590					
GULA DARAH	1187	2372					
JANTUNG	583	629					
ELEKTROLIT DAN BGA	334	230					
IMUNO SEROLOGI	481	216					
REMATIK	6	5					
ENDOKRINOLOGI	60	58					
REPRODUKSI	44	98					
MIKROBIOLOGI	32	63					
Jumlah	8654	9217					

Analisis :

Jumlah Pemeriksaan Pada bulan Januari mengalami Kenaikan sebanyak dari dengan 9217 pemeriksaan Laboratorium

Rencana Tindak Lanjut :

Tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke pada pasien khususnya pasien Laboratorium

1.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Januari 2026

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
1	-				

Analisis :

Tidak ditemukan sampel darah yang rusak

Rencana Tindak Lanjut :

-

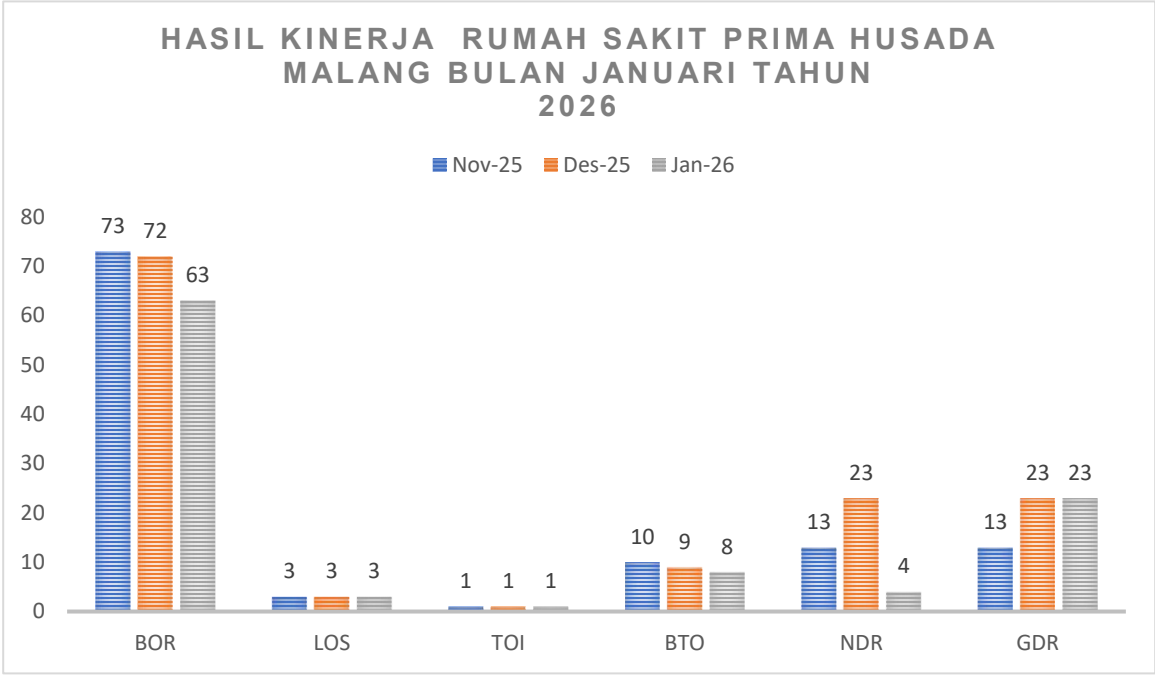
3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Januari 2026

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang													
						LT 2C	LT 2A	LT 3A	LT 3 C	LT 4ab	LT 5C	LT 6	LT 7	LT 8	MTS	NICU	HCU	ICU	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	November 25	73	40	34	72	92	59	84	71	71	74	38	47	26	73
					Desember 25	67	59	28	76	88	65	79	67	74	66	35	28	29	72
					Januari 26	60	48	18	56	66	57	66	65	65	66	16	47	32	63
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	November 25	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	5	2	2	3
					Desember 25	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	5	2	2	3
					Januari 26	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	5	4	3
3TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	November 25	1	3	3	1	0	2	1	1	1	1	6	1	4	1
					Desember 25	1	1	5	1	0	1	1	1	1	1	8	3	4	1
					Januari 26	2	3	14	2	1	2	2	1	1	1	17	6	9	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali	November 25	9	7	7	9	13	8	10	8	9	11	3	15	6	10
				(dalam hitungan bulan)	Desember 25	8	9	5	10	12	7	9	8	8	11	3	8	6	9
					Januari 26	6	5	2	8	9	7	7	8	7	10	2	3	2	8

NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ Mati} >48\text{jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25‰	November 25	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	34	260	13
					Desember 25	0	0	0	0	7	18	10	43	30	0	0	208	245	23
					Januari 26	0	0	0	0	7	9	0	0	11	0	0	0	59	4
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	November 25	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	34	260	13
					Desember 25	0	0	0	0	7	18	10	43	30	0	0	208	245	23
					Januari 26	0	33	0	0	7	27	12	21	23	7	0	500	471	23

3.1.1.1 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Januari 2026



Indikator	November	Desember	Januari
BOR (Bed Occupancy Rate)	73%	72%	63%
LOS (Length of Stay)	3 hari	3 hari	3 hari
TOI (Turn Over Interval)	1 hari	1 hari	1 hari
BTO (Bed Turn Over)	10 kali	9 hari	8 hari

1. Analisa

- A. **BOR mengalami penurunan signifikan** dari 73% (Nov) menjadi 63% (Jan).
→ Menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur menurun.
- B. **BTO menurun bertahap** dari 10 kali menjadi 8 kali.
→ Frekuensi penggunaan tiap tempat tidur semakin rendah.
- C. **LOS tetap stabil (3 hari)**
→ Lama perawatan pasien tidak berubah, pelayanan medis berjalan konsisten.
- D. **TOI tetap 1 hari**
→ Waktu kosong tempat tidur antar pasien masih efisien.
- E. LOS : stabil 3 hari

→ LOS yang stabil menunjukkan lama perawatan pasien konsisten.

→ Hal ini menunjukkan bahwa lama perawatan rata-rata pasien stabil dan tidak ada gangguan signifikan dalam alur pelayanan.
- F. TOI: tetap 1 hari

→ TOI yang konsisten menunjukkan waktu tunggu tempat tidur sebelum digunakan kembali berada pada kondisi optimal.

→ Kapasitas tempat tidur yang tersedia dapat langsung digunakan kembali tanpa jeda yang terlalu Panjang menandakan manajemen bed berjalan baik

2. Masalah
 - 1) Penurunan pendapatan rawat inap
 - 2) Utilisasi sarana dan SDM tidak optimal
 - 3) Biaya operasional per pasien meningkat
 - 4) Efisiensi layanan rumah sakit menurun
3. Tindak Lanjut
 - 1) Evaluasi kebutuhan jumlah tempat tidur bila tren berlanjut
 - 2) Pengembangan layanan spesialis dengan kebutuhan rawat inap tinggi
 - 3) Strategi pemasaran layanan rawat inap

3.1.1.2 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan November 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	Z48.0	Attention to surgical dressings and sutures	511
2.	E11.4	With neurological complications	510
3.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	353
4.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	280
5.	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	264
6.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	246
7.	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	216
8.	J47	Bronchiectasis	215
9.	Z23	Need for immunization against single bacterial diseases	204
10.	R10.4	Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain	193

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan November 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	J18.9	Pneumonia	56
2.	A09.9	Gastro Enteritis Acute	39
3.	I63.9	Cva Infark	37
4.	E11.6	Dm Hyperglikemy	35
5.	A01.0	Typhoid Fever	27
6.	N20.0	Calculus Of Kidney	23
7.	A90	Dengue Fever	20
8.	I20.0	Unstable Angina Pectoris	16
9.	M72.6	Necrotizing Fasciitis	16
10.	D24	Tumor Mammae	15

Analisis :

Diagnosa terbanyak pasien rawat inap bulan Januari 2026 adalah Pneumonia sejumlah 56 Pasien. Diagnosa tersebut diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang.

Rencana Tindak Lanjut :

-

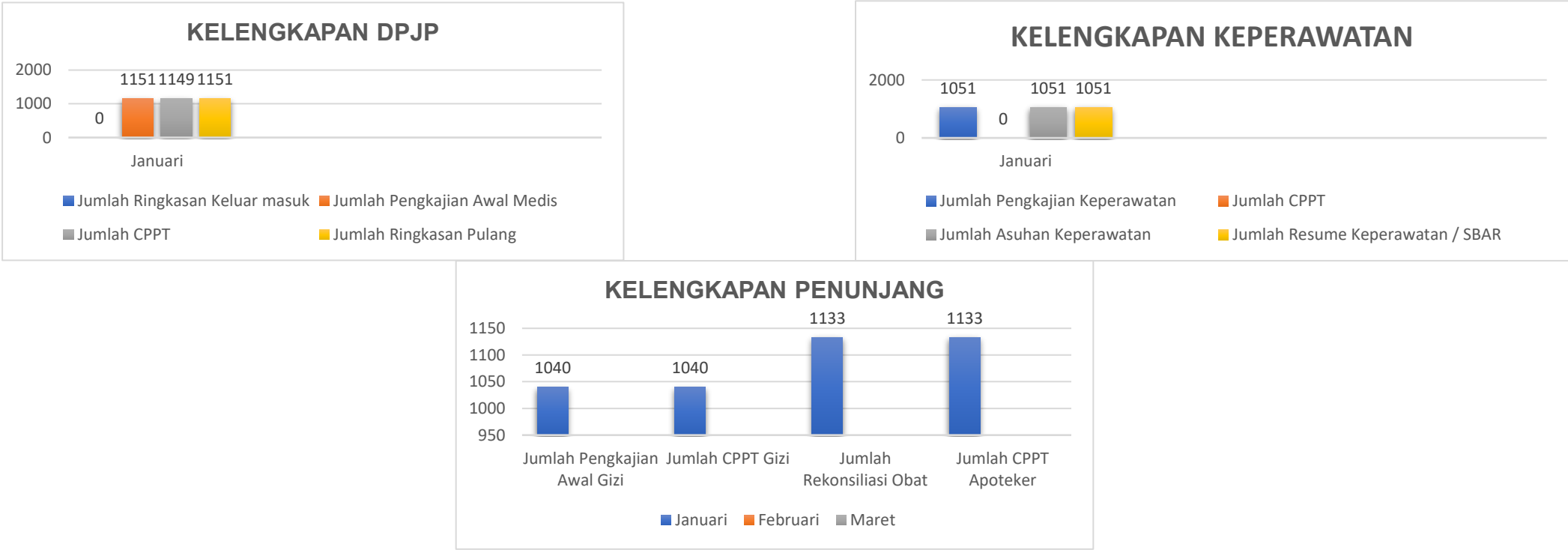
3.1.1.4 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Januari 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari																
Maret																
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR (Oktober)			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari																
Maret																
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari																
Maret																
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

3.1.1.5 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Januari 2026



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan tertinggi poli per poli : IGD dan IRJA
- 2. Kelengkapan pengkajian keperawatan 97,18% pada Bulan November 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Januari 2026.

Rencana Tindak Lanjut :

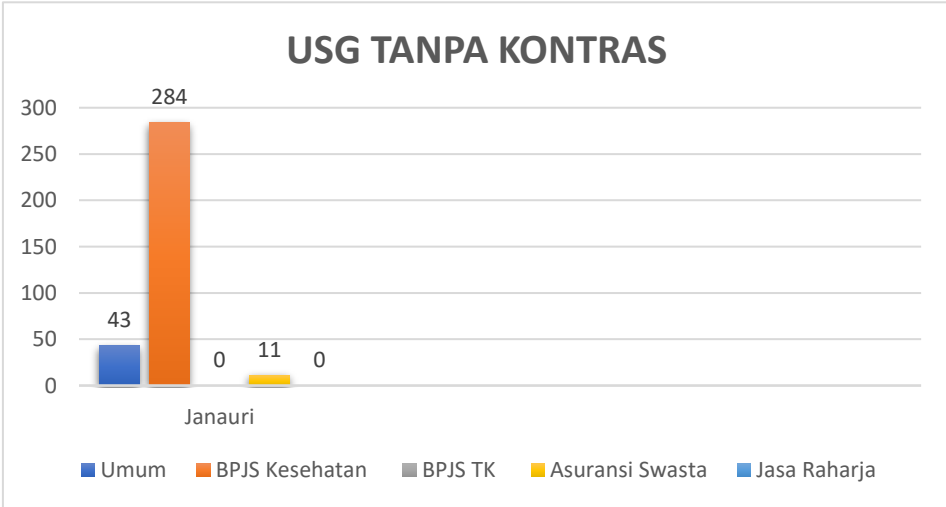
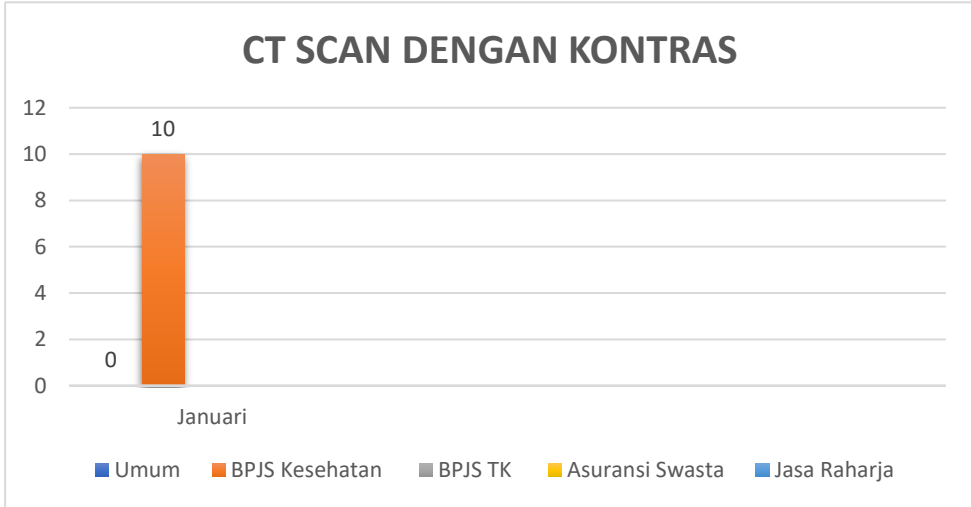
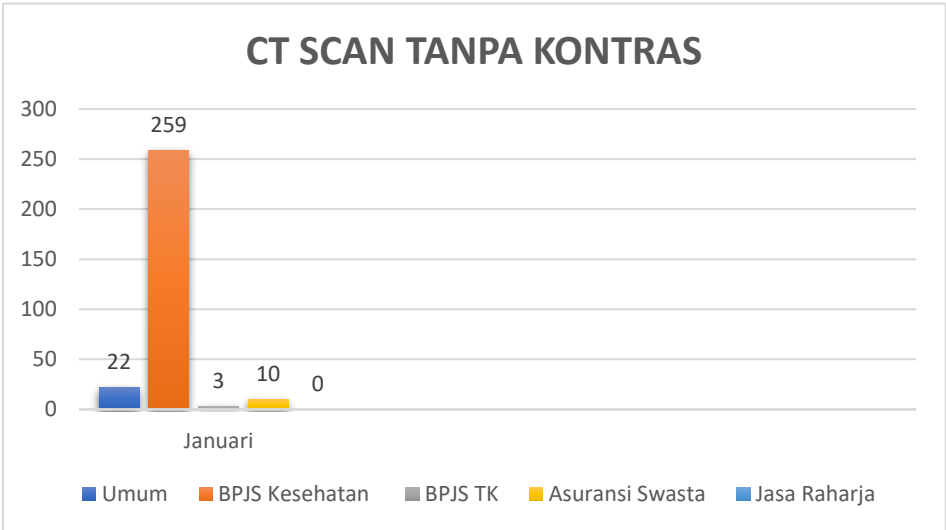
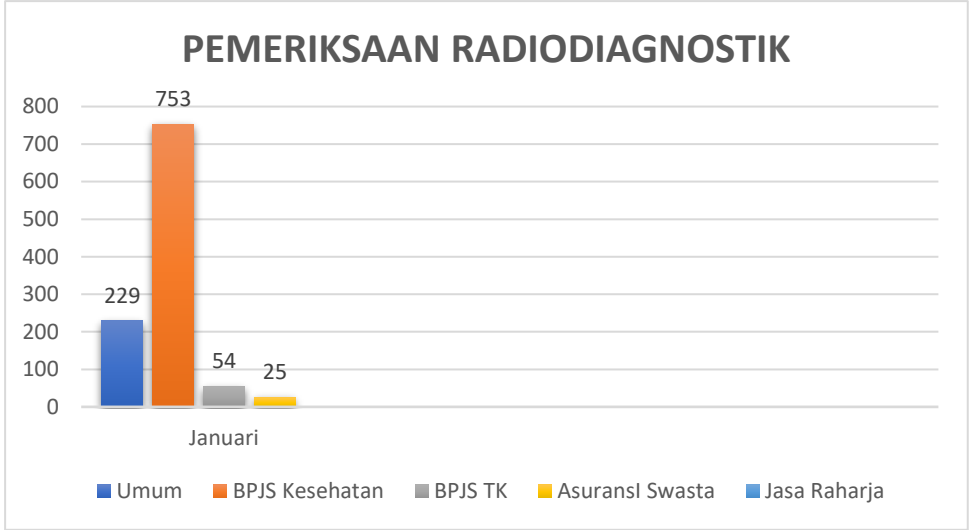
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan.

6.2.4 Radiologi

6.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Januari 2026

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			JAN		
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	229		
		BPJS KESEHATAN	753		
		BPJS TK	54		
		ASURANSI SWASTA	25		
		JASARAHARJA	13		
	TOTAL		1.074		
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	22		
		BPJS KESEHATAN	259		
		BPJS TK	3		
		ASURANSI SWASTA	10		
		JASARAHARJA	0		
	TOTAL		294		
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0		
		BPJS KESEHATAN	10		
		BPJS TK	0		
		ASURANSI SWASTA	0		
		JASARAHARJA	0		
	TOTAL		10		
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	43		
		BPJS KESEHATAN	284		
		BPJS TK	0		
		ASURANSI SWASTA	11		
		JASARAHARJA	0		
	TOTAL		338		
TOTAL KESELURUHAN					

6.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Januari 2026



Analisis :

- 1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan November 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada Bulan Januari 2026 pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - a. Radiodiagnostik : 1.074
 - b. USG Tanpa Kontras : 338
 - c. CT Scan Tanpa Kontras : 294
- 2. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Januari 2026 adalah sebanyak 1.173 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - a. Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - b. Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
 - 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
-
- 3. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

6.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Tahun 2026

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Januari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Abd Salam	Brain Atrofi Senilis	Brain Atrofi senilis, Infark	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	-	-	-	-

Analisis :

Untuk bulan Januari 2026 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak sesuai dengan kondisi pasien pada surat permintaan radiologi sehingga dokter radiolog kurang menambahkan hasil bacaan tersebut.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

6.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

1. dr.Agung Setyawan, Sp.Rad (K)

PEMERIKSAAN	RATA-RATA SELESAI PERIKSA (Menit)	RATA-RATA SELESAI PEMBACAAN (Menit)
Ro Thorax	00:03:20	00:25:00 (waktu efektif) 00:180:00 (diatas jam 12 malam)
Ro Vertabrae	-	-

Ro Abdomen	-	-
Ro Ekstremitas	-	-
Ro Skull	-	-
USG	00:08:00	00:05:00
CT Scan Non kontras	00:05:00	00:30:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)
CT Scan Kontras	00:15:00	00:25:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)
Radiologi Cito	00:10:00	00:04:00 (waktu elektif) 00:25:00 (diatas jam 12 malam)

Analisa :

- a. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen 3 menit 20 detik dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit dijam elektif. Hal ini disebabkan karna hasil rontgen dapat langsung dikonsulkan via media sosial (*whatsapp*). (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- b. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen jika waktu diluar jam efektif rata- rata hasil pemeriksaan mencapai 180 menit. Hal ini disebabkan karna hasil rontgen langsung dikonsulkan via media sosial (*whatsapp*) namun radiolog belum membalas (Tidak sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- c. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi USG 8 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 5 menit. Hal ini disebabkan karna hasil usg langsung dibaca oleh radiolog. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- d. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi CT Scan Non Kontras 5 menit dan rata- rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien ct scan dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- e. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi CT Scan Kontras 15 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien ct scan dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)

2. dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad (K)

PEMERIKSAAN	RATA-RATA SELESAI PERIKSA (Menit)	RATA-RATA SELESAI PEMBACAAN (Menit)
Ro Thorax	00:03:04	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Vertabrae	00:04:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Abdomen	00:10:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Ekstremitas	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Skull	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
USG	00:15:00	00:10.00
CT Scan Non kontras	-	-
CT Scan Kontras	-	-
Radiologi Cito	00:10:00	0:10:00

Analisa :

- a. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Thorax 3 menit 4 detik dan rata- rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- b. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Vertabrae 4 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- c. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Ekstremitas 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- d. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Abdomen 10 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- e. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi rontgen Skull 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
- f. Rata Rata waktu pemeriksan radiologi USG 15 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 10 menit. Hal ini disebabkan karna hasil usg langsung dibaca oleh radiolog. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)

- g. Semua pemeriksaan CT Scan di alihkan ke dokter Agung Setyawan, Sp.Rad berdasarkan kesepakatan antar radiolog.
- h. Terdapat pembacaan CITO selama bulan Agustus 2025 dan hasil *ekspertise* sesuai target yakni kurang dari 30 menit

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

6.2.4.5 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
			2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan.
			3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Januari 2026

No.	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026	
1.	Diabetes Mellitus	571	526	454	-13,6
2.	Rendah Garam	586	580	561	-3,2
3.	Jantung	291	308	345	12

No.	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026	
4.	Rendah Serat	434	349	237	-32
5.	TKTP	1221	1130	1092	-3,3
6.	Makanan Biasa	33	38	19	1,3
7.	Diet Alergi	5	6	0	-1
8.	Rendah Lemak	352	329	312	-5,1
9.	Rendah Protein	207	286	232	-18,8
10.	Bubur Halus	160	209	143	-31,5
11.	Cair	106	106	117	10,3
12.	Rendah Purin	175	177	197	11,2
13.	Tinggi Protein	63	42	36	-14,2
14.	Blender	23	33	23	-30,3
15.	Tinggi Serat	5	0	0	0
16.	Tinggi Kalium	15	64	59	-7,8
17.	Rendah Kalium	27	22	7	-68,1
18.	Rendah Sisa	16	3	4	33,3
Jumlah		4290	4208	3838	-8,7

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Januari 2026



Analisis :

Jumlah pesanan diet pasien rawat inap menurun seiring dengan menurunnya jumlah pasien di rawat inap. Pemberian diet jantung meningkat karena banyaknya pasien rawat inap dengan diagnosa terkait sakit jantung. Diet makanan r.purin juga mengalami kenaikan karena banyaknya pasien rawat inap dengan hasil laboratorium uric acid lebih dari batas normal. Bentuk makanan cair mengalami kenaikan, dikarenakan permintaan pasien rawat inap terhadap makanan cair juga meningkat, biasanya makanan cair diminta karena dipengaruhi oleh faktor kesadaran pasien. Diet yang mengalami penurunan adalah diet DM, rendah garam, rendah serat, TKTP, rendah lemak, rendah protein dan tinggi kalium.

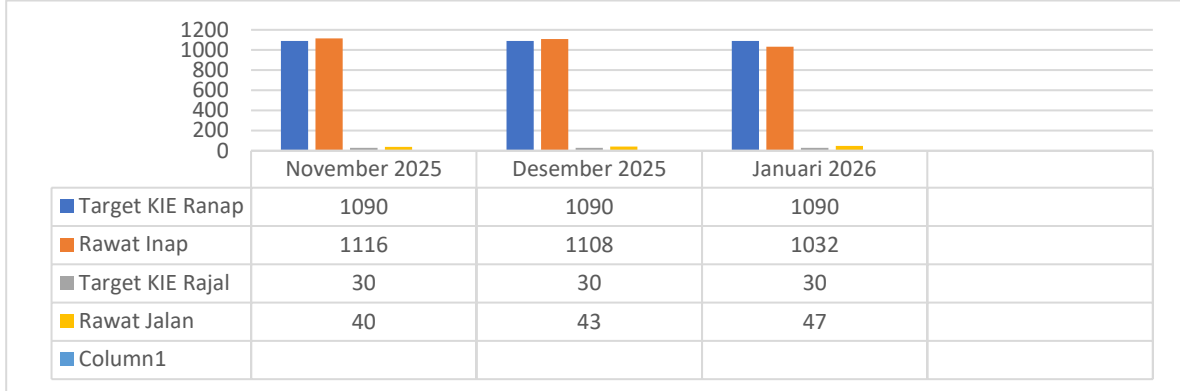
Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi Januari 2026

No.	Indikasi	Jumlah Pasien November 2025	Jumlah Pasien Desember 2025	Jumlah Pasien Januari 2026
1.	Konsultasi Rawat Inap	1116	1108	1032
2.	Konsultasi Rawat Jalan	40	43	47

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada Janauri 2026



Analisis :
Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada bulan Januari menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan bulan Januari mengalami peningkatan dikarenakan DPJP sudah mulai aktif melakukan rujukan konseling gizi rawat jalan. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ard hany Sp.PD, dokter Ardhi Bustami, Sp.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan dokter DPJP dan asisten poli spesialis agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi, selain itu koordinasi dengan tim pendaftaran dalam mempromosikan poli gizi.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Januari 2026

No	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan November 2025	Jumlah Komplain Bulan Desember 2025	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	0	0	1
	ISI KOMPLAINAN	- Komplain dari karyawan (no name) bubur kacang hijau snack pasien yang sisa diberikan kepada karyawan. Dan karyawan yang menemukan komplain terkait ada kutu di bubur kacang hijau.		
	Analisis	- Ditemukan banyak kutu di kacang hijau, diduga saat penerimaan kacang hijau dalam keadaan baik, namun kutu menetas - Pencucian dan perendaman kurang maksimal		
	RTL	- Memperhatikan kebersihan wadah kacang hijau - Menerapkan prinsip FIFO FEFO ditingkatkan lagi		

2.4.5.6 Tabel Rekap *Food Waste* (Sisa Makanan) Januari 2026

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	
1.	Karbohidrat	Nasi	93,6	74,1	65,9	76% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan Januari 2026 menurun 8,7% dari bulan Desember 2026
		Nasi Tim	147,6	123,2	101,3	
	Total		280	199,4	167,2	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang yang rata rata memiliki sisa yaitu snack setup pisang, bubur kacang hiaju, bubur sagu
		Setup Pisang	1	0,8	0,5	
		Kacang Hijau	1,8	0,6	0,5	
		Kue Hongkong	0	0	0	
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	1,4	0,8	0,5	
		Kue Lumpur	0	0	0	
		Puding	0	0	0	
		Donat	0	0	0	
		Tahu Fantasi	0	0	0	
		Brule Bomb	0	0,4	0	
	Total		2,1	2,6	1,5	
1.	Menu 1					Menu 1 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,2 Kg pada bulan Januari. Dan terbanyak pada menu siang sebanyak 4,4 kg sisa makanan
	Bulan		Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	4,6	2,7	3,3	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	5,7	3,6	4,4	
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok				
	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)	5,1	3,3	3,5	
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon				
	Total		15,4	9,6	11,2	
2.	Menu 2					
	Bulan		Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	4,4	3,8	4,2	
		Tahu Rempah (Remet)				
		Abon				

	Tambahan VIP	Telur Rebus			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	5,5	3,8	3,2
		Ayam Wijen			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Telur Gulung			
	Sore	Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)	4,9	3,5	3,1
		Telur dadar tebal			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
Total			14,8	11,1	10,5
3.	Menu 3				
	Bulan		Nov 2025	Des 2025	Jan 2026
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	4,8	4,5	3,9
		Tahu Krispy			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	5,7	4,6	3,4
		Rolade Ayam			
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem			
	Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)	6,2	4,9	3,2
		Telur rebus			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
	Total		16,7	14	10,5
4.	Menu 4				
	Bulan		Nov 2025	Des 2025	Jan 2026
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	6,1	3,9	3,6
		Tahu Nugget			
		Abon			
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	4,6	3,7	1,5
		Ayam Kecap			
		Jamur Krispy			
	Tambahan VIP	Tahu Bacem			
	Sore	Fuyunghai (telur,	1,3	4,2	3,4

		wortel,daunan)sas u polong orang			
		Jamur goreng			
	Tambahan VIP	abon			
Total			12	11,8	8,5
5.	Menu 5				
	Bulan		Nov 2025	Des 2025	Jan 2026
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	6,1	4,1	2,8
		Opor Tahu			
		Oper Telur			
		Tambahan VIP			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	4,8	3,1	3,9
		Ayam Bombay			
		Bakwan Jagung			
		Tambahan VIP			
	Sore	Tahu Krispy	4	3,7	4,2
		Soto ayam			
		Telur rebus			
		VIP= Perkedel ayam			
	Total		14,9	10,9	10,9
	Total Sisa Menu tanpa KH		73,8	57,4	51,6
	Total Keseluruhan dengan KH		315	256,8	218,8

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2026

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)
1.	Januari 2026	218,8
2.	Februari 2026	-
3.	Maret 2026	-
4.	April 2026	-
5.	Mei 2026	-
6.	Juni 2026	-
7.	Juli 2026	-
8.	Agustus 2026	-
9.	September 2026	-
10.	Oktober 2026	-
11.	November 2026	-

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Tahun 2026



Analisis :

- 1. Terdapat 218,8 food waste pada bulan Januari 2026
- 2. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - a. Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b. Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c. Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
- 3. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
- 4. Menu snack yang tidak diminati adalah setup pisang, bubur kacang hijau, bubur sagu dan tahu fantasi.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
- 2. Melakukan plating secara menarik.
- 3. Mengadakan cooking class.
- 4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
- 5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
- 6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
- 7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

2.4.5.7 Lampiran Pemantauan Air Panas di Pencucian Alat Makan



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA

BULAN :

TEMPAT : PENCUCIAN CENTRAL

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Monitoring Suhu (Suhu Normal = 15° - 25°)

Ruang	TANGGAL																																																		
	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M						
Batas suhu min (°C)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
Batas suhu maks (°C)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
Nilai Suhu (°C)	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	26,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	26,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	26,6	26,5	26,4	26,5	26,2	26,8	27,1	27,2	26,3	26,5	27,1	26,8	27	26,8	26,8	27	27,1	27,3	26,8	26,4	26,5	26,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	26,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3
Initial Staff	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	Dw	Dn	Dn	An	Sm	Dw	Dnn	An	An	Dw	An	Dn	Sm	Dn	An	De	Dn	Dw	Dn	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm		
Supervisi Karu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			

Ket :

1. Isi dengan angka yang sesuai pada kolom suhu (°C) sebagai tanda ukuran suhu pada tanggal tersebut, grafik secara otomatis akan terbentuk.

2. Tuliskan inisial staf yang melakukan pencatatan dan akan di supervisi (v) oleh kepala ruang setiap harinya.

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																	
P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M																																
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15																																	
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25																																	
25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	26,6	26,5	26,4	26,5	26,2	26,8	27,1	27,2	26,3	26,5	27,1	26,8	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	26,6	26,5	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	26,6	26,5	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	26,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3			
an	an	an	sm	sm	sm	Dw	Dn	Dn	An	Sm	Dw	Dnn	An	An	Dw	An	Dn	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	Dw	Dn	Dn	An	Sm	Dw					
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

(-->) Suhu ruang tidak lebih dari 25°C

(-->) Suhu ruang tidak kurang dari 15°C

2.4.5.8 Lampiran Rekap Data Kehilangan Alat Makan

DATA NAMA PASIEN MENGHILANGKAN / MERUSAKKAN ALAT							
NO.	TANGGAL	RUAN GAN	NAMA PASIEN	KWITA NSI	DOKUME NTASI	Nama Alat	KET
NOVEMBER 2025							
1	28/11/2025	D6A-8	UMI KULSUM	-	-	SEND OK PASIE N	Pasien menghilangkan sendok, akan tetapi pasien komplain saat diminta mengembalikan dan mengganti sendok
DESEMBER 2025							
1	01/12/2025	C3C-3	SYABIL ISMAIL DWIFARO	-	-	GELA S	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar pergantian ke kasir
JANUARI 2026							
1	06/01/2026	-	-	-		GELA S PASIE N	Gelas tiba-tiba retak, tidak layak pakai
2	12/01/2026	-	-	-		TUTU P BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.
3	13/01/2026	-	-	-		GELA S PASIE N	Gelas mengalami pemuaian saat diangkut oleh CS dan pecah di trolly.
4	17/01/2026					SEND OK MAKA N PASIE N	Sendok makan sudah tidak layak pakai karena berkarat.

5	20/01/2025	-	-	-		GELAS PASIEN	
6	27/01/2025	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.

Analisis :

- Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 6 kehilangan alat makan pada Bulan Januari 2026
- Ada perubahan alur dan dilakukan supervisi oleh Koordinator CS.

Rencana Tindak Lanjut :

- Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
- Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan , CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

4.4.7 CSSD – Laundry

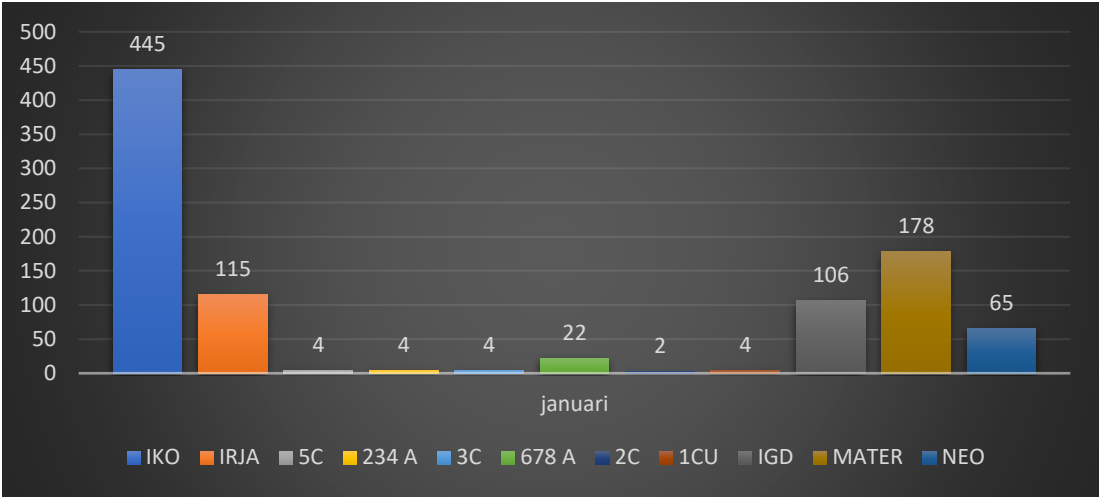
4.4.7.1 CSSD

4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Januari 2026

NO	HAL	BULAN			
		JANUARI 2026			
BHP					
1.	Chemical Alcacide (ml)/ oplos	13 kali oplos			
2.	Chemical Alkazyme (pcs)/ oplos	33 kali oplos			
3.	Kassa Masuk (roll)	70			
4.	Kassa Keluar (pouches)	2209			
5.	BHP Pouces (roll)	4			
6.	Indikator Adhesive (roll)	2			
7.	Indikator Strip Steam (roll)	0			
Alat yang disetor (set)					
8.	IKO	445			
9.	IRJA	115			
10.	IRNA 5C	4			
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	4			
12.	IRNA 3C ANAK	4			
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	22			
14.	IRNA 2C VIP	2			
15.	IRNA ICU	4			

16.	IGD	106			
17.	MATERNITAS	178			
18.	NEONATOLOGI	65			
Jumlah					

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Janari 2026



Analisis :
 Pada bulan Januari Kassa Keluar (pouches) yang paling tinggi

-

Rencana Tindak Lanjut :

-

1.4.7.2 Laundry

1.4.7.2.1 Tabel Produksi Linen Steril

JENIS LINEN	JAN			
Linen IKO	206 SET			
Linen mata	11 SET			

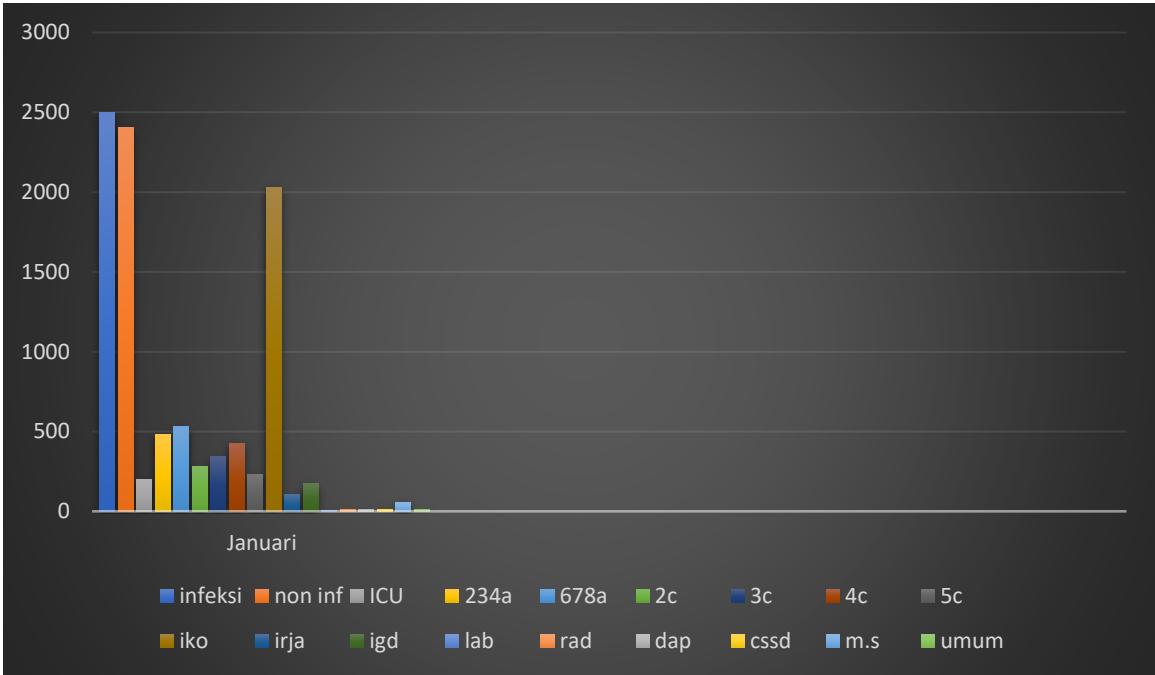
1.4.7.2.2 Penggunaan Chemical Laundry

CHEMICAL	JANUARI
CLAX BUILT LITE	1
CLAX 100	1
CLAX SONRIL	1
CLAX NEUTRAL	1
CLAX SOFT	1
SNAPY	15 LITER
RAPIKA	14 L
BAYKLIN	15 L
SOFTENER	0
LIQUID	30 L
LPG	22 TABUNG

1.4.7.2.3 Produktivitas Linen Laundry

Hal	Januari					
Lineninfeksius	2496					
Linen non infeksi	2402					
234 A	483					
678 A	529					
2 C	280					
3 C	342					
4 C/Mater	425					
5 C	232					
IKO	2.030					
IGD	173					
ICU	202					
IRJA	107					
M.S	58					
Umum	9					
CSSD	13					
DAPUR/GIZ	9					
RAD	9					
LAB	8					

1.4.7.2.4 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Januari 2026



- Analisis :
- 1. Linen IKO di bulan Januari 2026 mencapai 2030
 - 2. Linen IRJA, IGD mencapai 173
 - 3. Linen IRNA juga mengalami penurunan

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
- 2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan,
- 3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.

- Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
- Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
- Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

1.4.7.2.5 Kejadian Instrument Kurang Bulan Januari 2026

IKO	IGD	IRNA	IRJA
0	0	0	0

Analisis :
Tidak ada kejadian instrument kurang

Rencana Tindak Lanjut :
-

1.4.7.2.6 Angka Tercampurnya Instrument dengan Benda Asing

IKO	IGD	IRNA	IRJA
0	0	0	0

Analisis :
Tidak ada kejadian tercampurnya instrument dengan benda asing

Rencana Tindak Lanjut :
-

1.4.7.2.7 Kejadian Linen Hilang

IKO	IGD	IRNA	IRJA
0	0	0	0

Analisis :
Tidak ada kejadian linen hilang

Rencana Tindak Lanjut :
-

4.4 Kinerja Bidang Umum
4.4.1 SDM

Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	S1 Kesehatan Lingkungan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	39	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analisis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		21	14	7	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0

		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		5	3	2	0
14	IGD	Profesi Ners	22	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	1
		D3 Keperawatan		4	4	0	1
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
17	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
18	IRJA	Profesi Ners	29	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		16	14	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	17	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		10	6	4	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0

25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	8	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		7	6	1	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	39	13	7	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	11	4	2	2	0
		SMA		7	6	1	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
Total Karyawan			361	361	275	86	2
42	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	1
43	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0

48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			61	61	2	59	0
Total Keseluruhan			422	422	277	145	2

Keterangan :
Pada bulan Januari terdapat 2 staf resign unit IKO

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	dr. Fiona Paramitha, Sp. A	Dokter Spesialis	14 Januari 2026	SIP Perpanjangan
2	Safitri Retno Kurniawati, AMd.Kep	Perawat	13 Januari 2026	SIP Perpanjangan
3	Winda Lestari, S. Kep. Ns	Perawat	31 Januari 2026	SIP Perpanjangan

Keterangan :
Pada bulan Januari 2026 terdapat 3 SIP baru yang terbit.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menguhubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
4	Dokter Umum IGD	2	1	1	Proses seleksi	Proses seleksi

					sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.	sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.
--	--	--	--	--	--	--

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	21 Oktober 2025	Khusus	Kendita Putri Mahadini	S1	Perawat Gigi	21 Oktober 2025	Penempatan IRJA Poli Gigi

Keterangan : Pada bulan November 2025 ada 1 staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK

Keterangan:
 Pada bulan Januari 2026 belum ada diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	1		0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayana Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Casemix Manager	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	0	26	11	1	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	4	6	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	0	4	1	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	16	0	9	7	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit Humas Markrtng & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	11	0	10	1	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	23	0	16	5	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	11	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCN secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRS	Umum	6	0	6	0	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	28	0	24	4	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	7	0	6	1	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	17	0	16	1	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	13	0	11	1	0	1	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	8	0	8	0	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	17	4	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	8	0	7	0	0	1	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Kuangan & Akuntansi	Umum	9	0	9	0	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	8	0	2	6	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	2	3	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	6	1	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	15	0	5	10	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	4	0	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	6	0	6	0	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	1	2	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	25	14	0	1	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	5	7	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Januari 2026.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	169											
Baik	180											
Cukup	8											
Kurang	0											
Sangat Kurang	4											
TOTAL	361											

Analisa :
 Secara umum terdapat pada kategori baik dan sangat baik. Dikarenakan tidak ada diklat internal pada bulan januari 2026

Rencana Tindaklanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.
4. Membuat diklat dengan konsep baru sesuai arahan PT

Tabel Keterlambatan Karyawan

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	320											



Analisa :
 secara umum terdapat peningkatan keterlambatan karyawan dari bulan sebelumnya

Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0

2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	0
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	1
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	1
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	1
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	0
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	0
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	0
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	1
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	1
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	4

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.6.1 Supervisi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0											

Analisaais:
 Belum dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :
 Lebih ditingkatkan supervisi ke tiap unit khususnya unit dengan tingkat temuan banyak.

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	Haris Fadilah, Amd. Kep	IRJA	IRNA 678A
2	Indha Maghfirotin, Amd. Kep	Neonatologi	ICU
3	Muhammad Roziqin Ni'am Bisri	PDF PHM	PDF PHS

Analisis : pada bulan Januari 2026 terdapat 3 staf rotasi

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	58,97%												

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	276	119	43,12%
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	8
Februari	
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Juli	
Agustus	
September	
Oktober	
November	

Analisa :
Pada bulan ini capaian adalah 43,12% untuk ruangan dan 43,12% untuk alat kesehatan

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	4	8	13	25
FEBRUARI				
MARET				
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER				

Analisa :
Pemeliharaan AC bulan November naik dibandingkan sebelumnya

Link terlampir : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan			
3	Maret	4x/bulan			
4	April	4x/bulan			
5	Mei	4x/bulan			
6	Juni	4x/bulan			
7	Juli	4x/bulan			
8	Agustus	4x/bulan			
9	September	4x/bulan			
10	Oktober	4x/bulan			
11	November	4x/bulan			

Analisis :

Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi berkala

Melalui link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvqSZrNmPuELgYBKbs_oUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan			
3	Maret	4x/bulan			
4	April	4x/bulan			
5	Mei	4x/bulan			
6	Juni	4x/bulan			
7	Juli	4x/bulan			
8	Agustus	4x/bulan			
9	September	4x/bulan			
10.	Oktober	4x/bulan			
11	November	4x/bulan			

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>
2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3l7_SLF6JsafyAZHxZKoPBLPqdAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497
4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fi662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>
5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAYz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5ImQzu3mwtuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4gWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

January 2026							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/01/2026	1704	1257	447	MMHG			MMHG
02/01/2026	1257	3168	0	MMHG	sesudah pengisian	1911	MMHG
02/01/2026	3168	3054	114	MMHG			MMHG
03/01/2026	3054	2760	294	MMHG			MMHG
04/01/2026	2764	2464	300	MMHG			MMHG
05/01/2026	2464	2150	314	MMHG			MMHG
06/01/2026	2150	1838	312	MMHG			MMHG
07/01/2026	1838	1530	308	MMHG			MMHG
08/01/2026	1049	3169	0	MMHG	sesudah pengisian	2120	MMHG
08/01/2026	3169	3030	139	MMHG			MMHG
09/01/2026	3030	2713	317	MMHG			MMHG
10/01/2026	2713	2418	295	MMHG			MMHG
11/01/2026	2418	2248	170	MMHG			MMHG
12/01/2026	2248	2119	129	MMHG			MMHG
13/01/2026	2119	1815	304	MMHG			MMHG
14/01/2026	1815	1322	493	MMHG			MMHG
15/01/2026	1322	3319	0	MMHG	sesudah pengisian	1997	MMHG
15/01/2026	3319	3030	289	MMHG			MMHG
16/01/2026	3030	2786	244	MMHG			MMHG
17/01/2026	2786	2487	299	MMHG			MMHG
18/01/2026	2487	2160	327	MMHG			MMHG
19/01/2026	2160	1827	333	MMHG			MMHG
20/01/2026	1827	1531	296	MMHG			MMHG
21/01/2026	1531	1268	263	MMHG			MMHG
22/01/2026	1268	846	422	MMHG			MMHG
23/01/2026	846	3057	0	MMHG	sesudah pengisian	2211	MMHG
23/01/2026	3057	2946	111	MMHG			MMHG
24/01/2026	2946	2630	316	MMHG			MMHG
25/01/2026	2630	2317	313	MMHG			MMHG
26/01/2026	2317	1997	320	MMHG			MMHG
27/01/2026	1997	1691	306	MMHG			MMHG
28/01/2026	1691	1548	143	MMHG			MMHG
29/01/2026	1411	1084	327	MMHG			MMHG
30/01/2026	896	3250	0	MMHG	sesudah pengisian	2354	MMHG
30/01/2026	3250	3136	114	MMHG			MMHG
31/01/2026	3136	2796	340	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan			8252	MMHG			MMHG

ini							
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						8682	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			505.6666667	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3472.8	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan			
Maret	1x/bulan			
April	1x/bulan			
Mei	1x/bulan			
Juni	1x/bulan			
Juli	1x/bulan			
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi melalui link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY_e93IQE/edit?gid=342425059#gid=342425059

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan			
Maret	1x/bulan			
April	1x/bulan			

Mei	1x/bulan			
Juni	1x/bulan			
Juli	1x/bulan			
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcauU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 List Lokasi Lift

NO	LOKASI	KONDISI
1	Lift Gedung A Pasien	Baik
2	Lift Gedung A Pengunjung	Baik
3	Lift Gedung B	Baik
4	Lift Gedung C Umum	Baik
5	Lift Gedung C Karyawan	Baik
6	Lift Gedung D (Garansi)	Baik

1.5.2.2.8.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

1.5.2.3

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				

November				
Desember				

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPJtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017

1.5.2.3.3 **UPS**
1.5.2.3.3.1 **Tabel Capaian Pemeliharaan UPS**

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapitan Kegiatan External

DATE	URAIAN PEKERJAAN	UNIT AREA	PETUGAS
01/01/2026	Cleaning ac klinik ptp	klinik ptp	Dian T, Tulus j
05/01/2026	perbaikan dental ms karangploso	klinik karlos	M Arifin
06/01/2026	perbaikan dental ptp lt 1	klinik ptp	M Arifin
08/01/2026	perbaikan ac poli gigi lt 1	klinik ptp	Dian T, Tulus j
12/01/2026	instalasi ulang kabel genset dan pemasangan pengaman genset	klinik karlos	M Arifin
13/01/2026	pengecekan sealer continue cssd rsdh	rsdh	M Arifin
14/01/2026	Monitoring genset	klinik bedali	M Arifin
	monitoring flow ipal		
	monitoring flow air bersih		
	monitoring panel mdp		
	perbaikan highspeed dental		
15/01/2026	Monitoring genset	klinik ptp	M Arifin
	monitoring flow ipal		
	monitoring flow air bersih		
	monitoring panel mdp		
	Mapping ruang laboratorium baru		
19/01/2026	pemasangan heater selaer cssd rsdh	rsdh	M Arifin
20/01/2026	Uji fungsi setelah pemasangan heater rsdh	rsdh	M Arifin
20/01/2026	Perbaikan ac poli klinik kia	klinik bedali	Dian T, Yonatan d
20/01/2026	perbaikan ulang ac poli kia	klinik bedali	Dian T
22/01/2026	perbaikan lampu tindakan	klinik bedali	M Arifin
22/01/2026	Monitoring genset	klinik ptp	M Arifin
	monitoring flow ipal		
	monitoring flow air bersih		
	monitoring panel mdp		
	maintenance dental lt 2		
	maintenance dan service dental lt 1		
23/01/2026	Perbaikan ac ruang tunggu lt 1	klinik karlos	Dian T, Tulus j
	uji coba usg logic 100	klinik karlos	Salma GP
24/01/2026	bongkar ac ex klinik lawang	klinik bedali	Dian T, Yonatan d
26/01/2026	Monitoring panel mdp	klinik bedali	M Arifin
	Monitoring genset	klinik bedali	

	Monitoring flow air bersih	klinik bedali	
	Monitoring flow ipal	klinik bedali	
	mapping pemasangan ac casette dengan berkah jaya	klinik bedali	
27/01/2026	cleaning ac farmasi	klinik bedali	Dian T, Yonatan d
	Cleaning ac poli umum 1	klinik bedali	
	Perbaikan ac ruang tunggu selatan	klinik ptp	
28/01/2026	cek flow debit ipal	klinik ptp	M Arifin
	cek flow debit air bersih		
	Monitoring panel listrik		
	monitoring genset		
	pendampingan pihak ketiga instal alat laboratorium		
	setting dan pemasanangan water tank poli gigi lt 2		

Keterangan :
 Total 47 jam lebih 27 menit untuk perbantuan eksternal.

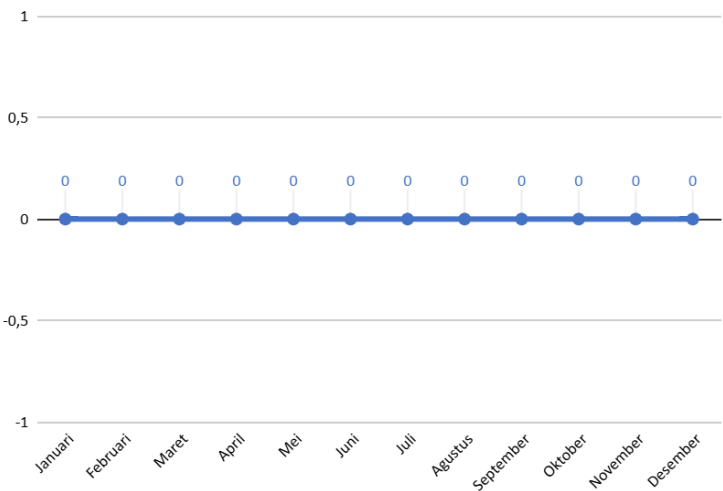
Rekapan link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian kehilangan barang	0											

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



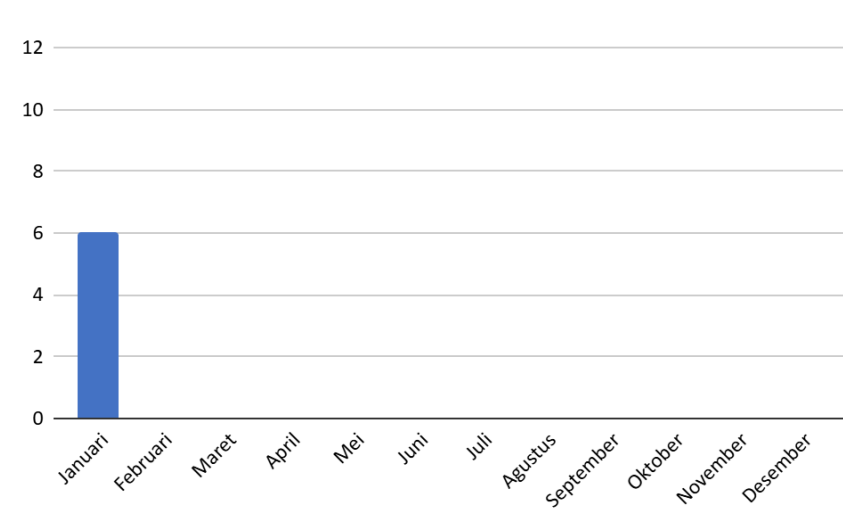
Analisa :
 Tidak ada kehilangan barang bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	6										

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



3.7.6 Tabel Angka Kejadian Berpotensi Kehilangan Barang

TANGGAL	KETERANGAN	RTL
06 – 01 – 2026	Ditemukan berkas milik pengunjung di area kamar mandi belakang parkiran baru oleh team parkir diamankan di pos igd	Telah di ambil pemilik
06 – 01- 2026	Telah ditemukan dompet di area ruang tunggu farmasi . dompet kita amankan di pos igd	Telah di ambil pemilik
10 – 01 – 2026	Telah ditemukan barang milik pasien tertinggal di depan ruang tunggu farmasi diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
13 – 01 - 2026	Telah ditemukan kontak sepeda motor diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
13 – 01 – 2026	Telah ditemukan dompet tertinggal di meja pengambilan obat farmasi diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
27 – 01 – 2026	Telah ditemukan kunci kendaraan diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

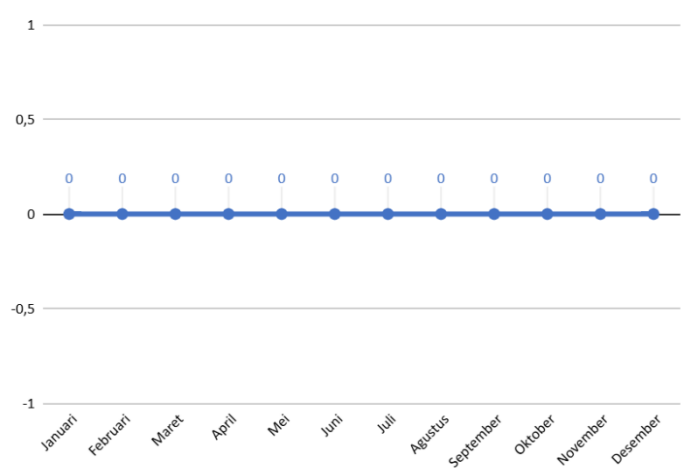
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0										

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

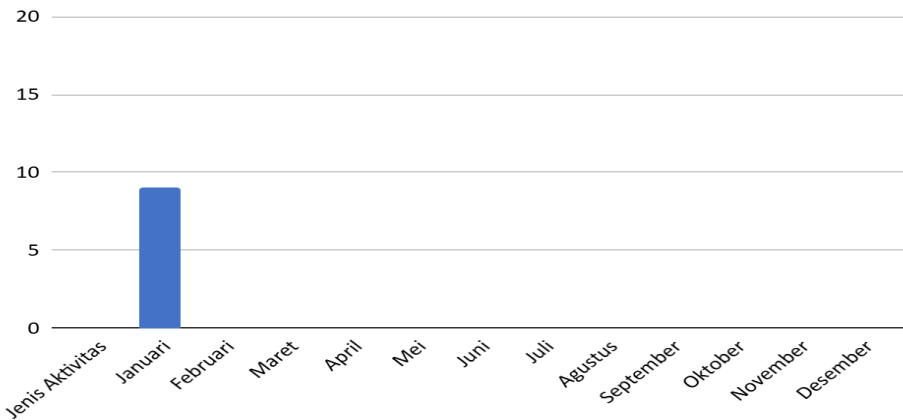


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	9											



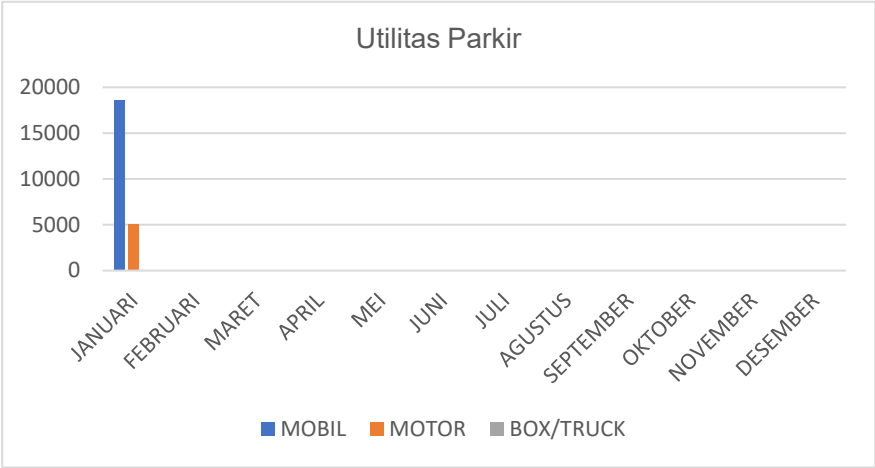
Analisis :

Angka 9 ini terindikasi masih belum terekap semua, hal ini ditunjukkan dari rata-rata per hari yang telah diedukasi karena merokok bisa lebih dari 1x. Dengan temuan yang lebih banyak dari bulan lalu mengindikasikan pencatatan dan pelaporan lebih baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.4 Parkir



Analisis :

Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Juni 2025

No	Bulan	Target	Jumlah					
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	Total Kurang
1	Januari 2026	1 IKS baru	128	1	1	0	1 (Proses review)	1
Analisis ; 1. Pada bulan Januari 2026, PKS dengan Laboratorium Kedungdoro Selesai, Proses Perpanjangan PKS PMI dalam proses,PKS baru dengan Klinik Waras Wiris yang sebelumnya adalah PT CAKRA SURYA HUSADA 2. Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review Rencana Tindak Lanjut : 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru 2025

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
2	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Review
3	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	TTD Pihak ke-2	Selesai
4	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
5	TPA Halodoc	Review	Proses Review
6	Klinik Waras Wiris	Review	Proses Review



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

1.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Tahun 2025

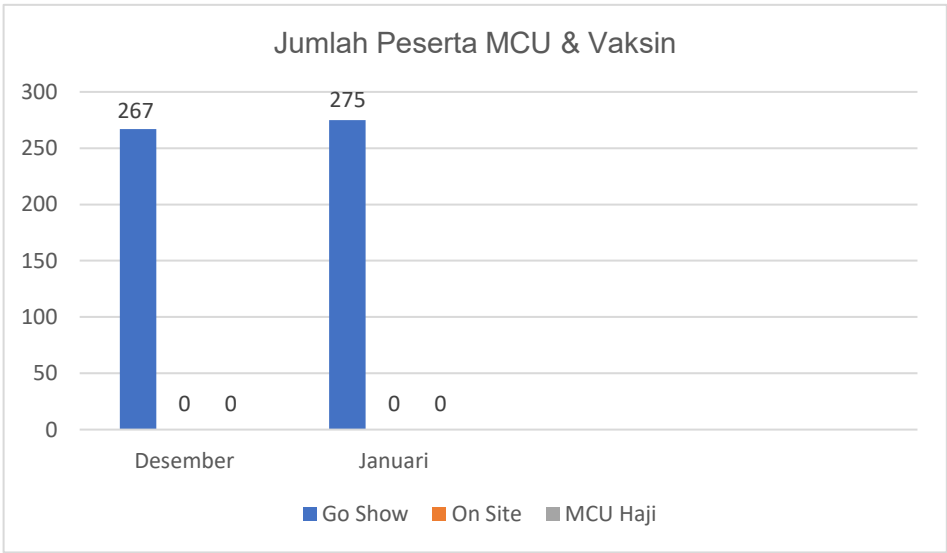
No	Bulan	Target	Jumlah Pasien GOSHOW	ON SITE
1	Desember	150	267	-
2	Januari	150	275	-

Analisis ;

Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Januari meningkat sebesar 3% dibandingkan bulan sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut :

- Melakukan Promosi kesehatan kembali melalui Social Media
- Kunjungan Perusahaan dan sekolah untuk menawarkan program MCU



1.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2026

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Sinergi Pangan	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit
		Travel Kbih Al Muchsinin	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 24 Jamaah di RSPHM
		Travel King Salman	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 5 Jamaah di RSPHM

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

Target	N o	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
5 Kunjungan per bulan	1	12/01/2026	PT TENTREM	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	2	12/01/2026	PT KEMAS SUPER INDONESIA (KSI)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal	Belum respon ada	Follow up ulang akhir bulan

				dari Perusahaan		
	3	12/01/2026	PT ARTHAWEN A SAKTI GEMILANG	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	4	12/01/2026	PT BANGUN SARANA WREKSA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	5	12/01/2026	CV AUMIRETA ANGGUN	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	6	12/01/2026	PT CIPTA SANDHI DARMA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	7	12/01/2026	PT INTAN PRAMADITA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan,	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

				3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	penawaran terlebih dahulu 3. PIC menanyakan untuk paket Pemeriksaan Narkoba dan sudah dijelaskan	
	8	12/01/2026	PT INDOMARINE	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menyampaikan penawaran akan menjadi bahan referensi	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	9	12/01/2026	PT LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

				dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan		
	10	12/01/2026	PT MALINDO INTITAMA RAYA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	11	12/01/2026	PT UNGGUL ANUGRAH SEJAHTERA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. PIC akan menanyakan kepada pimpinan dan bila pimpinan mengadakan program MCU akan di arahkan ke RS	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	12	15/01/2026	PT OTSUKA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	13	15/01/2026	PT RAGAM RAYA RASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	14	15/01/2026	PT KHARISMA SELARAS	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan,	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

				3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan		
	15	15/01/2026	PT ADI PUTRO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	16	15/01/2026	PT USTEGRA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

				dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan		
	17	15/01/2026	PT INDOSTAR BUILDING MATERIAL	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	18	15/01/2026	PT SUMBER ALFARIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	19	15/01/2026	PT WIM (KTG)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	20	20/01/2026	PT SINAR TAMAN PLASTINDO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	21	20/01/2026	PT PADMA INDAH PRIMA PERKASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan,	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

				3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan		
	22	31/01/2028	Kegiatan Senam Yoga Lansia	1. Program dengan komunitas Lansia geriatri berupa Yoga 2. Jumlah peserta 56 orang 3. Peserta aktif mengikuti seluruh kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik, peserta sangat antusias mengikuti kegiatan	Koordinasi dengan PKRS untuk agenda selanjutnya

Analisa :
 Kunjungan eksternal disesuaikan dengan permasalahan yang ada, komunikasi sekarang juga dilakukan dengan online pada beberapa target klinik dan mitra. Untuk kegiatan umum seperti pengenalan RS dll sudah dilakukan di event HKN

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi berkala.

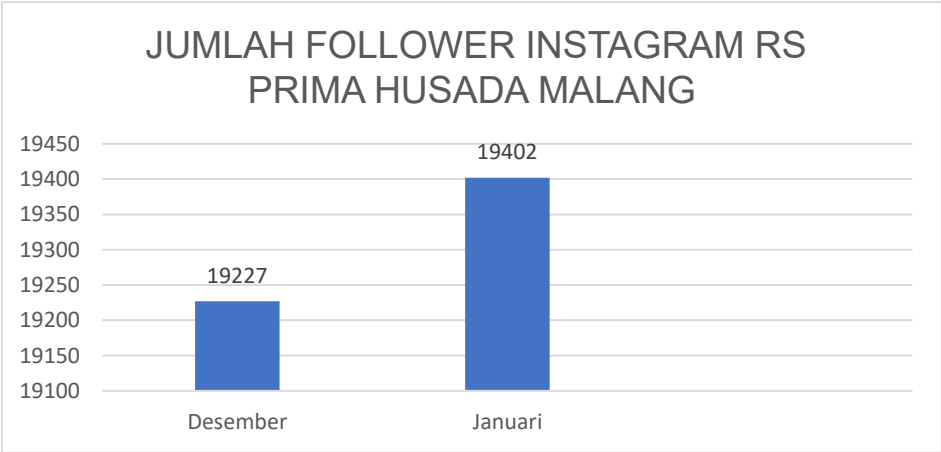
Tabel Hasil Kinerja Event Eksternal Humas Marketing RSPHM Pada Tahun 2026

Target	No	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
MCU dan Vaksin	1	09/01/2026	PT Sinergi Pangan Gemilang	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Sinergi Pangan Gemilang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	2	14/01/2026	KBIH Al Muchsinin	Program Vaksin 24 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan vaksin untuk 24 orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	3	26/01/2026	KBIH Alfattah Singosari	Program Vaksin 9 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan Vaksin untuk 6 Orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	4	26/01/2026	Travel King Salman	Program Vaksin 5 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan untuk vaksin sesuai ketentuan penawaran dengan 6 Orang	Sudah selesai

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

JUMLAH KONTEN BARU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
FEED FOTO	12											
REELS	4											
STORY	13											
TOTAL	29											0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
FEED FOTO	13											
FEED VIDEO	4											
REELS	4											
STORY	89											
TOTAL	110											
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	19402											
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	311											
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



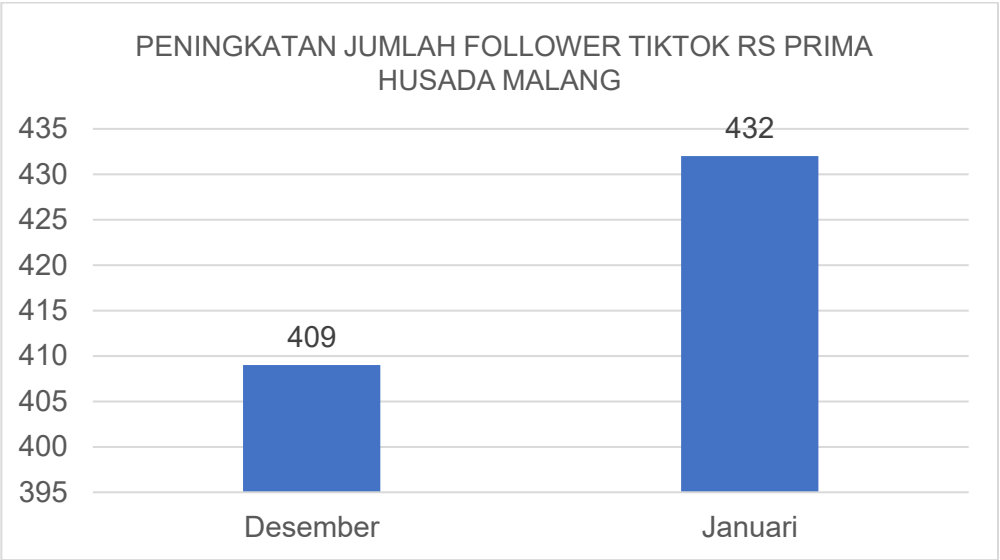
Analisa :

Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 0.91%. dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH KONTEN BARU	2											
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	432											
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	23											
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH LIKE	1876											



Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 5,62% dari bulan sebelumnya

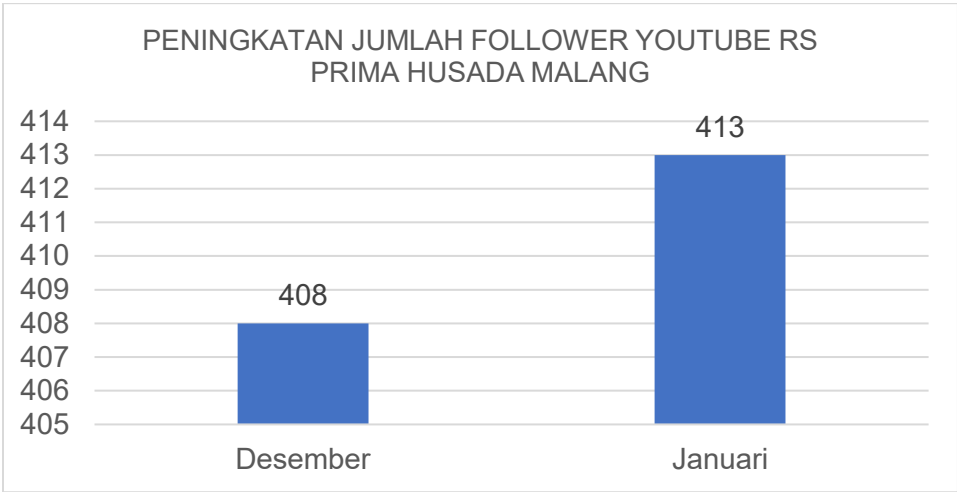
- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH KONTEN BARU	0											
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
-------	---------	----------	-------	-------	-----	------	------	---------	-----------	---------	----------	----------

JUMLAH SUBS	413											
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	5											0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Analisa :
 Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan Sebesar 1,23 % dari bulan Sebelumnya

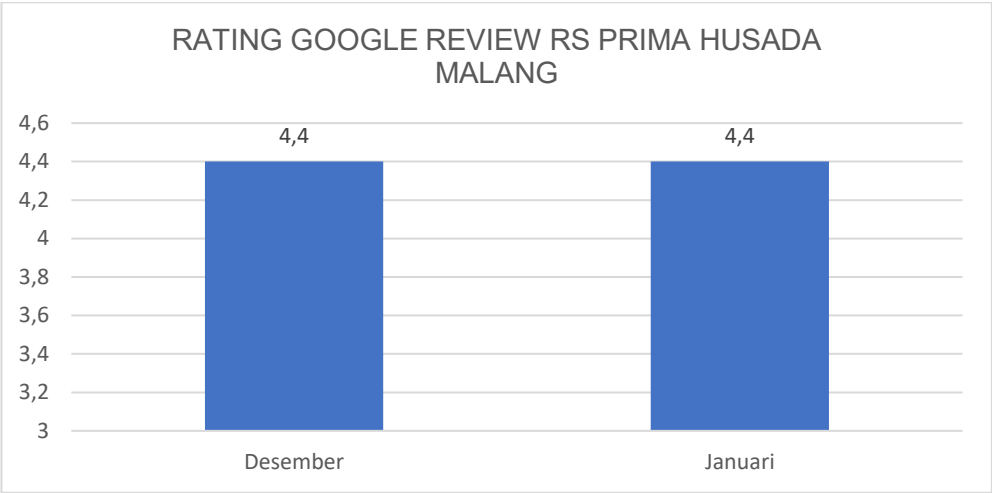
- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.4											

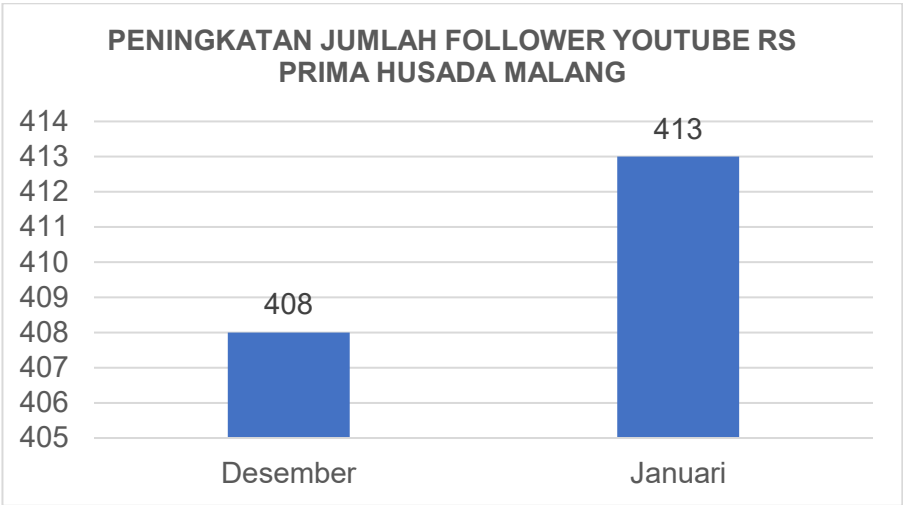
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUL I	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH KONTEN BARU	0											
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUL I	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH SUBS	413											
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUL I	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	5											0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Analisa :
Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan sebelumnya

Rencana Tindal Lanjut :
Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review



Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan Sebesar 1,23 % dari bulan Sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG																
PERIODE 2026																
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUM YA)	SELISIH KURANG (BULAN SEBELUM YA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
											Y	Z	AA	AB	AC	
		a	b	c	{a-b-c=d}	e	f	g	{e-f-g=h}	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
PERIODE JANUARI 2026 :																
1	Anerasi	327.848.678	118.103.853	3.551.773	206.187.046	223.315.785	33.024.473	142.290	183.468.402	389.655.448	322.713.452	36.349.124	11.433.748	5.428.212	13.739.718	389.655.447
2	Perawatan	541.731.384	211.314.688	260.201	330.217.035	369.380.032	15.600.000	-	353.780.032	683.397.188	546.449.749	751.582	47.849.411	-	41.497.327	683.397.188
3	Mandi kesehatan	154.254.619	130.403.588	3.220.018	20.631.013	75.884.547	-	-	75.884.547	36.515.560	96.515.569	-	-	-	-	36.515.560
4	Jasa Rawat	146.106.395	141.951.785	353.365	3.995.245	105.163.030	18.385.814	0	86.777.216	30.712.521	99.712.521	-	-	-	-	30.712.521
5	BPJS Kesehatan	578.231.439	476.533.400	407.580	101.284.519	436.075.163	-	-	436.075.163	537.359.682	937.359.442	-	-	-	-	537.359.682
									Total Saldo	1.798.300.398	1.634.660.193	37.188.626	59.325.359	5.428.212	62.586.036	1.798.300.398
NOTE : JASA RAHARJA DAN BPJS TK MENGGUNAKAN TARIF SESUAI TARIKAN SIMRS DIKARENAKAN BELUM CLOSING HINGGA TGL 07/02/2026																

Keterangan : Cut off 31 Januari 2026 sebesar Rp 1.798.300.398

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	E110 tidak sesuai, reseleksi E119, coma bagian dari DU	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Konfirmasi berapa cc urin output, BB pasien, dan lampirkan lembar observasi cairan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Tidak sesuai kaidah pengkodean klinis, tidak ditemukan skor curb/psi, AB < 72 jam, pemeriksaan gram (-), du lebih spesifik	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Tidak sesuai standar pelayanan: Tidak ada hasil antropometri, kode E44.1 dihapus	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Tidak sesuai kaidah pengkodean klinis, prosedur yang sesuai 86.59	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Indikasi MRS dan resource terbesar R02, reseleksi DU	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Tidak sesuai kaidah pengkodean klinis, R57.9 tidak dikode terpisah	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Tidak ada bukti pendukung diagnosa I50 (hasil echo) hapus kode DS	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			
1	Kunjungan multi Poli, fragmentasi TL, Pending, indikasi Rujukan transit , TL	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Indikasi Rujukan transit	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Rujukan FKTP dx katarak 2 x, indikasi masih diberi kontrol	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Dx kronis, setiap bulan kontrol, PRB	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	IRM lebih dari 6 bulan, dx nonstroke	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

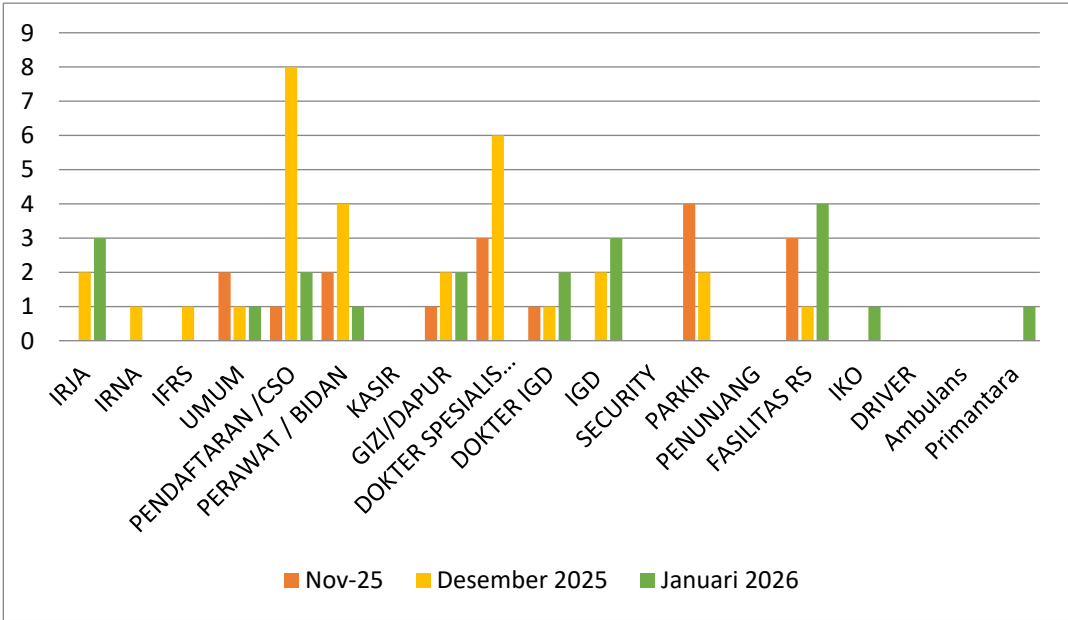
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Januari 2026

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1.	IRJA	0	2	3
2.	IRNA	0	1	0
3.	IFRS	0	1	0
4.	UMUM	2	1	1
5.	PENDAFTARAN /CSO	1	8	2
6.	PERAWAT / BIDAN	2	4	1
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	1	2	2
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	3	6	0
10.	DOKTER IGD	1	1	2
11.	IGD	0	2	3
12.	SECURITY	0	0	0
13.	PARKIR	4	2	1
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	3	1	3
16.	IKO	0	0	1
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	1
Total		17	31	20

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Januari 2026



Analisis :

Jumlah pasien complain selama Bulan Januari 2026 mengacu pada complain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- 1. Jumlah complain Pada bulan Januari 2026 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan November sebanyak 16 pasien pada bulan Desember sebanyak 31 pasien, Sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 20 pasien
- 2. Complain terbanyak pada bulan Januari 2026 yaitu dari bagian Fasilitas RS sebanyak 4 kasus, IGD dan IRJA sebanyak 3 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- 3. Pada bulan Januari 2026 tidak ada complain yang tidak bisa langsung diselesaikan

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Complain Bulan Januari 2026

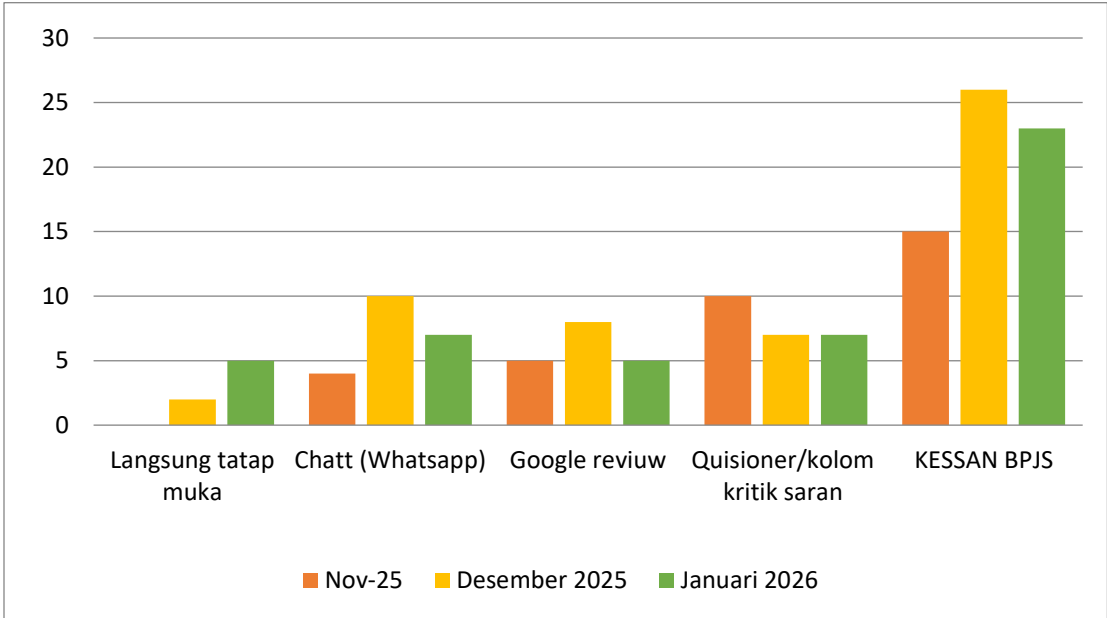
NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1.	Langsung tatap muka	0	2	5
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	4	10	7
b	Google review	5	8	5
3.	Quisioner/kolom kritik saran	10	7	7
4	KESSAN	15	26	23

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

KESSAN BPJS	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5
	0	0	2	21	86

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Complain Bulan Januari 2026



Analisis :

Pada bulan Januari 2026 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Watshap yaitu sebanyak 7 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari Quisioner sebanyak 7 kasus complain

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Januari 2026

NO	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplai atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	100%	0	0
5.	KESSAN	100%	100%	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Januari 2026 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 90% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

1. Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 2 kasus complain dengan rincian :
- 1) Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu perbaruan matras penunggu pasien sudah kaku dan keras

Rencana Tindak Lanjut :

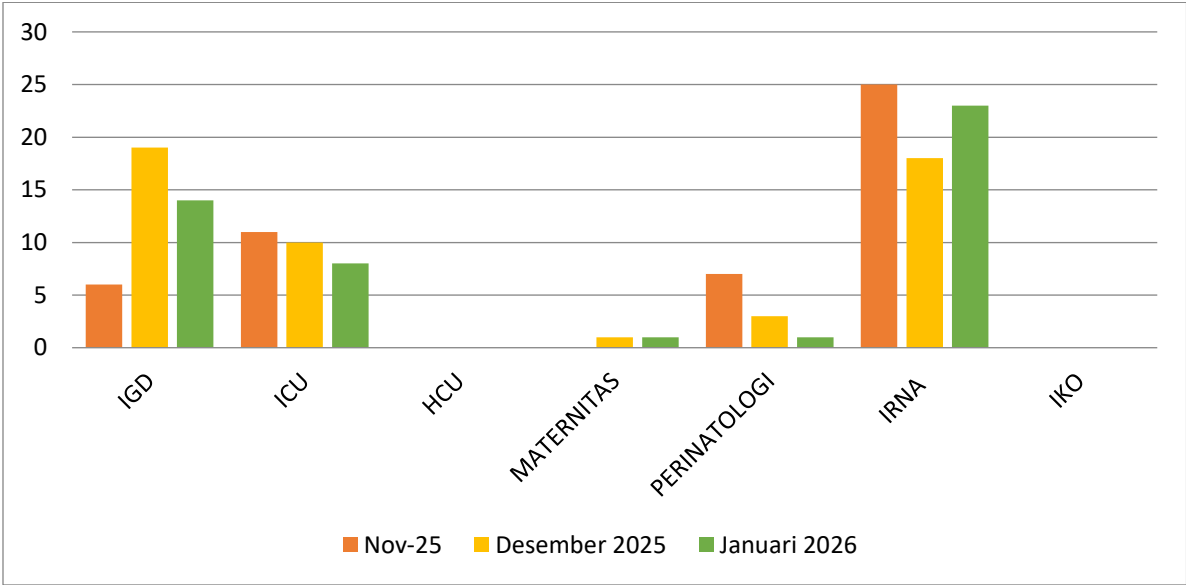
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Januari 2026

NO	UNIT PERUJUK	NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1.	IGD	6	19	14
2.	ICU	11	10	8
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	0	1	1
5.	NEONATOLOGI	7	3	1
6	IRNA	25	18	23
7	IKO	0	0	0
Total		49	51	47

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Januari 2026



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk Januari 2026

No Tahun	NO RM	Nama Pasien	LAMA RAWAT	Status	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	PLAVON HABIS
1	229879	NISWATI	2	BPJS kesehatan	8A	ALO Kardiogenik DD non kardiogenik, CPC, Effusi perikardium dd tamponade	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RSSA	Pro CVCU	Tidak
2	242543	SDR. TOMY KURNIAWAN	1	Jaminan perusahaan	7A	Open fraktur pedis sin dihiiti 1-4, CF metacarpal Sin, FR mandibula	DR KUNTADI, SP. OT	RS Lavallete	APS dari penjamin	Tidak
3	225559	Ny Tatik	3	BPJS kesehatan	7A	DM Hiperglikemia, Syok Condition teratasi, AKI St III	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RS Lavalete	pro HD	Tidak
4	36590	NY NIA MASLIKHAH	2	BPJS kesehatan	4A	Febrile netropeni post kemoterapi riw ca mamae D	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RS Lavalete	Pro pemberian lekogen	Tidak
5	242587	Tn.Hadir	3	BPJS kesehatan	8A	Ca Renal, Anemia gravis	DR PRADANA, SP.U	RSSA	Pro radikal nefrectomy kp embolisasi	Tidak
6	242655	MUTHIA ARRAHMA KUSUMA	2	BPJS kesehatan	3C	curiga anemia aplastik dengan sindrom nefritik akut dan perdarahan akut	DR DICKY FATURRACHMAN,SPA,M,BIOME D	RSSA	Pro BMP	Tidak

7	242680	Tn. Santoso MUH. Umar	2	BPJS kesehatan	8A	Combutio grade 2	DR SIGIT, SP.BP	RSSA	Pro Tata laksana Lebih Lanjut	Tidak
8	242785	NY JUMIATI	1	BPJS kesehatan	ICU	STEMI inferoposterior RV infarct (failed fibrinolytic)+Cardiogenic shock (during fibrinolytic) 1 st degree AVB+VT (post cardioversion)+Hyperglycemia in critically ill	DR MIRYANTI CAHYANINGTAS SP JP	RST dr Soepraoen	pro PCI	Tidak
9	242759	Tn. Raden Aan Kurniawan	2	BPJS kesehatan	5C	NSTEMI PRO PCI ec high risk, ADHF EF 42%,SVT, Dislipidemia	DR IRA SETYA WATY SP JP	RST dr Soepraoen	pro PCI	Tidak
10	65476	NY. LIS SA'ADAH	5	BPJS kesehatan	2A	Neoplasma Cerebri + DM + Hemiparase dextra	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RST. SOETOMO SURABAYA	pro excisi tumor	Tidak
11	242827	MARTINUS ISTIJO	2	BPJS kesehatan	IGD	Resp Failure type 2	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RS Lavallete	pro HD Cito	Tidak
12	136972	NY. MISNI	6	BPJS kesehatan	ICU	ADHF+HT emergency+CAD+Stroke+Pneumonia+Resp Failure type 2+copd+DM hiperglikemia in critical ill+AKI st 3+sepsis MODS	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RS Lavallete	Pro HD Back up Ventilator	Tidak
13	242863	TN.SAIFUL	2	BPJS kesehatan	ICU	STEMI ANTERIOR >12 jam, ADHF EF 42%, DISLIPIDEMIA	DR IRA SETYA WATY SP JP	RS UMM	Pro PCI	Tidak
14	176608	TN.UNTUNG LELONO	6	BPJS kesehatan	4A	Cardiogenic shock + septic shock, CVAdr Farid Sp S	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RST Soepraon	Pro Stroke unit	Tidak
15	40027	ENDANG SRI W	2	BPJS kesehatan	IGD	Fr. Patologis femur S.	DR KUNTADI, SP. OT	RSSA	Pro perawatan lebih lanjut	Tidak
16	81347	TN.GHOZALI BAJURI	2	BPJS kesehatan	2A	CKD St V, hiperkalemia, uremic gastropaty	DR ZORAIDA DWI WAHYUNI, SP. PD	RSUB	Pro HD	Tidak
17	242940	An. Ahmad Arshan	2	BPJS kesehatan	3C	Bronchopneumonia, distres napas	DR DICKY FATURRACHMAN,SPA,M,BIOMED	RSSA	Pro ventilator dengan perawatan lama	Tidak
18	196200	Hariyono Soeparto	5	BPJS kesehatan	2A	CVA Infark + Pneumonia + DM 2 + LV Failure	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RSSA	PRO Stroke unit	Tidak
19	68112	JAYADI	2	BPJS kesehatan	IGD	CKD	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RS Lavalate	PRO HD	Tidak
20	155427	Rizki Mega Dian	2	BPJS kesehatan	MTS	P0201 Ab000 dengan post partum vbac + post histerektomi atas indikasi HPP + susp polisitemia vera	DR HUMAIRAH, SP. OG	RSSA	PRO PERAWATAN INTENSIF	Tidak
21	76676	MUHAMMAD ARIF FEBYANSYAH	2	UMUM	IGD	Crush Injury Manus Sinistra	DR ARIANTO, SP.OT	RS Lavalete	Pro repair arteri + tendon + Orif	Tidak
22	243201	MUKHAMMAD CHAFIDUL MUKHID	2	UMUM	IGD	STEMi anterior extensive	DR MIRYANTI CAHYANINGTAS SP JP	RST	Pro Primary PCI	Tidak
23	243157	NY CHUSNUL CHOTIMAH	3	BPJS kesehatan	7A	UAP ADHF EF 33% DISLIPIDEMIA	DR IRA SETYA WATY SP JP	RS Aisyah	pro pci	Tidak
24	214669	NY. SULIATI	2	BPJS kesehatan	4A	gbs, tetraparase, paraplegi	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RS Soetomo surabaya	pro EMG + Lumbal pungsi, plasmapheresus / IVIG	Tidak
25	243274	NY. JUARIAH	3	Jasaraharja	ICU	Trauma thorax dg trauma abdomen, Susp perdrh sal cerna bagian atas, fr cruris sinistra	DR KUNTADI, SP. OT	RS Soetomo surabaya	PRO penatalaksanaan lanjutan (bedah digestif)	Tidak
26	152541	NIZAM ALI SYARIQ	1	Asuransi	IGD	susp seizure dd gerakan involunter (korea)	DR DICKY FATURRACHMA	RS PERSADA HOSPITAL	Pro EMG	Tidak

							N,SPA,M,BIOME D			
27	141566	NY. Patonah	4	BPJS kesehatan	2A	Uremic encephalopati + Acute on CKD + Cushing syndrome + DM hiperglikemia	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD		pro HD cito	Tidak
28	243450	NI'AMAH	1	BPJS kesehatan	IGD	STEMI inferior	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RSI Aisyah	Pro PCI	Tidak
29	170171	KHUSNUL ROFIQ	2	BPJS kesehatan	ICU	Aortic stenosis, Mitral Insufficiency, Cardiogenic shock	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RSSA MALANG	Pro CVCU	Tidak
30	120704	HARJONO	1	BPJS kesehatan	IGD	STEMI	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RS UMM	Pro PCI	Tidak
31	168850	Tn. Totok Sugianto	3	BPJS kesehatan	5C	anemia, hematemesis, Susp. Ruptur VE	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RSSA	Pro endoskopi dan penanganan sirosis, perawatan dengan KGEH	Tidak
32	59439	Ny. Rakhmi Fitri Diani	4	BPJS kesehatan	6A	Post hipoglikemia refrakter, Congestif pulmonum	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	RSI Aisyiyah	Pro pertimbangan endoskopi	Tidak
33	242951	Ny. Hasan Sadjali	11	BPJS kesehatan	ICU	.respiratory failure, Sepsis dt pneumonia	DR. ANDY SP. P	RSSA	Pro Tracheostomy	Tidak
34	161456	SITI JUBAIDAH	1	BPJS kesehatan	IGD	STEMI, susp. Stent thrombosis	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RS UMM	Pro PCI	Tidak
35	243630	SUKARI	2	BPJS kesehatan	IGD	Spinal Cord Injury ec Brust Fr Thoracal 12	DR ARIANTO, SP.OT	RS Saiful Anwar Malang	Pro MRI + Decompresi + Stab Post	Tidak
36	243009	Ny. Uswatun Khasanah	5	BPJS kesehatan	6A	Post status epileptikus+Susp ME dengan Tuberkuloma dd Abscess Cerebri+Efusi Pleura sinistra+Hiponatremia	DR FAHIMMA, SP. N	RS Saiful Anwar	Pro Lumbal Pungsi dan perawatan lanjutan	Tidak
37	210483	Siti Khoiriyah	3	BPJS kesehatan	ICU	CVA ICH Subcortex dekstra, HT	DR AKHMAD SYAHRIR SP N	RS Saiful Anwar Malang	Pro Stroke Unit	Tidak
38	240252	JOKO SANTOSO	2	UMUM	IGD	STEMI INFERIOR	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RS UMM	Pro PCI	Tidak
39	243831	Tn. Misdi	4	BPJS kesehatan	ICU	COB	DR ANTON, SP.B	RS Saiful Anwar	Pro tatalaksana lanjutan multiple trauma	Tidak
40	70085	SUDJONI	1	BPJS kesehatan	IGD	Susp CF distal femur sinistra	DR ARIANTO, SP.OT	RSUD Bangil	Pro Pro locking titan trochanter femur	Tidak
41	243950	BY NY. HAZIZAH PUTRI KOTIMA	2	BPJS kesehatan	NEO	RDS ok HMD DD neonatal pneumonia	DR FIONA PARAMITHA SP.A	RSSA	Pro penatalaksanaan sub spesialisik neonatologi	Tidak
42	145523	CHOIDIN	1	BPJS kesehatan	IGD	CKD	DR ARDHI BUSTAMI,SP.P	RSSA	PRO HD	
43	116193	MASUKAH	2	BPJS kesehatan	5C	SAH dengan Vasospasme	DR FAHIMMA, SP. N	RS Karsa Husada Batu	Pro Unite Stroke	Tidak
44	244215	FADHIL	2	BPJS kesehatan	IGD	Anemia, Tumor Abdomen susp Hepatomegali	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	RSSA	Pro Endoscopy + Sp.PD-KGEH	Tidak
45	244184	Tn SUEP	1	BPJS kesehatan	2C	1. Susp. TETANUS	DR ANTON, SP.B	RSUD KANJURUHAN	Pro Isolasi Tetanus dan tatalaksana lanjutan	Tidak
46	130811	Tn. Mujiono	1	BPJS	2A	NSTEMI, Syock kardiogenik	DR MIRYANTI CAHYANINGTAS	RSSA	Pro immediate invasive strategy	Tidak

				Kesehatan			SP JP		(PCI)	
47	243389	Ny. Endang Murtisiwi	2	BPJS kesehatan	4A	STEMI	DR MIRYANTI CAHYANINGTAS SP JP	RSI AISIYAH	Pro primary PC	Tidak

Analisis :

- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Januari 2026. Pada bulan November sebanyak 49 pasien, pada bulan Desember 2025 sebanyak 51 pasien, Sedangkan pada bulan januari 2026 sebanyak 47 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan
 - Membutuhkan alat khusus
 - Membutuhkan pengobatan ARV
- Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya. Pada bulan Desember 2025 sebanyak Rp. 8.188.659 sedangkan pada bulan Januari 2026 tidak di dapatkan plavon minus.

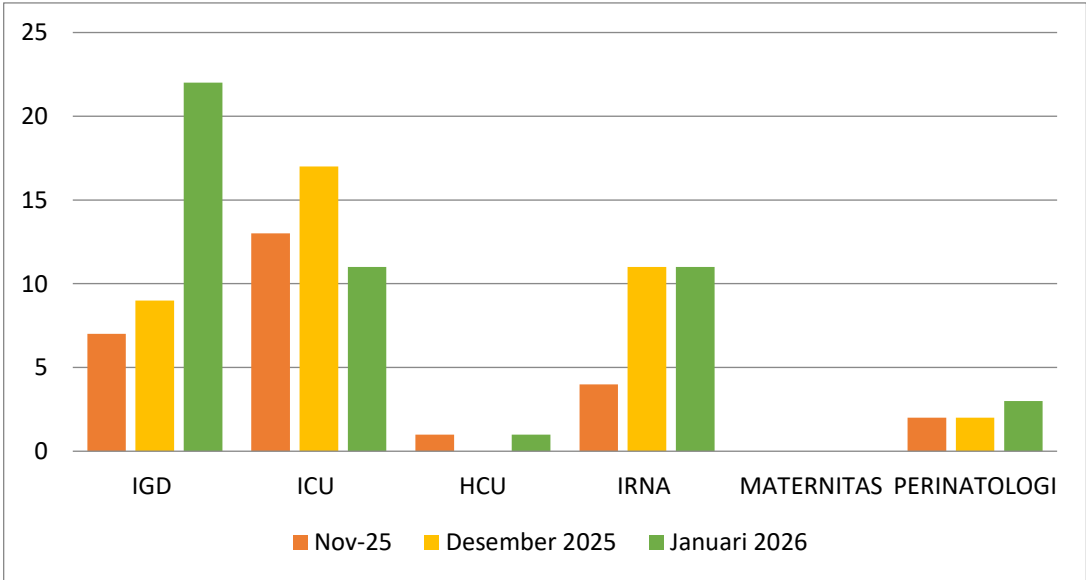
Rencana Tindak Lanjut:

- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Januari 2026

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1.	IGD	7	9	22
2.	ICU	13	17	11
3	HCU	1	0	1
4.	IRNA	4	11	11
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	2	2	3
Total		27	39	48

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Januari 2026



Tabel Rincian Pasien Meninggal Januari 2026

NO TAHUN	NAMA PASIE	LAMA RAWAT	UNIT	PENYEBAB KEMATIAN	DIAGNOSIS	DPJP	EWS
1	Tn. Suwadji	1	ICU	CARDIAC ARREST	DOC EC SEPSIS, ARDS,	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
2	An. Alvito Maulana Uwais	1	IGD	SYOK HIPOVOLEMIK + COB	COB + SUSP FBC	DR FACHRY, SP.BS	√
3	Sdr. Lailatul Anisa	2	HCU	CARDIAC AREST	S. B20+TOXOPLASMA	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	√
4	Suwandi	2	5C	CARDIAC AREST	GANGRENE PEDIS D POST OP DEBRIDEMENT, HERPES REGIO FACIALIS	DR ROSSY ZAKI, SP.B	√
5	Sudiono	1	ICU	CARDIAC AREST	SUSP ILLEUS PARALITIK DD OBSRUKTIF	DR ROSSY ZAKI, SP.B	√
6	Ny. Yayuk Puji Purwati	4	2A	CARDIAC AREST	FEBRIS DT BACTERIAL INFECTION+VERTIGO+DM TIPE 2 HIPERGLIKEMIA+SHOCK CONDITION	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√
7	Ny. Lianah	1	IGD	CARDIAC AREST AC MALIGNANCY	CARDIAC AREST AC MALIGNANCY	DR YENI	√
8	Ny Zustina	1	IGD	CARDIAC AREST	GOUT ATHRITHIS	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	√
9	Tn Paidi	4	2A	CARDIAC AREST	MELENA, CKD ST LV, HEMATEMESIS, HT, ANEMIA	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√
10	An. Ahfifah	1	IGD	DOA	DOA	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	√
11	Tn. Teguh Nugroho Prihantono	1	IGD	CARDIAC AREST	CARDIAC AREST (VP), HF, CAD	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
12	Ny. Tiajah	2	5C	CARDIAC AREST	PNEUMONIA DD TB, HIPERGLIKEMIA, CVA SQUELE	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
13	By Ny Rizki Mega Dian	1	NEO	PREMATURE + MULTIPLE	PREMATURE + MULTIPLE	DR HUMAIRAH, SP.OG	√
14	Tn Sanari	2	ICU	CARDIAC AREST	SUSP. PNEUMONIA+SUSP TB+ANEMIA+LEUKOPENIA+ TROMBOSITOPENIA+ AZOTEMIA+HIPERGLIKEMIA+PNEUMONI A+ SEPSIS+DOC+GAGAL NAPAS TYPE I	DR. ANDY SP. P	√
15	Ny. Nurhayati	2	IGD	CVA ICH	CVA ICH	DR DEWI MAHARANI SP. S	√
16	Ny. Isnaniyah	3	7A	CARDIAC AREST	DM TIPE 2 NEUROPATY+ULKUS INGUINAL SISNISTRA	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
17	Tn. Budi Santoso Pribadi	1	IGD	DOA	DOA	DR ANNISAFIRA	√
18	Ny. Benti	1	IGD	SYOCK	SUSP DIC, HIPOGLIKEMIA	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
19	Ny. Hatminingsih Sudjiwati	4	5C	CARDIAC ARREST	FATTY LIVER CHOLELITHIASIS ULKUS PEDIS D	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
20	Tn. Joko Santoso	2	IGD	SYOCK HEMORAGIC + ICH	COB GCS 121	DR FACHRY, SP.BS	√
21	Tn. Pa'i	3	8A	CARDIAC ARREST	ILEUS OBSTRUKTIF POST OP LAPARATOMY+STOMA	DR ROSSY ZAKI, SP.B	√
22	Ny. Sugiarti	1	ICU	CARDIAC ARREST	SHOCK CONDITION	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	√
23	Tn. Jaelani	1	8A	CARDIAC ARREST		DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	√
24	Ny. Siami	2	IGD	CARDIAC ARREST	CVA 2ND ATTACK	DR AKHMAD SYAHRIR SP N	√
25	Ny. Markati	2	ICU	CARDIAC ARREST	AF, RVR, ADHF, DM, HIPERGLIKEMIA, CVA INFARK	DR IRA SETYA WATY SP JP	√
26	Tn. Margi	1	IGD	CARDIAC ARREST	DOA	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	√
27	Ny. Riami	2	IGD	CARDIAC ARREST	ACUTE ABDOMEN SUSP CHOLELIHIASIS DD GASTRITIS +SUSP CVA ICH + POST FOCAL TO BILATERAL SEIZURE	DR FAHIMMA, SP. N	√
28	Ny. Supiatun	1	IGD	DOA	DOA	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	√
29	By Ny Nufaisah Muniroh	1	NEO	IUFD	IUFD	DR AIDA, SP.OG	√
30	Suharti	1	IGD	CARDIAC AREST	HF + CKD	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	√
31	Tn.Andri	1	IGD	CARDIAC AREST	DOA	DR GANDHA	√

	Ardiansah						
32	Ny. Suyati	4	ICU	CARDIAC AREST	ACUTE RESPIRATORY FAILURE ON VENTILATOR DT PNEUMONIA HAP	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
33	Masngut	1	IGD	DOC MULTIPLE TRAUMA	DOC + COS + FR ZYGOMA DEXTRA + MULTIPLE TRAUMA	DR ROSSY ZAKI, SP.B	√
34	Mohammad Ainul Yaqin	1	IGD	DOA	DOA	DR ENDRA	√
35	Muhajid Kossah	1	IGD	DOC	DOC	DR YENI	√
36	Maksum	3	ICU	CARDIAC AREST	GAGAL NAFAS	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
37	Sutono	6	ICU	CARDIAC AREST	CVA INFARK, DM, EFUSI PLEURA	DR FAHIMMA, SP. N	√
38	Mujianto	3	6A	CARDIAC ARREST	ADHF, ATRIAL TACHYCARDI, HHD + HF REDUCED EF 24,19%, ISK	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
39	Kasemin	2	IGD	PNEUMOTHORAX	PNEUMOTHORAX	DR. ANDY SP. P	√
40	Kusmiati	2	IGD	CARDIAC ARREST	DOC EC DM HIPERGLIKEMIA	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
41	By Ny Siti Fatonah	1	NEO	IUFD	IUFD	DR HUMAIRAH, SP.OG	√
42	Tn. Mulyadi	1	7A	CARDIAC ARREST	CVA INFARK + INFARK CEREBELLUM	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	√
43	Subaniarto	2	IGD	CARDIAC ARREST	STEMI INFEROPOSTERIOR DAN RV INFARCT PADA RBBB	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	√
44	Erfan Ali	2	2A	CARDIAC ARREST	AKUT ABDOMEN SUSP ILEUS	DR ANTON, SP.B	√
45	Keira Zevania Naura	1	IGD	CARDIAC ARREST	DSS	DR DICKY FATURRACHMAN,SPA,M,BIOMED	√
46	Sulastri	3	ICU	CARDIAC ARREST	HEART FAILURE + SEPTIC CONDITION + DIABETIC ULCER BILATERAL + LUNG EDEMA + CKD + DM TIPE 2	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	√
47	Ngatiasih	1	ICU	CARDIAC ARREST	DOC EC SEPSIS	DR ROSSY ZAKI, SP.B	√
48	Ny. Ifa Ujlifatul Azizah	1	ICU	CARDIAC ARREST	SHOCK HIPOVOLEMIA EC ATONIA UTERI POST HISTEREKTOMI	DR HUMAIRAH, SP.OG	√

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Januari 2026 sebanyak 48 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 22 pasien, ICU : 11 pasien IRNA : 11 pasien Neo : 3 pasien
3. Pada bulan Januari 2026 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 10 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Habis PKS	16	7	8
2	BPJS status Denda	63	71	53
3	BPJS status Premi	3	8	6
4	BPJS status Denda dan Premi	0	4	1
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	2	2	2
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	2	0	0
7	BPJS status penanguhan pembayaran	5	3	3
8	Rencana pengurusan BPJS	68	76	85
9	BPJS status tidak ditanggung	2	6	5
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	1	1	1
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	0	0	0

3.5.8 Cleaning Service

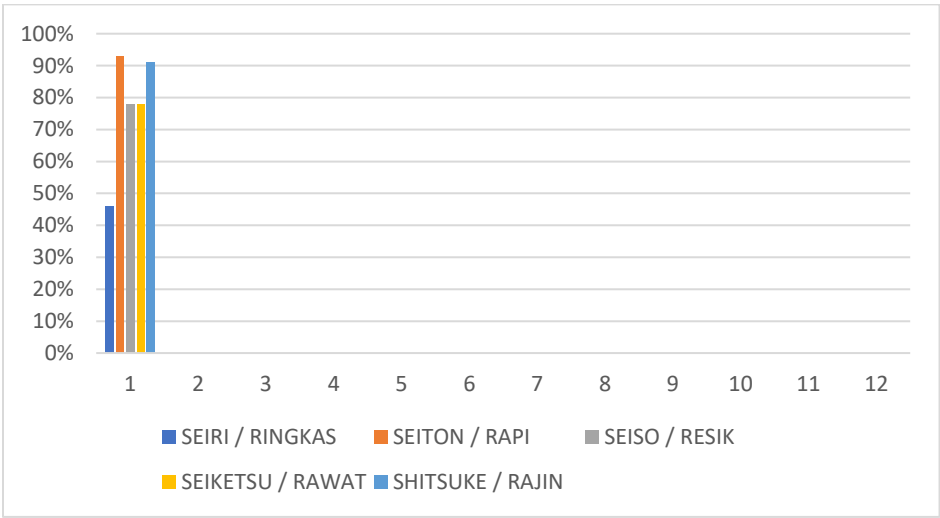
3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal

	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEIRI / RINGKAS	46%											
2	SEITON / RAPI	93%											
3	SEISO / RESIK	78%											
4	SEIKETSU / RAWAT	78%											
5	SHITSUKE / RAJIN	91%											



Analisa :
 Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

No	Unit Asal	Jumlah Barang		Persentase
		Desember	Januari	
1	IGD	4	1	↓-100%
2	MATERNITAS	3	2	↓-50%
3	IKO	2	1	↓-100%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	4	1	↓-100%
7	ICU	2	1	↓-100%
8	IRNA 3A+4A	0	2	↓100%

9	IRNA 3C DEWASA	0	1	↓100%
10	IRNA 4C	0	0	↓0%
11	IRNA 5C	1	0	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	12	5	↓-100%
13	KASIR	5	1	↓-100%
14	DAPUR	6	1	↓-100%
15	POLI	9	6	↓-50%
16	CLEANING SERVICE	6	5	↓-20%
17	IPSRS	5	2	↓-100%
18	GUDANG FARMASI	3	2	↓-50%
19	RUMAH DPM	1	1	↓0%
20	SEKRETARIAT PT	3	1	↓-100%
21	SEKRETARIAT RS	8	2	-↓100%
22	CSSD	2	1	↓50%
23	GIZI	3	1	↓-100%
24	REKAM MEDIS	5	1	↓-100%
25	PENDAFTARAN	4	1	↓-100%
26	DEPO FARMASI	5	4	↓-25%
27	SECURITY	1	1	↓0%
28	LABORATORIUM	5	1	↓-100%
29	RADIOLOGI	6	3	↓-100%
30	FISIOTERAPI	0	1	↓100%
31	IRNA 3C ANAK	1	1	↓0%
32	NS NICU	1	1	↓0%%
33	LAUNDRY	3	0	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	2	↑100%
35	DRIVER	2	1	↓-100%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	4	2	↓-100%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	5	5	↓0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , dan Poli

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

1.3.5.10.1 Pemeliharaan PC Server

Tabel 6. Pemeliharaan PC Server

NO	BULAN	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGA N	DOKUMENTA SI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	server SIMRS 2, CCTV, INACBG, SIMIPSRs, SYNOLOGY, FINGER, NYESHARE, SIDOKAR, FREENAS	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL	4x/tahun					
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI	4x/tahun					
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER	4x/tahun					
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.2 Pemeliharaan Mikrotik

Tabel Pemeliharaan Mikrotik

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
2	FEBRUARI						
3	MARET						

4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.3 Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

Tabel 8. Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	1x/bulan	1x	100%	16/01/2025	Gedung A1, A2, DPM, Gedung B, Gedung C, Maternitas, Gudang Farmasi, Pos Sentral It1, Ruang Serv IT, Parkiran Karyawan, Blok 3, Parkiran Belakang, Server IPCAM	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.4 Pemeliharaan Modem Internet

Tabel 9. Pemeliharaan modem internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2015	Modem Indibiz, D-NET, Biznet, Indihome	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.5 Pemeliharaan Komputer Unit

Tabel Pemeliharaan Komputer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	15PC/Bulan	4x	26%	26/01/2025	Gate Parkir, Server Gate Parkir, Server IPCAM, Irna lantai 2A	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						

8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Target tidak tercapai dikarenakan banyak pekerjaan yg harus di dahulukan contohnya seperti CCTV yang tidak terecord di area rawan, dan kejadian tidak terduga seperti petir yg menyambar alat jaringan (switch hub).

Tindak lanjut : melanjutkan maintenance dibulan berikutnya

3.3.5.10.6 Pemeliharaan Printer Unit

Tabel 11. Pemeliharaan Printer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	1/01/2025	PT, Rekam Medis (managemen t), PDF IGD.	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.7 Perapian Kabel Internet

Tabel Perapian kabel internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/Tahun	1x	25%	2/01/2025	Poli THT, Poli Syaraf 2, Poli Obgyn 2, SPI	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						

5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.8 Perapian Kabel Telepon

Tabel Perapian kabel telepon

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	31/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.9 Pemeliharaan Access Point

Tabel Pemeliharaan access point

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	04/01/2025	Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4.	

							blok 3, Pdf Paru, Lounge loundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
2	FEBRUARI							
3	MARET							
4	APRIL							
5	MEI							
6	JUNI							
7	JULI							
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.10 Pemeliharaan Switch Internet di Setiap Panel dan Unit

Tabel Pemeliharaan switch internet di setiap panel dan unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	09/01/2025	Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1- 5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge loundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPT						

10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.11 Pemeliharaan Modem GSM

Tabel Pemeliharaan modem gsm

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5 10.12 Capaian Kegiatan Lainnya

No	Bulan	Kegiatan	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Januari	Pergantian printer gate in parkir	Tuntas	Vendor	
2	Januari	Intaslasi Server PACS Radiologi	Tuntas	Internal / Vendor	
3	Februari dst				

3.3.5 10.13 Rencana Kegiatan Lainnya

NO	Kegiatan	Target (Bulan)	Hasil	Keterangan
1.	Maintenace pc IRNA dengan instal ulang win 10. Untuk print surat pengantar lab	Februari	Tuntas / Tidak Tuntas	Yang belum : Irna 7a, Irna 8a
2	Melengkapi dokumen dokumen akreditasi bab MRMIK	Maret	Tuntas / Tidak Tuntas	Penambahan umandok diklat pelatihan PPA
3	Penarikan kabel lan internet untuk panel CSO	Februari	Tuntas / Tidak Tuntas	Migrasi kabel dari server lama blok 1

4	Perpindahan kabel Fiber Telkom/Telfon di server lama	Februari	Tuntas / Tidak Tuntas	Kolaborasi dengan Teknisi indihome
5	Perpindahan dan instalasi ulang kabel internet & telfon untuk area poli paru dan lounge	Februari	Tuntas / Tidak Tuntas	Dilakukan internal

3.3.6 Penanganan Keluhan

3.3.6.1 Keluhan Terkait Software

Tabel Keluhan Terkait Software

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	51	51	100%
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.2 Keluhan Terkait Hardware

Tabel 17. Keluhan Terkait Hardware

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	69	69	100%
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			

Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.3 Jenis Keluhan

Tabel Keluhan Spesifik

SPESIFIK	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
PC	13											
PRINTER	17											
SIMRS	4											
JARINGAN INTERNET	60											
TELPON PABX	5											
CCTV	3											
UPS	1											
HP / TAB	3											
CAMERA	2											
KEYBOARD DAN MOUSE	3											
LAINNYA	2											
TOTAL	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.4 Keluhan lain

No	Kegiatan	Jumlah	Hasil	Petugas	Keterangan
1.	Instalasi server PACS	1	Tuntas	Internal	Instal Ubuntu di Komp Backup Untuk kebutuhan Server PACS Radilogi
2	Pindah kabel Fiber Optic indihome untuk telfon	1	Belum tuntas	Vendor	Pindah unit modem dari server blok 1 ke server baru Gedung D

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.5 Progress Peremajaan

Tabel Data PC

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PC RS	JUMLAH PC YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PC YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	188	- 19 pcs	-1 IRNA 2A (pakai pc ex pdf loket 6)	0%	belum dilakukan order PC pada bulan Januari

Tabel Data CCTV

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL CCTV RS	JUMLAH CCTV YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH CCTV YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	100	0	0	0	-

Tabel Data Printer

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PRINTER RS	JUMLAH PRINTER YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PRINTER YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	44		1. Printer etiket parkir get in		Untuk printer tidak dilakukan peremajaan karena akan menerapkan sistem EMR pada seluruh unit RS

3.3.6.6 Downtime

Tabel Laporan Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1	22/01/2026	Tidak Terencana	5 menit	Telkom interdent down gangguan masal	Backup Biznet

3.5.11 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
RUJUK PASIEN KE RS LAIN	47											
RUJUK PASIEN KE RSPHS	0											
JEMPUT RUMAH PASIEN	21											
ANTAR RUMAH PASIEN	22											
SAMPEL LAB	31											
SAMPEL SHK	3											
KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM	8											
KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT	1											
PENGANTARAN JENAZAH	42											
RUJUK CT SCAN	0											
ANTAR MCU RSPHM	0											
LAIN-LAIN	16											
TOTAL	191											

Analisa :
Masih dalam batas normal

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.12 PRIMANTARA

Tabel Jumlah Pengantaran Obat

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	1024
2	FEBRUARI	
3	MARET	
4	APRIL	
5	MEI	
6	JUNI	
7	JULI	
8	AGUSTUS	
9	SEPTEMBER	
10	OKTOBER	
11	NOVEMBER	
12	DESEMBER	
	TOTAL	

Analisa :
Terjadi peningkatan pengantaran pada ulan januari diatas 1000 pengantaran. Hal ini dikarenakan terdapat admin yang mengordinir.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

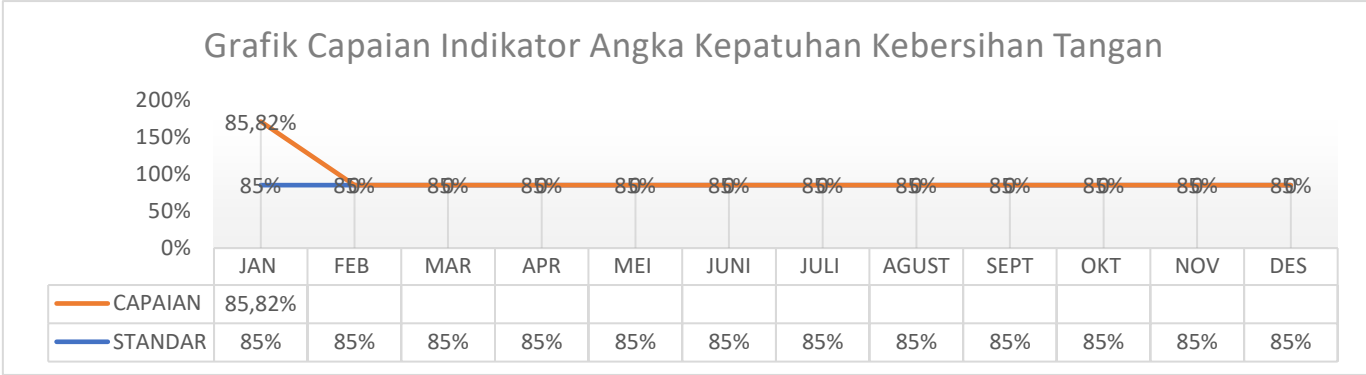
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85.82%												
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96.8%												
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99.96%												
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%												
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89.9%												
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%												
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	66.75%												
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	100%												
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%												
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	31,91%												
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	91.77%												
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%												
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76.61	99.7%												

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

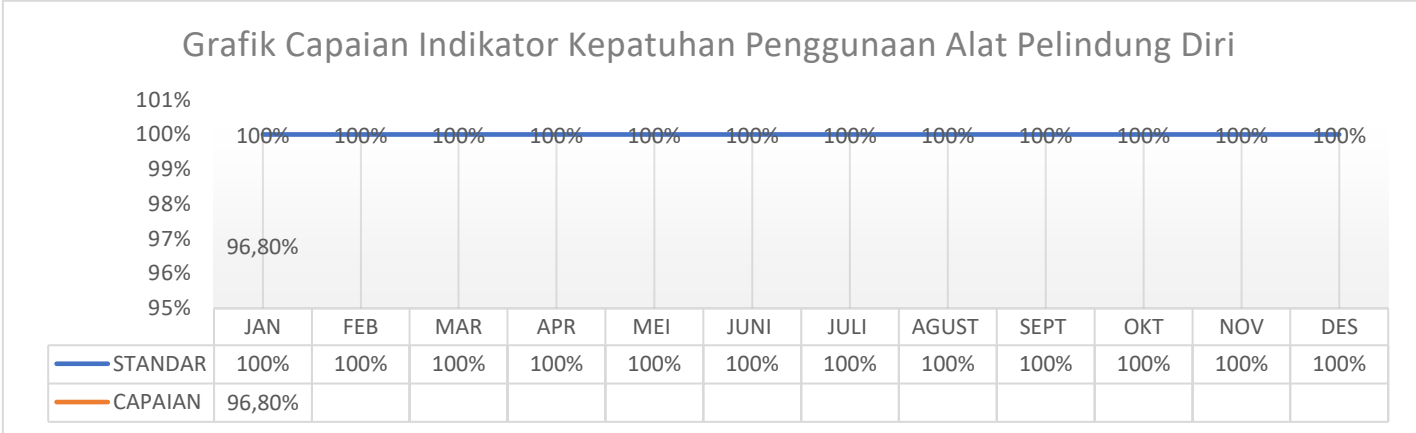
3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Berdasarkan data capaian indikator mutu angka kepatuhan kebersihan tangan di atas dapat diketahui bahwa telah mencapai standart meskipun belum 100%. Penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran petugas. Rencana perbaikan yang akan dilakukan yaitu : sosialisasi ulang 5 moment dan penjadwalan audit kepatuhan secara rutin.				
DO	1. Melakukan edukasi kebersihan tangan kepada seluruh petugas 2. Memastikan handrub tersedia dan terisi 3. Melakukan observasi kepatuhan kebersihan tangan 4. Memberikan teguran langsung saat ditemukan ketidakpatuhan				
STUDY	Capaian indikator mutu angka kepatuhan kebersihan tangan pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 85.82%, dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian telah mencapai standart meskipun belum 100%. Penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran petugas.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1 Menetapkan kebersihan tangan sebagai budaya keselamatan pasien 2 Memberikan umpan balik hasil audit ke unit terkait 3 Penguatan edukasi pada unit dengan kepatuhan rendah 4 Melanjutkan audit rutin dan menjadikan PDSA sebagai siklus berkelanjutan	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

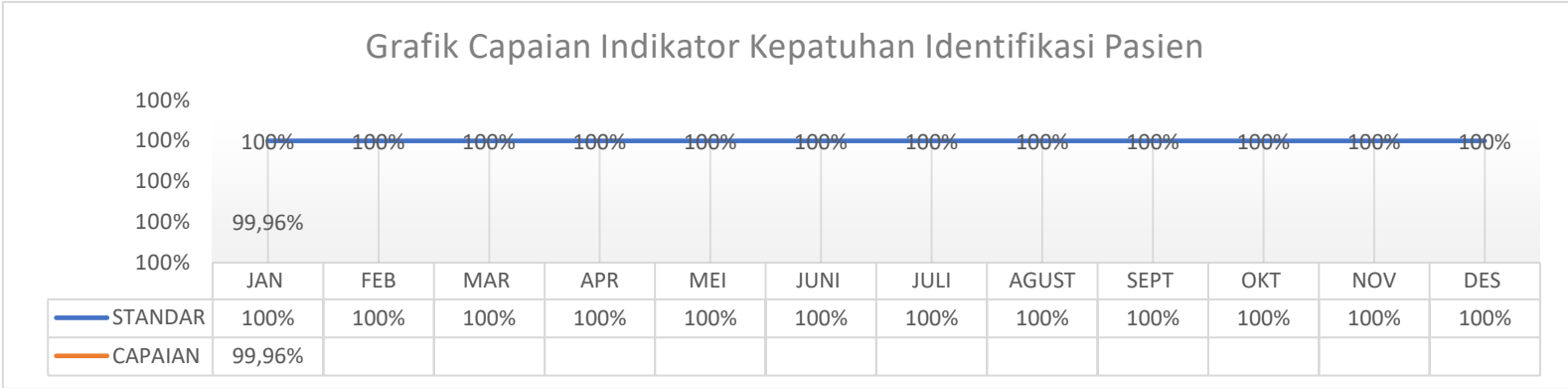
3.7.8 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



PLAN	Berdasarkan data indikator mutu kepatuhan penggunaan alat pelindung diri oleh petugas di atas dapat diketahui bahwa capaian belum mencapai standart. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan kedisiplinan petugas, pemahaman jenis APD belum optimal. Rencana perbaikan yang dilakukan adalah sosialisasi ulang SPO penggunaan APD, edukasi jenis APD, memastikan ketersediaan APD, meningkatkan monitoring dan supervisi.				
DO	1.Melaksanakan edukasi penggunaan APD kepada seluruh petugas 2.Menyediakan APD sesuai kebutuhan dan risiko pelayanan 3. Melakukan observasi kepatuhan penggunaan APD dengan lembar audit 4. Memberikan teguran dan edukasi langsung saat ditemukan ketidakpatuhan				
STUDY	Capaian indikator kepatuhan alat pelindung diri oleh petugas pada bulan Januari yaitu 96.80%. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian belum mencapai standart. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan kedisiplinan petugas, pemahaman jenis APD belum optimal. Rencana perbaikan yang dilakukan adalah sosialisasi ulang SPO penggunaan APD, edukasi jenis APD, memastikan ketersediaan APD, meningkatkan monitoring dan supervisi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1 Memberikan umpan balik hasil audit kepada unit terkait 2 Penguatan edukasi dan supervisi pada unit dengan kepatuhan rendah 3 Penegakan disiplin sesuai kebijakan RS 4 Menjadikan monitoring penggunaan APD sebagai kegiatan rutin dan berkelanjutan	1. Kepala ruangan dan IPCN 2. Kepala ruangan 3. Kepala Bidang	Satu Bulan

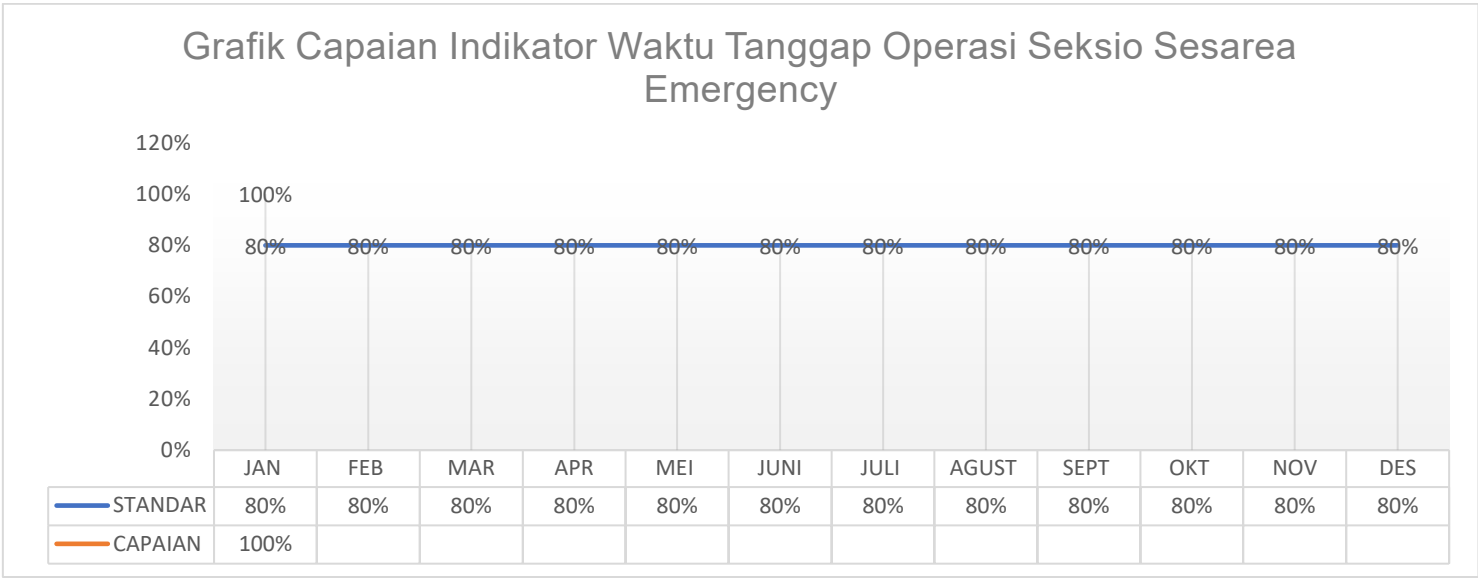
3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.7.9 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



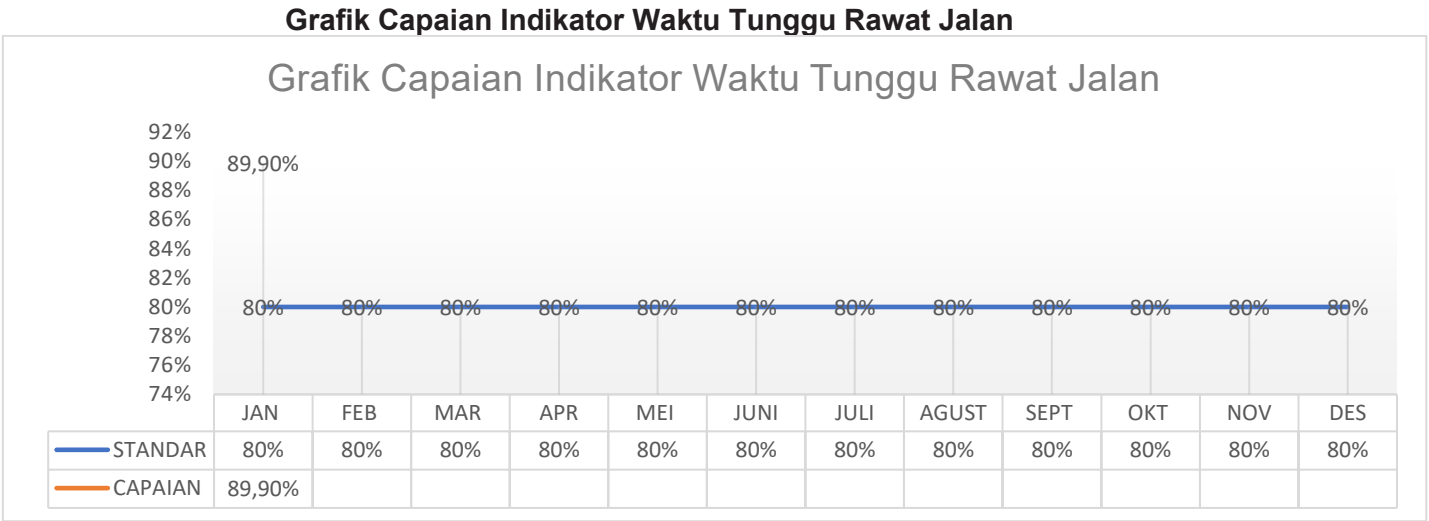
PLAN	Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 99.96% yang artinya belum mencapai standart, hal ini disebabkan petugas tidak selalu melakukan identifikasi dengan 2 identitas dan kurangnya kesadaran terhadap risiko keselamatan pasien.				
DO	1. Melaksanakan edukasi identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan 2. Memastikan pasien menggunakan gelang identitas sesuai standar 3. Melakukan observasi langsung kepatuhan identifikasi pasien sebelum tindakan, pemberian obat, dan pengambilan spesimen 4. Memberikan edukasi langsung bila ditemukan ketidaksesuaian				
STUDY	Capaian indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 99.96% yang artinya belum mencapai standart, hal ini disebabkan petugas tidak selalu melakukan identifikasi dengan 2 identitas dan kurangnya kesadaran terhadap risiko keselamatan pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1 Memberikan umpan balik hasil audit kepada unit terkait 2 Penguatan supervisi dan edukasi ulang pada unit dengan kepatuhan rendah 3 Penegakan disiplin sesuai kebijakan rumah sakit 4 Menjadikan identifikasi pasien sebagai budaya keselamatan pasien	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari tahun 2026 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi faktor tercapainya indikator waktu tanggap operasi SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun berikutnya.

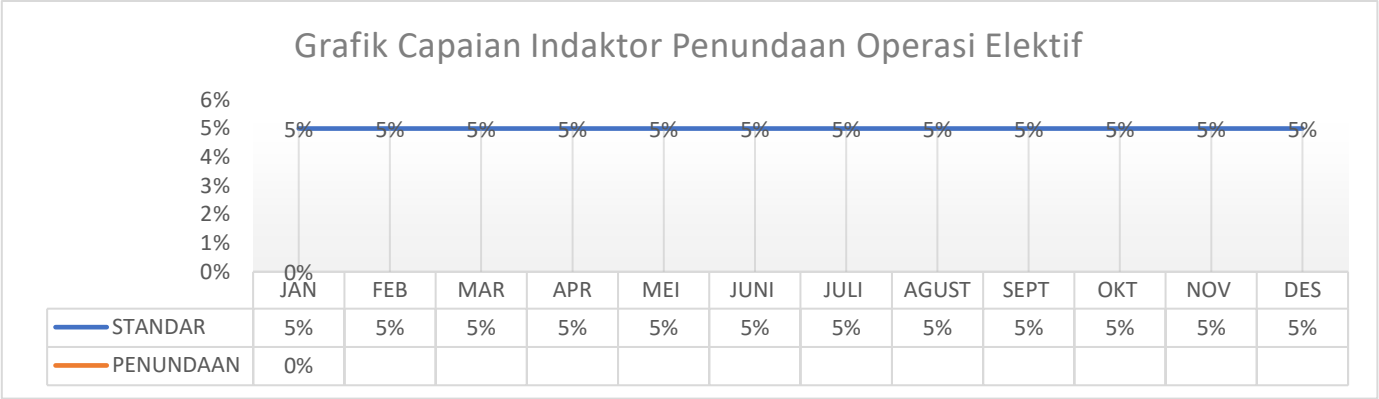
3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator mutu waktu tunggu rawat jalan di atas dapat diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 89.90%. Capaian belum maksimal 100% karena pendaftaran menumpuk pada jam jam tertentu dan masih ada keterlambatan kedatangan dokter. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah opyimalisasi sistem antrean dan pendaftaran online dan penyesuaian jam praktik dokter.				
DO	1. Melakukan sosialisasi alur pelayanan rawat jalan 2. Mengoptimalkan pendaftaran online dan sistem antrean 3. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter 4. Pengaturan jam pelayanan berdasarkan pola kunjungan pasien				
STUDY	Capaian waktu tunggu rawat jalan di bulan Januari yaitu 89.90%. Capaian belum maksimal 100% karena pendaftaran menumpuk pada jam jam tertentu dan masih ada keterlambatan kedatangan dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan	Tercapainya indikator waktu tunggu rawat jalan hingga 100%	1. Memberikan umpan balik kepada unit dan dokter terkait 2. Penyempurnaan alur pelayanan rawat jalan 3. Penyesuaian jadwal dan jumlah petugas secara berkelanjutan 4. Monitoring rutin waktu tunggu sebagai indikator mutu prioritas	Manajemen	Satu Bulan

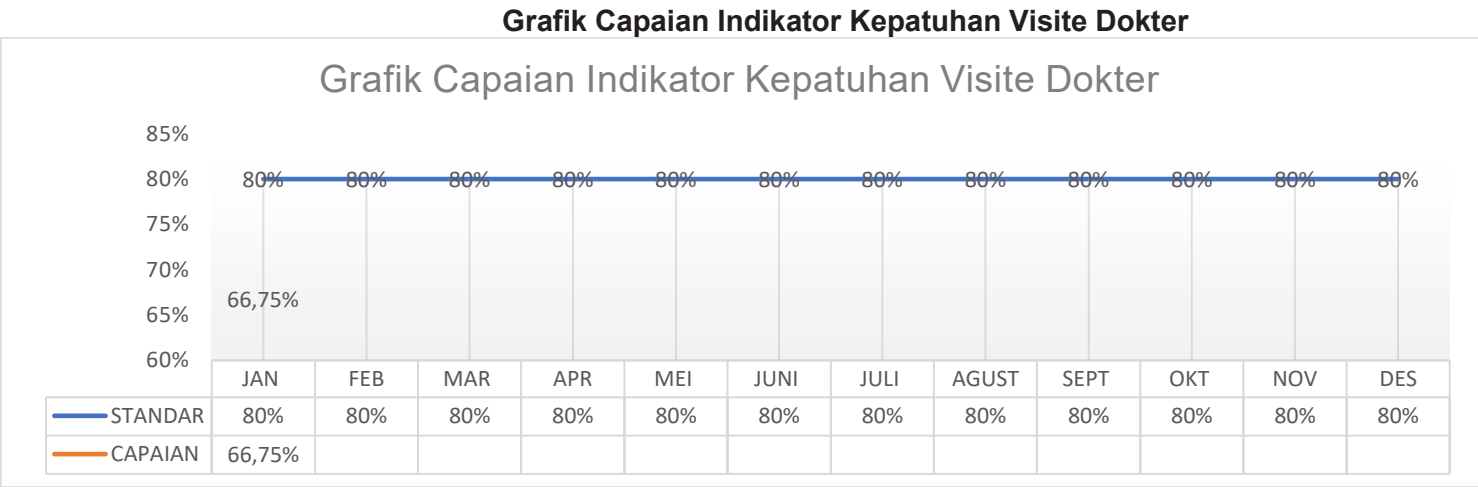
3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.7.10 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari tahun 2026 diketahui capaian telah mencapai standart, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif , perencanaan yang matang dari segi SDM, alat dan ruang operasi juga telah dilakukan guna meminimalisir terjadinya penundaan operasi elektif.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

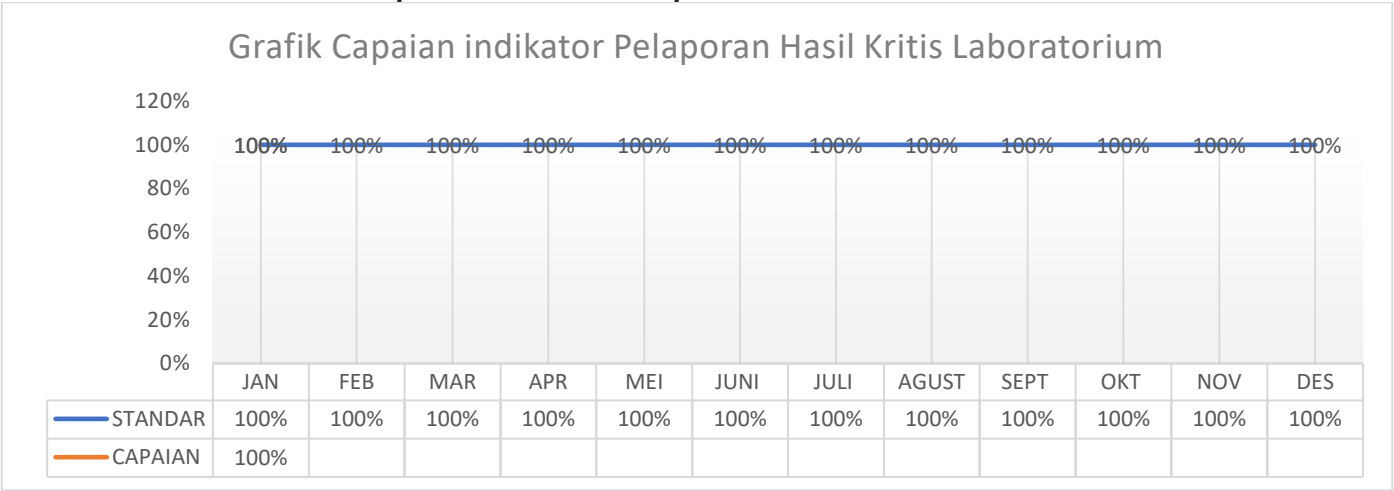


PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite dokter dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari tahun 2026 yaitu 66.75%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang. Rencan aperibaikan yang akan dilakukan adalah penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.				
DO	1. Penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati 2. Koordinasi perawat dengan DPJP terkait jadwal visite 3. Monitoring pelaksanaan visite oleh manajemen/unit terkait				
STUDY	capaian indikator kepatuhan visite dokter di bulan Januari tahun 2026 yaitu 66.75%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang. Rencan aperibaikan yang akan dilakukan adalah penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	1. Memberikan umpan balik hasil monitoring kepada DPJP dan unit terkait 2. Penyesuaian jadwal dan sistem koordinasi visite 3. Penguatan komitmen DPJP terhadap standar pelayanan	Manajemen RS	Satu Bulan
--	--	---	--	--------------	------------

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



Berdasarkan data capaian indikator mutu pelaporan hasil kritis laboratorium di atas, dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari tahun 206 telah mencapai standart 100%. Kegiatan yang akan terus kami lakukan yaitu sosialisai kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis, penguatan alur komunikasi hasil kritis dan menjadikan pelaporan hasil kritis sebagai budaya keselamatan pasien.

3.6.1.1.3 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

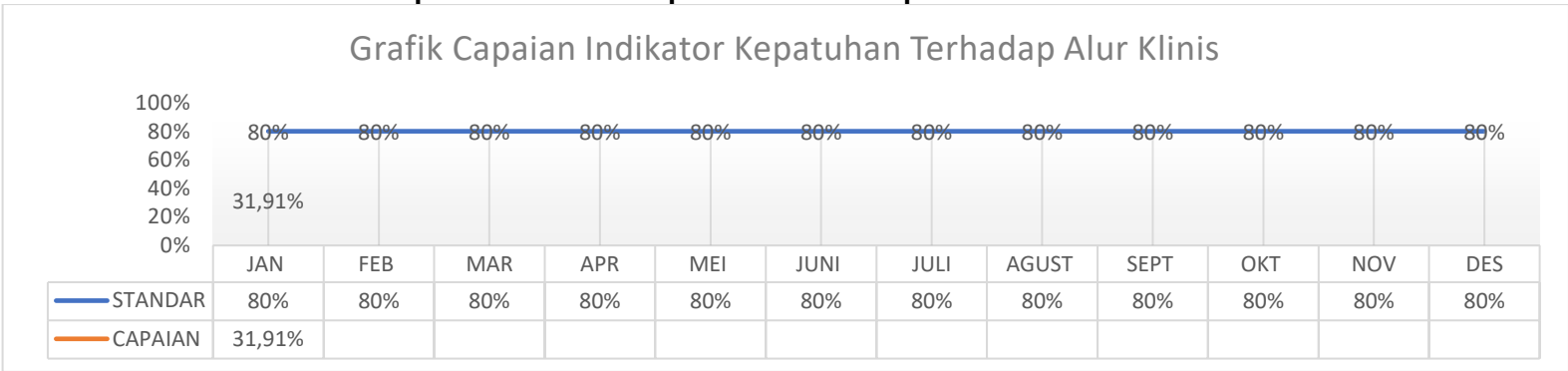
Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari tahun 2026 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Adanya payung hukum yang kuat, seperti Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional, memberikan landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan juga menjadi faktor yang membuat rumah sakit wajib mematuhi standart formularium nasional. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026.

3.6.1.1.4 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

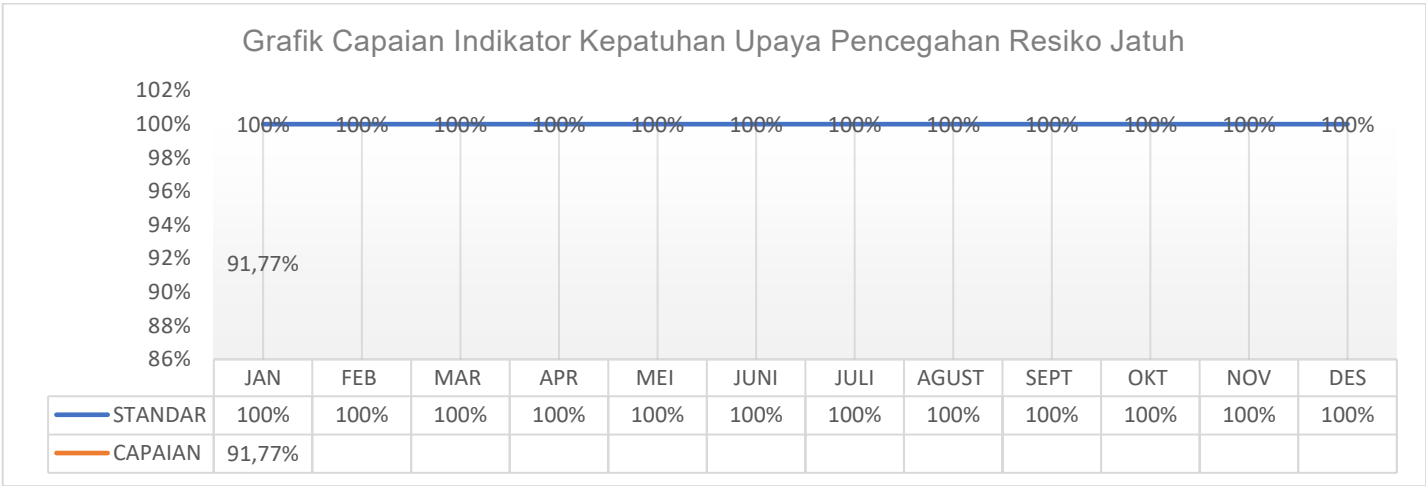
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



PLAN	Berdasarkan grafik capaian kepatuhan terhadap alur klinis diatas, dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari yaitu 31.91%. Hal ini disebabkan karena kepatuhan tenaga medis dalam menerapkan Clinical pathway belum optimal, dokumen CP belum terintegrasi dengan rekam medis, monitoring dan evaluasi CP belum rutin. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi dan refresh clinical pathway kepada DPJP dan PPA dan Standarisasi penggunaan CP serta audit kepatuhan CP secara berkala.				
DO	1. Melaksanakan edukasi penggunaan CP kepada DPJP dan tim PPA 2. Menerapkan CP pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan 3. Melakukan pengisian CP secara lengkap dan tepat waktu 4. Supervisi penerapan CP oleh komite medis / PMKP				
STUDY	Capaian di bulan Januari yaitu 31.91%. Hal ini disebabkan karena kepatuhan tenaga medis dalam menerapkan Clinical pathway belum optimal, dokumen CP belum terintegrasi dengan rekam medis, monitoring dan evaluasi CP belum rutin. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi dan refresh clinical pathway kepada DPJP dan PPA dan Standarisasi penggunaan CP serta audit kepatuhan CP secara berkala.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis	Indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standrt	1. Melaksanakan edukasi penggunaan CP kepada DPJP dan tim PPA 2. Menerapkan CP pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan 3. Melakukan pengisian CP secara lengkap dan tepat waktu 4. Supervisi penerapan CP oleh komite medis / PMKP	Manajemen RS	Satu Bulan

3.6.1.1.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

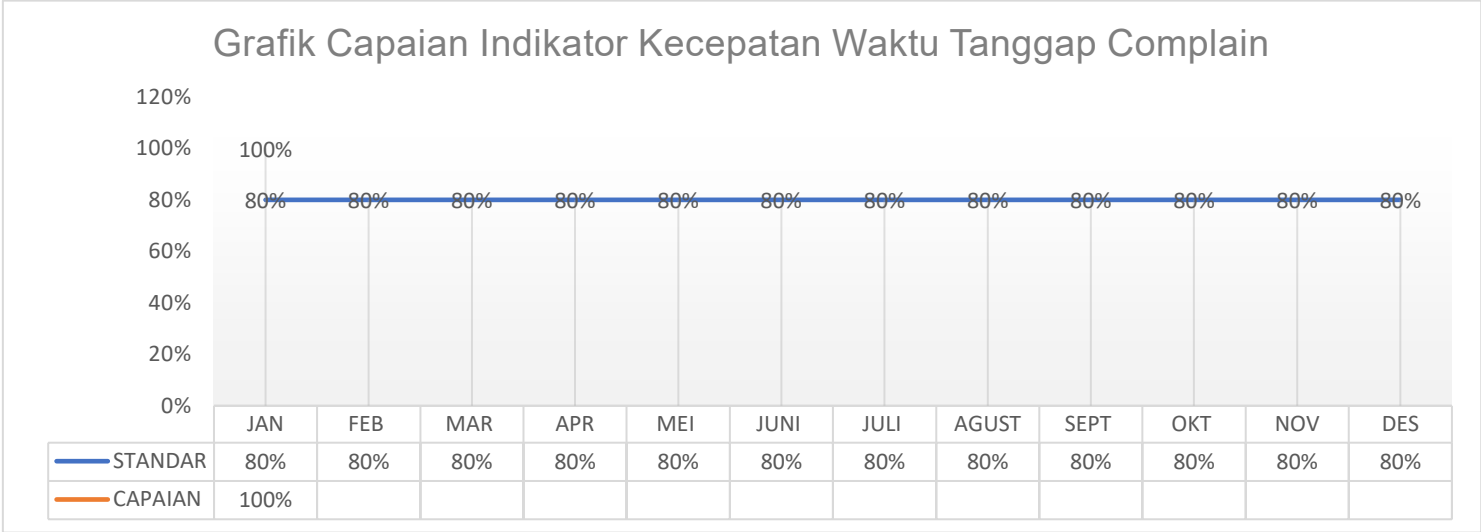
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 91.77%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.				
DO	1. Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala 2. Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) 3. Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko 4. Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh				
STUDY	Capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 91.77%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	1. Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala 2. Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) 3. Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko 4. Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh	Perawat instalasi rawat inap	5. Satu Bulan
--	--	--	--	------------------------------	---------------

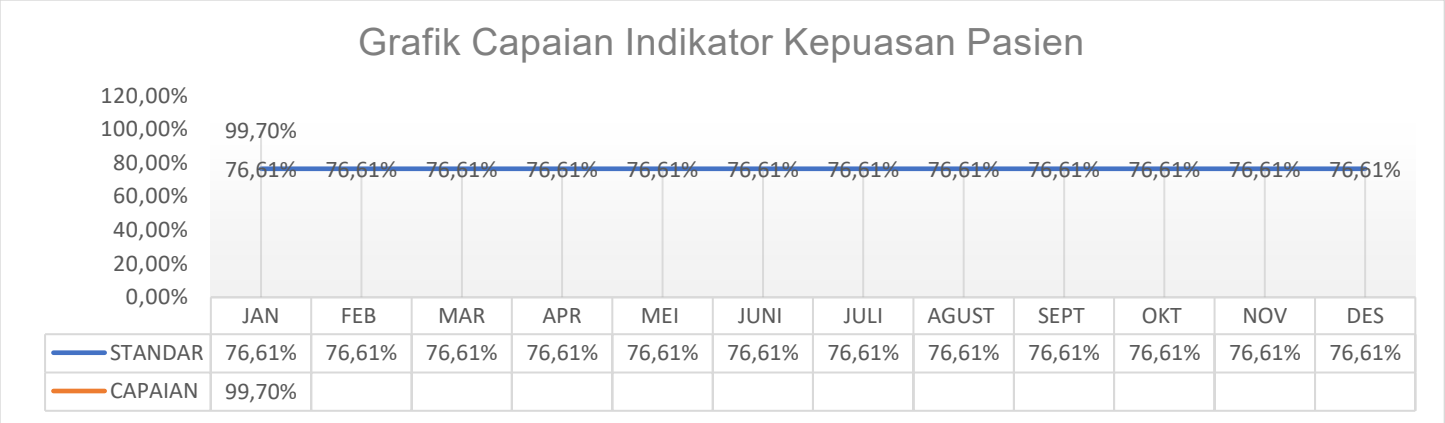
3.6.1.1.6 **Kecepatan Waktu Tanggap Komplain**
Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari tahun 2026 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa melalui tlp, WA dan formulir online. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

1.6.1.1.12.1 Kepuasan Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepuasan pasien dapat diketahui capaian di bulan Januari tahun 2026 yaitu 99.7%. Capaian telah mencapai standart walaupun belum maksimal 100%. Masih di dapatkan komplain terkait komunikasi petugas yang tidak efektif serta kenyamanan yang kurang optimal. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah evaluasi hasil survey dan kepuasan, peningkatan komunikasi efektif dan pelayanan prima.				
DO	1. Memberikan edukasi pelayanan prima kepada petugas 2. Menindaklanjuti keluhan dan saran pasien 3. Perbaikan layanan berdasarkan masukan pasien				
STUDY	Capaian indikator kepuasan pasien dapat diketahui capaian di bulan Januari tahun 2026 yaitu 99.7%. Capaian telah mencapai standart walaupun belum maksimal 100%. Masih di dapatkan komplain terkait komunikasi petugas yang tidak efektif serta kenyamanan yang kurang optimal. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah evaluasi hasil survey dan kepuasan, peningkatan komunikasi efektif dan pelayanan prima.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian Indikator Kepuasan Pasien	Meningkatkan capaian Indikator Kepuasan Pasien	Peningkatan capaian indikator kepuasan pasien	1. Memberikan edukasi pelayanan prima kepada petugas 2. Menindaklanjuti keluhan dan saran pasien 3. Perbaikan layanan berdasarkan masukan pasien	Seluruh layanan	6. Satu Bulan

3.6.2 IKP JANUARI 2026

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		JENIS IKP	KRONOLOGI	RENCANA TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
1	6 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulakn risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu “lantai basah” - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
2	8 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulakn risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu “lantai basah” - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
3	14 Januari		2C	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulakn risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu “lantai basah” - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
4	19 Januari	dr. Yuniar Ardi San	IGD	KTC	Anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak sesuai	Penguatan supervisi dokter IGD
5	19 Januari	dr. Naufal, Laras	Farmasi	KTC	Kesalahan input e-resep	

6	19 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu “lantai basah” - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
7	26 Januari	Laras, Noviati, Ria	Farmasi	KTC	Kesalahan pemberian obat	- Refresh SOP e-resep - Double check sebelum validasi resep - Edukasi keselamatan obat
8	28 Januari	Iqbal	IRNA 234A	KPC	Tidak melakukan advice dokter sesuai jam yang di advicekan	- Penguatan komunikasi DPJP & perawat - Monitoring pelaksanaan advice - Edukasi patient safety

1.6.1 Komite PPI

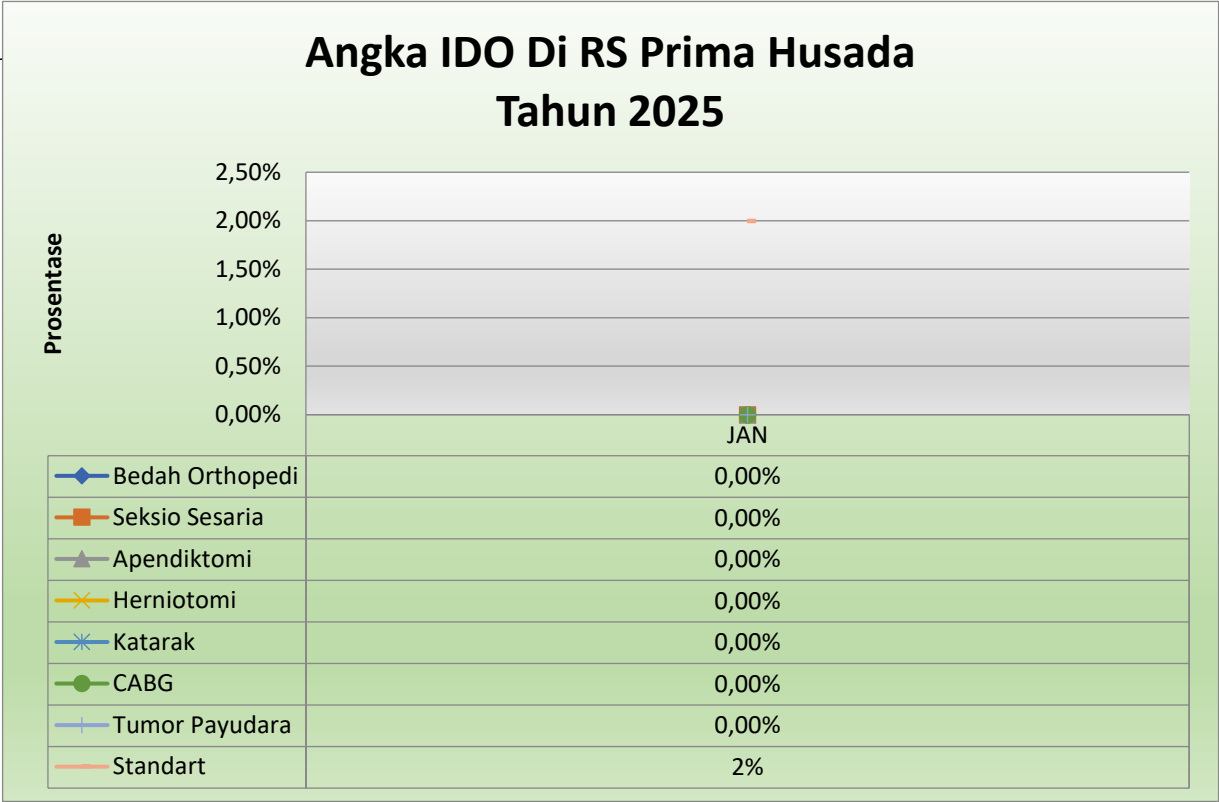
1.6.1.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.1.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

SSI 2026	Bedah Orthopedi	Seksio Sesaria	Apendiktomi	Herniotomi	Katarak	CABG	Tumor Payudara
Januari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	88	73	6	15	46	-	13
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Secara keseluruhan angka IDO pada masing-masing jenis tindakan operasi adalah 0%, yang menunjukkan capaian indikator berada dalam kategori baik dan telah memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit. Namun masih perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan under reporting.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kasus IDO.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kasus IDO sebelumnya.				
Tindakan yang dilakukan	• Monitoring rutin bundle/pencegahan SSI. • Monitoring kepatuhan Hand hygiene. • Monitoring pasien operasi dan dokumentasi rekam medis pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan).	• Mempertahankan angka IDO ≤2% serta menjamin kekakuratan sistem surveilans.	• Tim Bedah, perawat kamar operasi, perawat IRNA/IGD/IRJA.	• Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan). • Menjalankan audit bundle SSI dengan baik. • Menjalankan kepatuhan pemberian antibiotik profilaksis. • Meningkatkan edukasi PPI kepada tenaga kesehatan dan kepada pasien/keluarga.	• Komite PPI, Kepala ruang, dokter operator, dan manajemen mutu.	• Monitoring bulanan
• Pertahankan bundle IDO berjalan dengan baik.	• Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	• Pasien operasi	• Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. • Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) • Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. • Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Monitoring bulanan
• Pertahankan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan	• Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	• Pasien post operasi.	• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. • Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan	• Perawat /Bidan • Karu • IPCLN/IPCN	• Monitoring bulanan

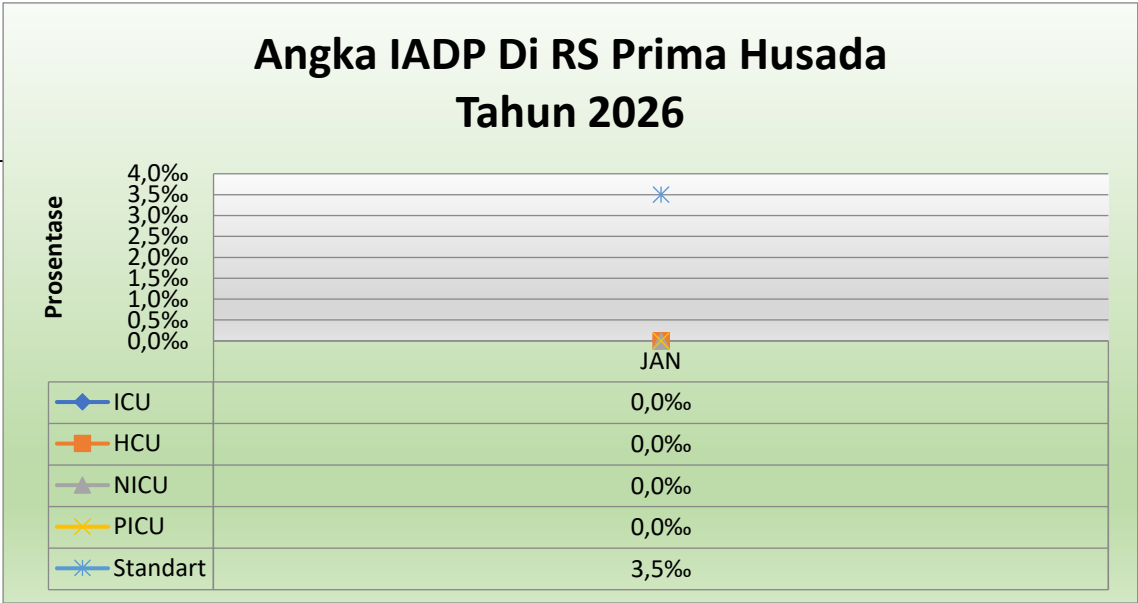
pasien pasca operasi			komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-pesan-media-feed back) • Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. • Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. • Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.		
----------------------	--	--	--	--	--

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

IADP 2026	ICU	HCU	NICU	PICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

3.7.11 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



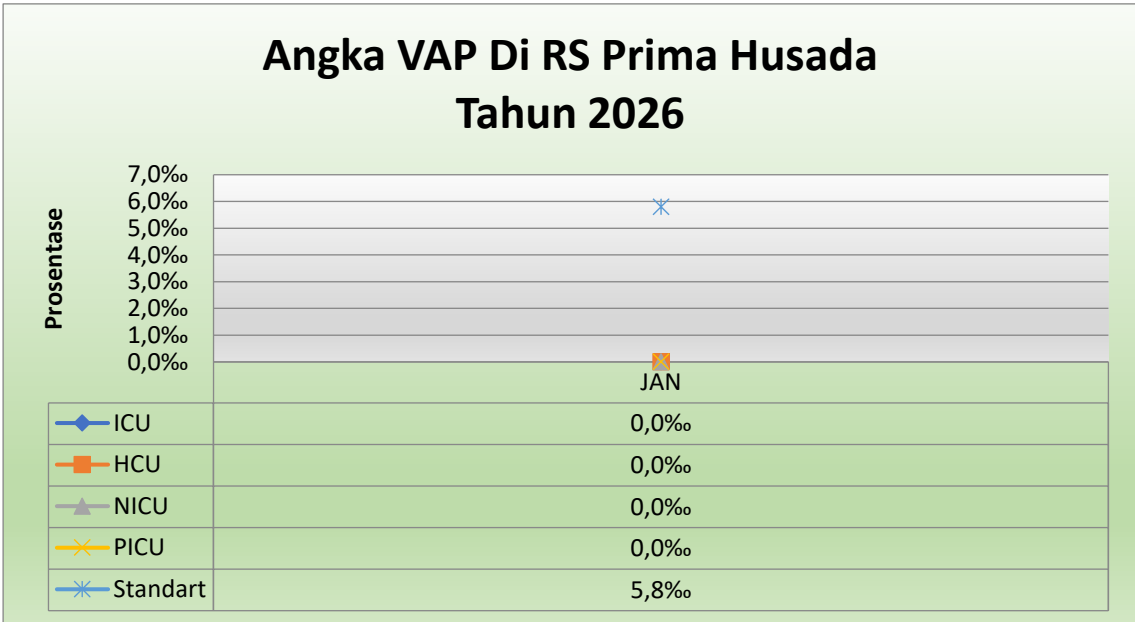
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP karena tidak ada tindakan pemasangan CVC.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	- Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. - Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Melakukan monitoring - perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

VAP 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	86	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)

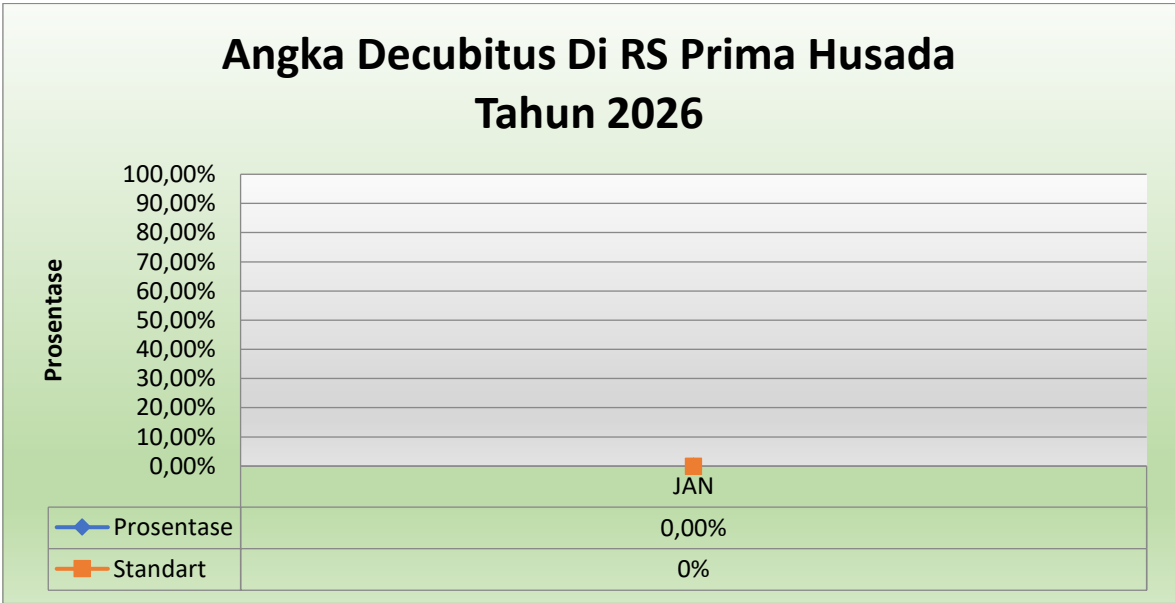


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 86 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. • Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. • Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. • Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. • Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKT U
• Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	• Pasien yang terpasang ventilator mekanik	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPC N	• Satu bulan

Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1278 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. • Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	• Pasien yang terpasang kateter	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

1.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus

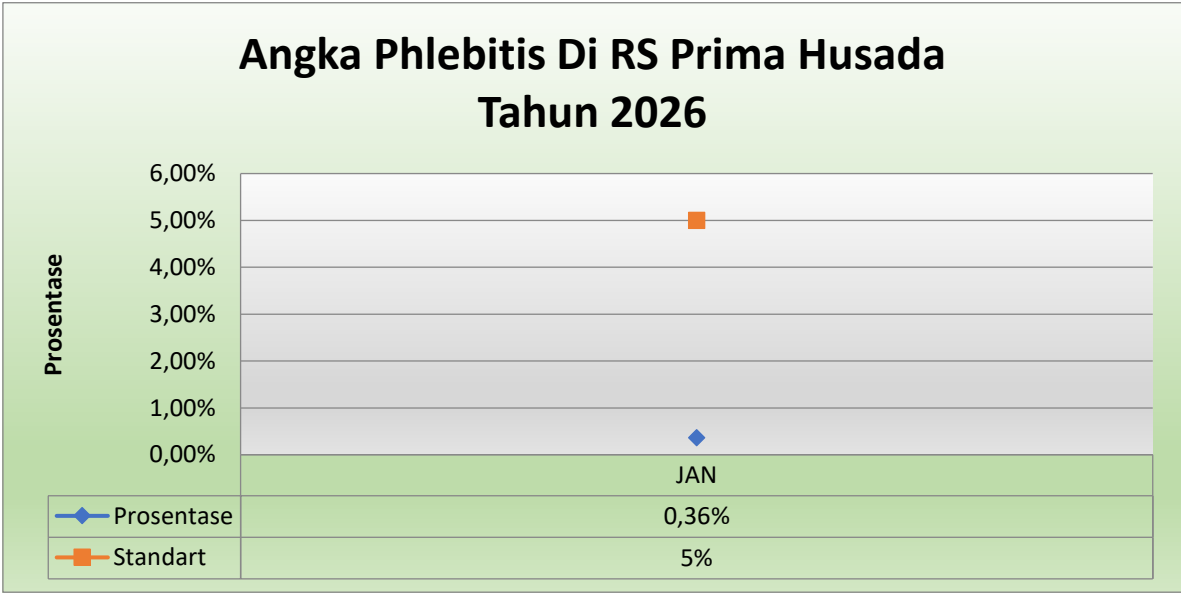


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 51 pasien tirah baring lama.
Masalah saat ini	• Tidak terjadi decubitus
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi decubitus

Tindakan yang dilakukan	- Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. - Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). - Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. - Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). - Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain - Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. - Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCN	Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.13 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

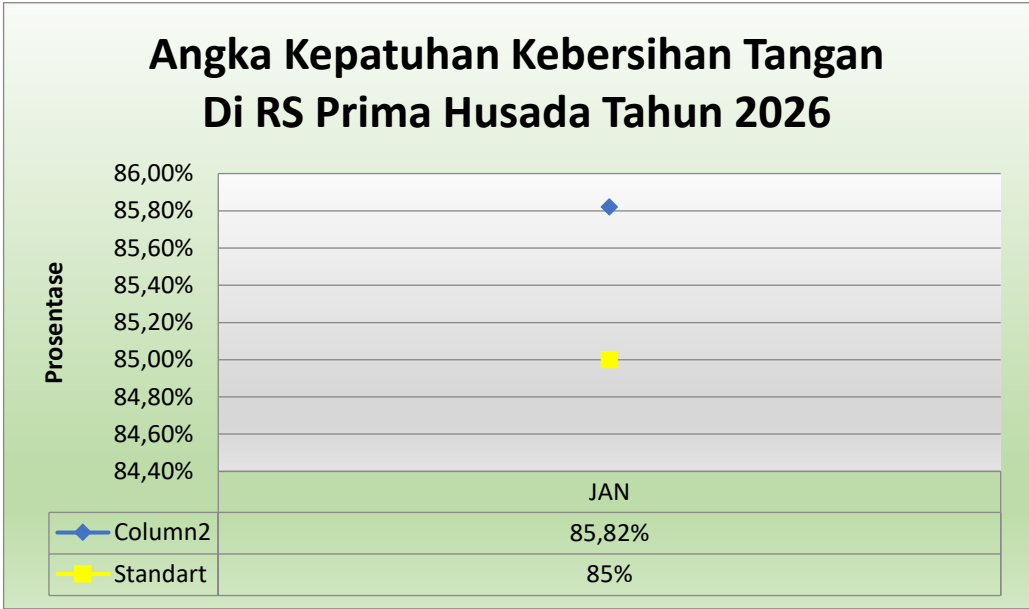


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2815 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,36%, masih memenuhi standar nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan infeksi dan perawatan akses intravena pada bulan Desember berjalan optimal. Rendahnya angka phlebitis peningkatan pada perawatan infus, serta pelaksanaan monitoring rutin lokasi insersi. Selain itu, efektivitas kolaborasi antara Komite PPI dan Komite Keperawatan, dengan adanya pembinaan serta monitoring berkala turut berkontribusi terhadap penurunan angka phlebitis. Kondisi pada bulan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif dan penguatan kepatuhan yang telah dilakukan memberikan hasil positif. Dari data yang diperoleh terdapat 10 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif tanpa pengenceran optimal, pemberian transfusi darah. Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	- Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. - Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Permasalahan sebelumnya	- Pengenceran obat kurang optimal dan kurang terkontrol di ruangan. - Teknik pemasangan infus yang tidak seragam, serta perawatan yang kurang optimal.				
Tindakan yang dilakukan	- Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. - Memberikan edukasi pada pasien setelah pemasangan infus terutama pada pasien yang beresiko tinggi phlebitis karena faktor internal. - Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. - Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. - Menganjurkan perawat untuk terus mengingatkan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	- Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. - Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. - Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. - Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. - Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. - Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

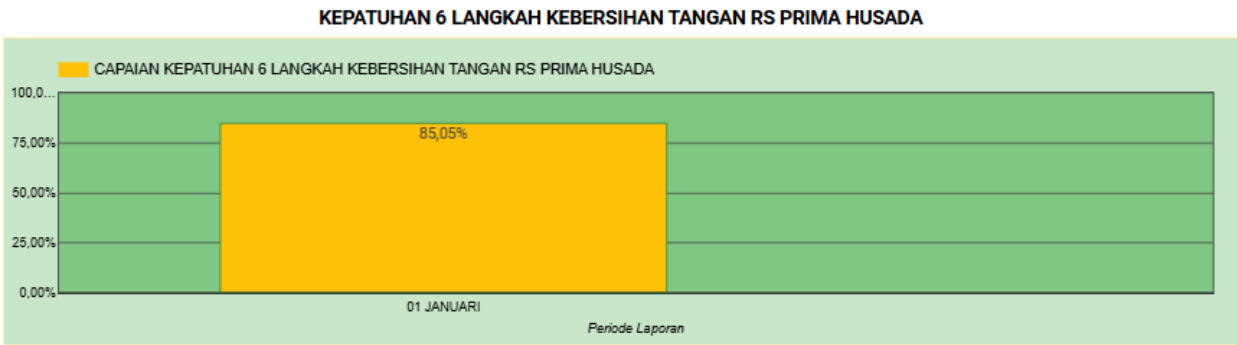
Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.	Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.	- Perawat/bidan - Apoteker	- Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi. - Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat. - Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.	- Perawat /Bidan - Apoteker - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan
Perbaikan Proses Pemasangan & Perawatan Infus	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Perawat/bidan	- Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi). - Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat yang belum mandiri memamsang infus. - Audit kepatuhan perawatan VAP & manajemen infus setiap bulan. - Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Tiga bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

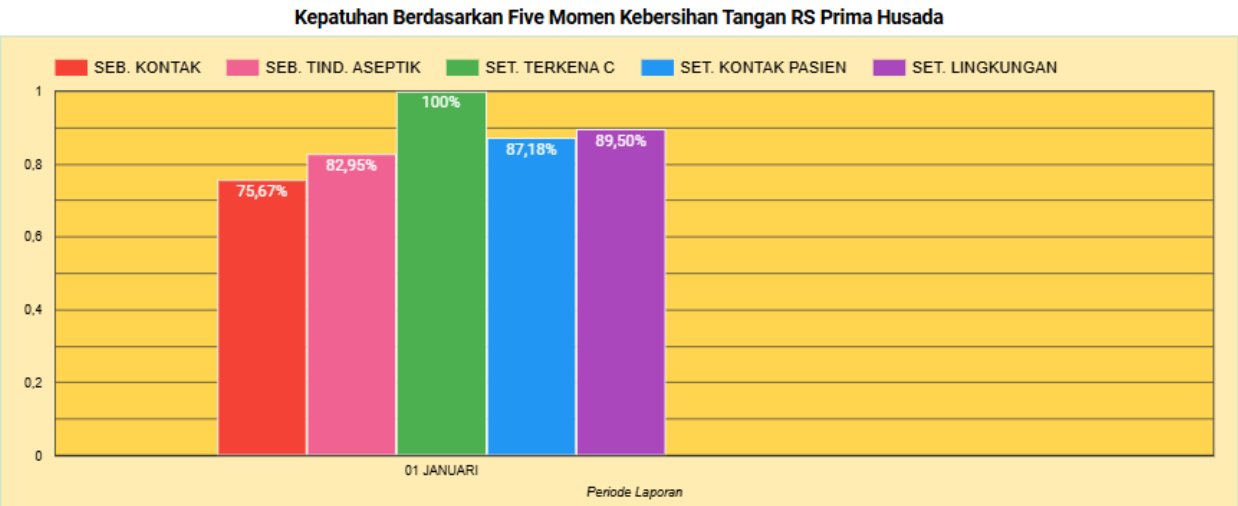
3.7.14 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

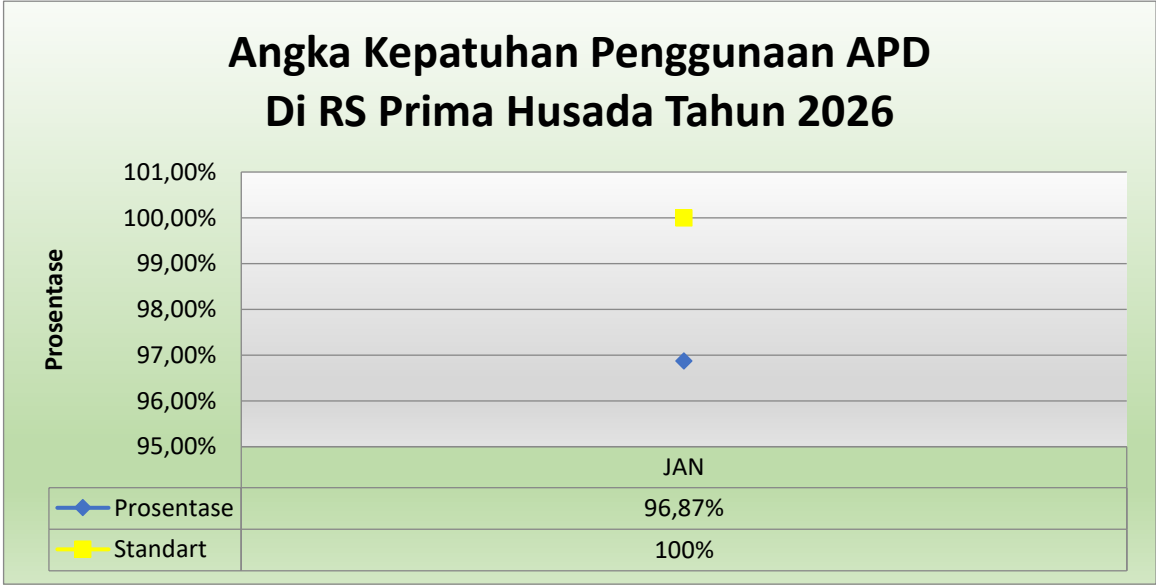


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan Desember 2025 berada sedikit di atas standar (selisih +0,82%). Meskipun masih memenuhi standar, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan, yang berarti ada sedikit peningkatan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat. Nilai kepatuhan terhdap 6 langkah cuci tangan pada bulan ini: 85,05%. Nilai ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya (Desember 2025: 84,61%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Peningkatan ini bisa mencerminkan peningkatan perhatian terhadap teknik yang benar dan peningkatan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, bukan hanya peningkatan frekuensi mencuci tangan saja. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan ini sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan. Selain itu dengan adanya program "PPI Quick Tips" diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.				
Masalah saat ini	• Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal. • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Memberikan contoh cara cuci tangan yang benar saat mengisi diklat KE. • Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien. • Menerapkan program "PPI Quick Tips" untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	- Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. - Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. - Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. - Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan
Lanjutkan audit kepatuhan secara acak dan supervisi pengamatan rutin.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Petugas kesehatan	- Melakukan audit mendadak (spot check) agar kebiasaan cuci tangan terpantau tanpa pengaruh pengawasan langsung. - Kepala ruangan dan IPCN melakukan pemantauan harian terutama pada shift pagi & sore. - Memberikan feedback cepat ketika ditemukan ketidaksesuaian.	- Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

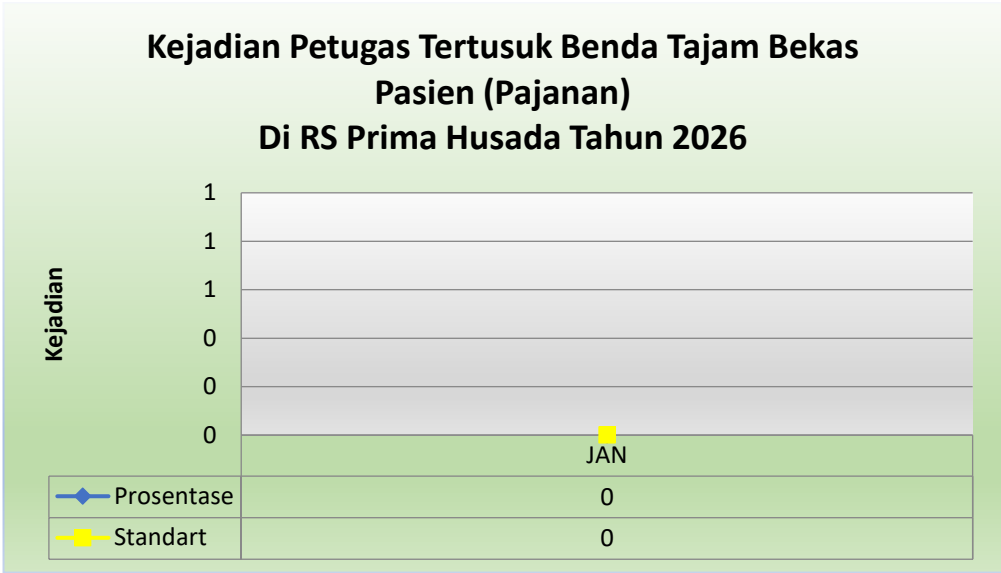


Analisa	Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan hasil pada bulan ini 96,87%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak lengkap atau tidak sesuai indikasi. Terjadi peningkatan pada bulan ini, menunjukkan adanya: perbaikan perilaku penggunaan APD, meningkatnya kesadaran staf, atau pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Meskipun meningkat, nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan berlebihan menggunakan APD. Perubahan
---------	--

	perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat.				
Masalah saat ini	• Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakkonsistenan penggunaan APD antar shift dan antar unit. • Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. • Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Penguatan budaya keselamatan dengan melakukan briefing harian dengan pesan wajib: “APD lengkap sebelum kontak dengan pasien atau cairan tubuh.” • Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. • Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. • Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. • Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. • Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Audit kepatuhan harian per shift, IPCN/kepala ruangan/IPCLN/PJ Shift melakukan audit: pagi, sore, malam, minimal 3–5 observasi per shift. Catat petugas dengan angka kepatuhan rendah untuk ditindaklanjuti pada evaluasi kinerja.	• Seluruh petugas pelayanan di RS.	• Satu bulan

3.6.1.1.9 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.9.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Tidak ditemukan kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Tindakan yang dilakukan	- Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar. - Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. - Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan. - Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam. - Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko pajanan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	- Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. - Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. - Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. - Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

Unit	Target	Okt	Nov	Jan	%	MANDOK	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 2C Mencapai Target
ICU\HCU	4x/Bulan	75%	100%	50%	Menurun	Lampiran B	ICU/HCU Tidak mencapai target
IRNA 3C	4x/Bulan	50%	0%	100%	Menurun	Lampiran B	IRNA 3C Mencapai target
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	100%	100%	Menurun	Lampiran B	MATERNITAS Mencapai Target
PERINATOLOGI	4x/Bulan	25%	100%	100%	Menurun	Lampiran B	PERINATOLOGI Mencapai Target
IRNA 5C	4x/Bulan	25%	100%	100%	Menurun	Lampiran B	IRNA 5C Mencapai Target
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	0%	100%	75%	Menurun	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A Tidak Mencapai Target
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	0%	75%	100%	Menurun	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A Mencapai target
IGD	4x/Bulan	50%	100%	100%	Me Menurun tingkat	Lampiran B	IGD Mencapai Target
FARMASI	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	FARMASI Mencapai target
GIZI	4x/Bulan	75%	100%	75%	Perlu di Tingkatkan	Lampiran B	Gizi Tidak mencapai target
IRJA	4x/Bulan	50%	100%	100%	Menurun	Lampiran B	IRJA Mencapai Target

ANALISIS : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Januari Tim PKRS telah melaksanakan edukasi dan mencapai target, beberapa Unit belum mencapai target yaitu ICU/HCU, IRNA 2,3,4A dan GIZI.

RTL : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Apret.

3.6.3.1 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

Unit	Target	Kegiatan	Nov	Des	Jan	%	MANDOK	KET
Forum Kesehatan Usia Lanjut (F-KUL) Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.2 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

Unit	Target	Okt	Nov	Jan	%	Bukti di Form Edukasi Terintegrasi atau kolaborasi	Ket
PONEK	4X/Bulan	100%	100%	100%	Tidak Tercapai	√	terlaksana
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	75%	100%	25%	Tidak Tercapai	√	Belum terlaksana
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	25%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
TB DOTS	4X/Bulan	25%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS
RTL

: Bulan Januari PROGNAS belum tercapai.
: Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

3.6.4 Tim Prognas

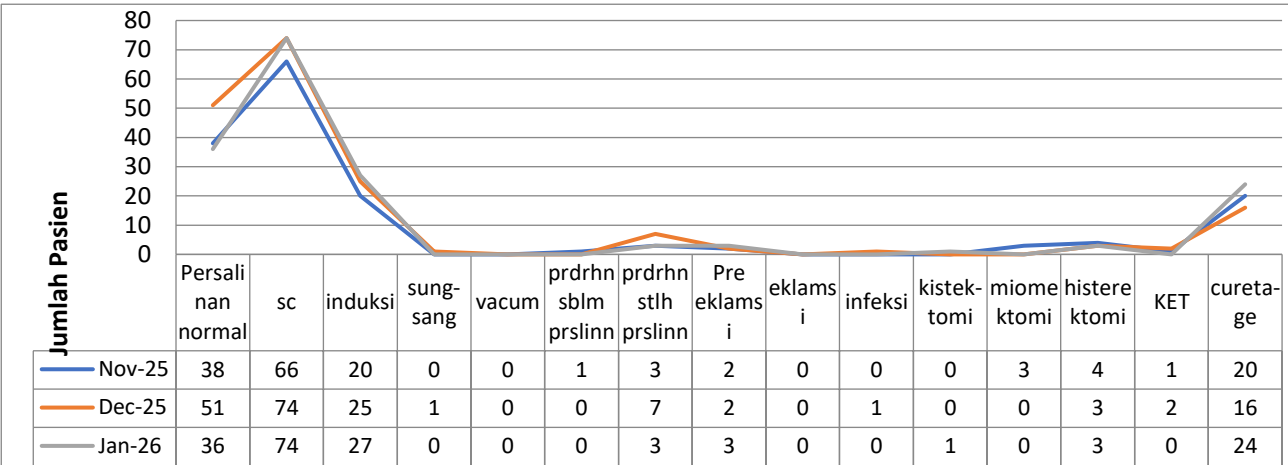
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Januari 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	38	51	36
	b. SectioCaesaria	66	74	74
2				
	a. Induksi / Drip	20	25	27
	b. Sungsang	0	1	0
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	1	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	7	3
	c. Pre Eklamsi	2	2	3
	d. Eklamsi	0	0	0

	e. Infeksi	0	1	0
4				
	a. Curretage	20	16	24
	b. Kistektomi	0	0	1
	c. Miomektomi	3	0	0
	d. Histerectomy	4	3	3
	e. KET	1	2	0

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Januari 2026 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 74 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 36 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu. Jumlah persalinan secara SC dan Persalinan normal pada bulan Januari menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah pasien INC di maternitas juga menurun pada bulan Januari 2026.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distres. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Januari 2026 dan bulan November 2025, sedangkang pada bulan Desember 2025 ada 1 persalinan sungsang. Dan tidak ada persalinan dengan vacuum pada bulan Januari 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
4. Induksi Persalinan pada bulan Januari 2026 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 27 pasien
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Januari 2026 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 3 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Januari 2026 maupun 2 bulan sebelumnya.

6. Jenis pelayanan curretage di bulan Januari 2026 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 24 pasien. *Curretage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

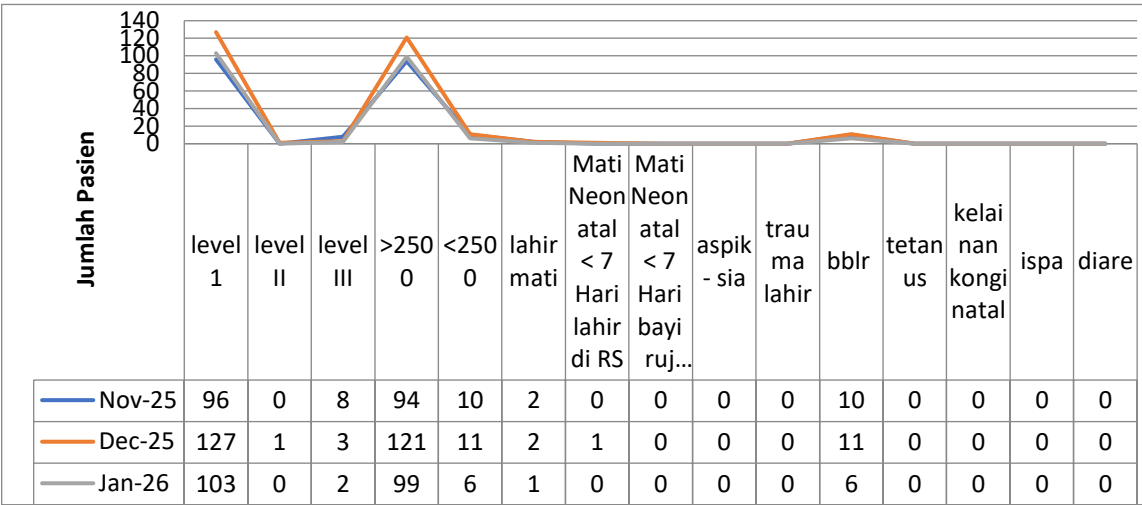
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Januari 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1				
	a. Level 1	96	127	103
	b. Level II	0	1	0
	c. Level III	8	3	2
2				
	a. ≥ 2500 gram	94	121	99
	b. ≤ 2500 gram	10	11	6
3				
	a. Kelahiran Mati	2	2	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari lahir di RS	0	1	0
	c. Mati Neonatal < 7 Hari bayi rujukan	0	0	0
4				
	a. Asphyxia	0	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	10	11	6
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Januari 2026



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 103 bayi. Dan untuk pelayanan level 2 pada bulan Januari yaitu 0, sedangkan pada level 3 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi. Jumlah bayi bulan Januari 2025 menurun seiring dengan jumlah persalinan pada bulan Januari 2026
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 99 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Januari 2026 juga menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 6 bayi.
5. Ada 1 kasus kelahiran mati pada bulan Januari 2026 dan pada bulan Desember dan November 2025 sama, yaitu 2 kasus.
6. Tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari yang lahir di RS pada bulan Januari 2026 dan November 2025, sedangkan pada bulan Desember ada 1 kasus.
7. Tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari yang bayi rujukan pada bulan Januari 2026 dan 2 bulan sebelumnya.

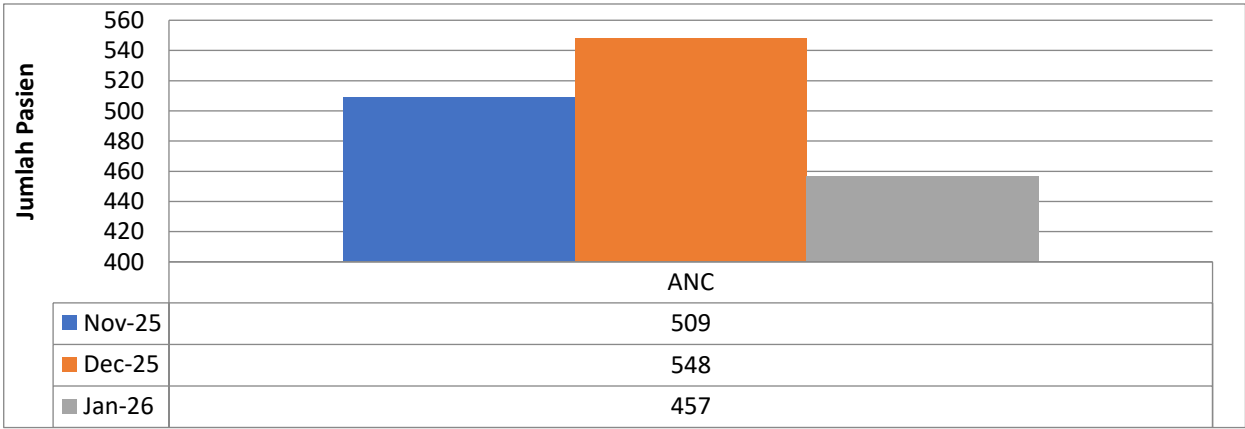
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.15 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek Januari 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	ANC	509	548	457

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Jnuari 2026



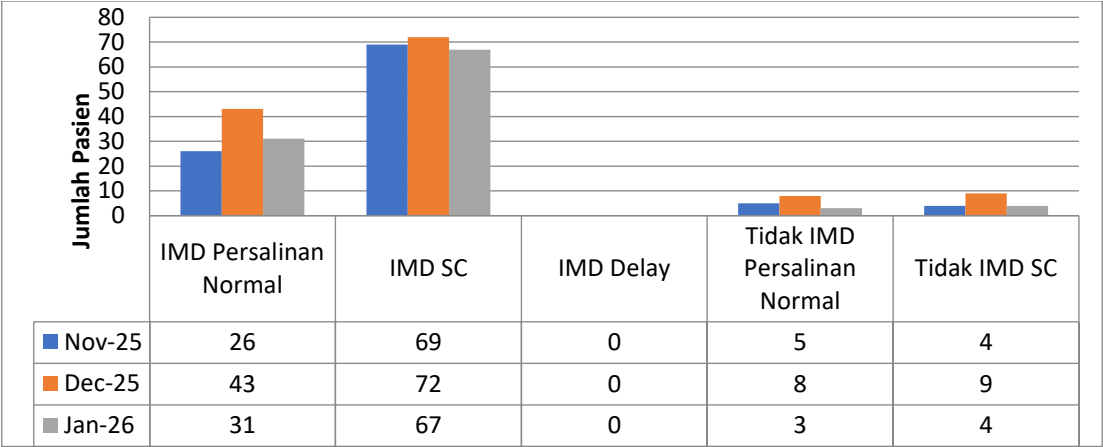
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Januari 2026 mengalami penurunan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 457 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.7.16 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Januari 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	IMD Persalinan Normal	26	43	31
2	IMD SC	69	72	67
3	IMD Delay	0	0	0
4	Tidak IMD Persalinan Normal	5	8	3
5	Tidak IMD SC	4	9	4

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada persalinan normal pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 31 bayi, sedangkan IMD pada SC sebanyak 67 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada persalinan normal pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 3 kasus, dan pada SC juga menurun yaitu 4 bayi.
- 3. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Januari 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
	Ny Linda Wati	NCB , BBLR	Cuvis
	Ny Diana	Pneumonia, NEC, BBLR	CPEP + Inkubator
SC			
	Ny Christyamara	NCB, BBLR	Cuvis
	Ny Hazizah	RDS, BBLR, Pneumonia, NKB	CPEP + Inkubator
	Ny Setyowati	NCB, BBLR	Cuvis
	Ny Rossianalis	NC, Ibu Hepatitis B	Infarm warmer

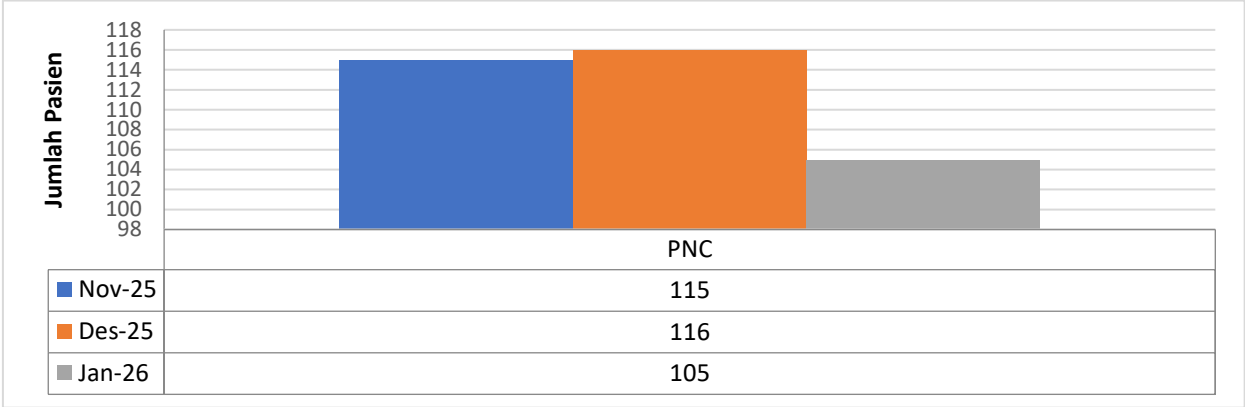
- 4. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

3.7.17 Pelayanan Post Natal Care (PNC)				
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Januari 2026				
No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	PNC	115	116	105

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

Pelayanan PNC pada bulan Januari 2026 sebanyak 105, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 116 kunjungan, dan bulan November sebanyak 115 kunjungan.

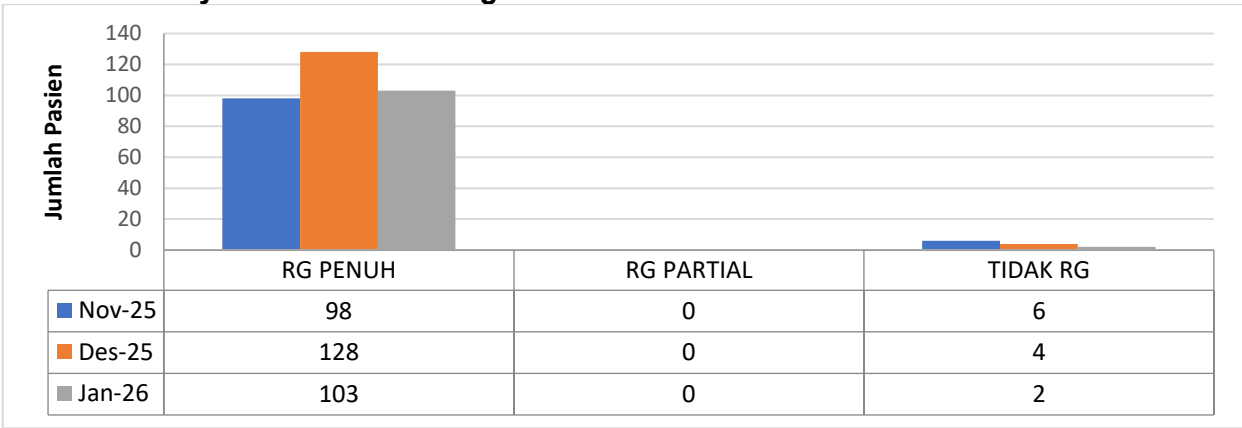
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Januari 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	Rawat gabung penuh	98	128	103
2	Rawat gabung partial	0	0	0
3	Tidak Rawat gabung	6	4	2

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 103 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Januari 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi.
3. Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
Ny Diana	Pneumonia, NEC, BBLR	CPEP+ Inkubator
Ny Hazizah	RDS, BBLR, Pneumonia, NKB	CPEP+ Inkubator

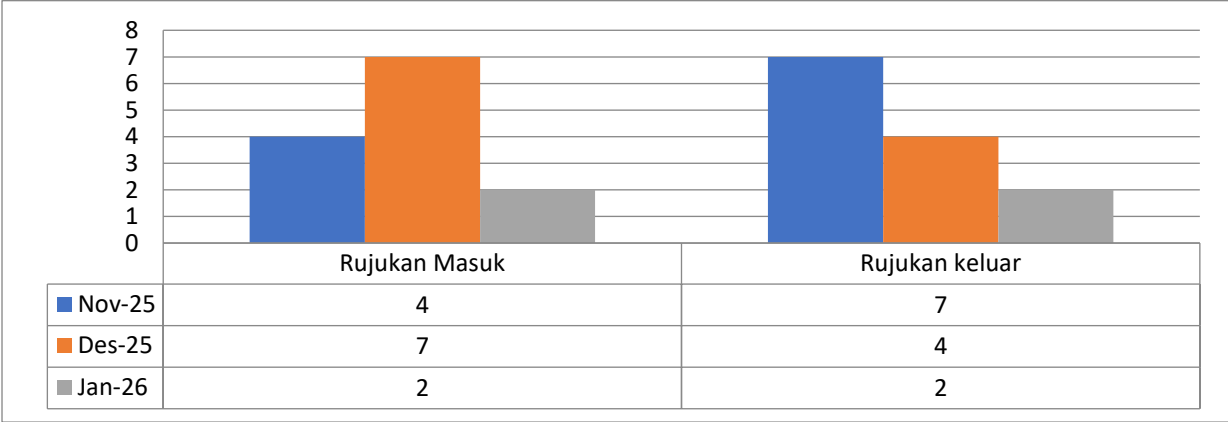
4. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек Januari 2026

Rujukan	Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
Rujukan Masuk	4	7	2
Rujukan keluar	7	4	2

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan November 2025

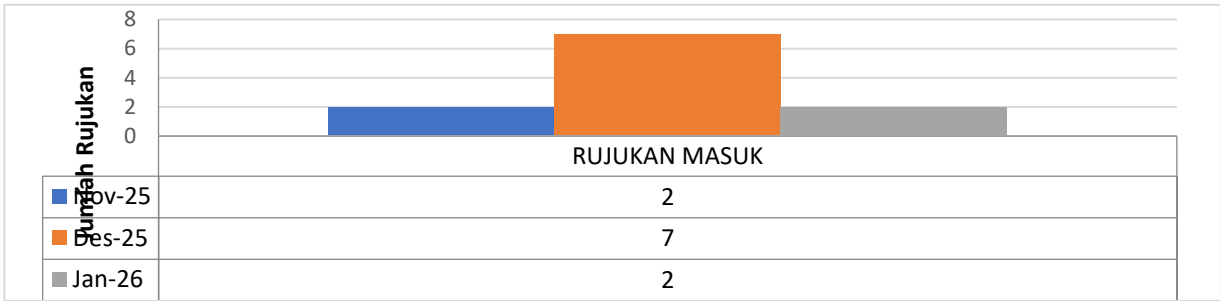


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponек Januari 2026

Bulan November 2025			
1	Ny Ipatul M	G3 P2002 Ab000 UK 32-34 minggu dengan PPI, Febris Hari ke 2	PKM Lawang
2	RISKA RISMAWANTI	G2 P1001 AB000 UK 32-34 MINGGU DNEGAN HEMOROID GRADE 4	RS GRAHA SEHAT MEDIKA
3	MAULIDIA AGUSTINA	G1P0000AB000 38-39 MG DG KALA 2 LAMA	BPM INDAH MAHARANI
4	By Ny Nurul F	BBLR, RDS	BPM Munawaroh
Bulan Desember 2025			
1	Ny Kurnia Fara Yunita	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan Prolong fase laten	PKM Singosari
2	Ny Puji Yuliani	G4 P3003 AB000 UK 37-38 minggu dengan KIFA + HT kronis	PMB Nurul Ismawati
3	Ny Elvina Darmayanti	G2P1001AB000 UK 37-38 minggu dengan letak sungsang + inpartu kala 1 fase laten	PKM Ardimulyo

4	NY Putri Maysyah	G1P000AB000 UK 38-39 minggu dengan prolong fase aktif	PKM Lawang
5	Ny Fara	G1P0000AB000 34-36 minggu dengan PPI	Klinik Mutiara Sehat
6	Ny Ranti Kusmawati	G3 P1001 AB1 UK 34-36 minggu + PPI + BSC < 2 tahun	RS Permata Bunda
7	By Ny Marchamah	Pneumonia, NEC	RS Enggal Waras
Bulan Januari 2026			
1	Ny Maddinatul Nor	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KPD	PMB Lilik
2	Ny Sinta	G2 P0000 Ab100 UK 39-40 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

Jumlah rujukan masuk pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan yang lalu, yaitu 2 rujukan, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 7 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

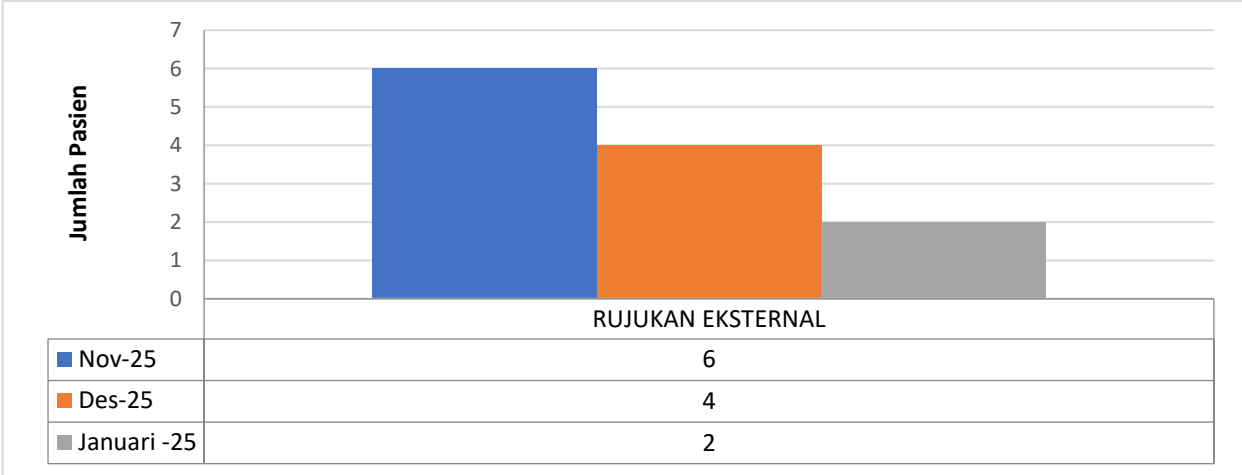
Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponек Januari 2026

No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan November 2025						
1	By Jerrel Gabrieal	18 hari	NICU	BBLASR,Apnew of prematurity, bronchopulmonary dysplasia, neonatal difficultybfeeding on breast, NEC, Congenital pneuminia	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Lavalette
2	By Jerrel Gabrian	20 hari	NICU	BBLASR,bronchopulmonary dysplasia, neonatal difficultybfeeding on breast, NEC, Congenital pneuminia	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Pantι Nirmala
3	By Ny Firda Ayu	6 hari	NICU	BBLSR, Neonatal Zeizure, pneumonia, NEC	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Lavalette
4	By. Ny khusnul W	1 hari	NICU	NCB, RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Pantι Nirmala
5	By Ny Ira S	2 hari	NICU	RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar

6	By Ny Farida	1 hari	NICU	RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Lavalette
Bulan Desember 2025						
1	Ny Yuli Sartika	35 Tahun	Maternitas	G1 P0000 Ab000 UK 12-14 minggu dengan akut abdomen dd apendicitis perforata dd abdominal pregnancy	Pro penanganan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
2	By Moh Akmal A	25 hari	NICU	Susp Ileus	Pro Beddah anak	RS Saiful Anwar
3	By Ny Diah Nur	3 Hari	NICU	NCB, RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
4	NY Ny Suyati	2 hari	NICU	Suspek Hypertrofic pylorus stenosis + Neonatal bronchopneumonia (perbaikan) + neonatal hipoglikemia (perbaikan)	Pro Diagnostik bedah anak	NCB, RDS
Bulan Januari 2026						
1	BY Ny Hazizah	1 hari	NICU	RDS, BBLR, Pneumonia, NKB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
2	Ny Rizki Mega	33 tahun	Maternitas	P0201 Ab100 dengan post partum VBAC + post histerektomi atas indikasi HPP + susp policitimiavera	Penangan Lebih lanjut	RS Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

Jumlah rujukan keluar pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 2 rujukan, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 4 rujukan, dan November sebanyak 6 rujukan keluar.

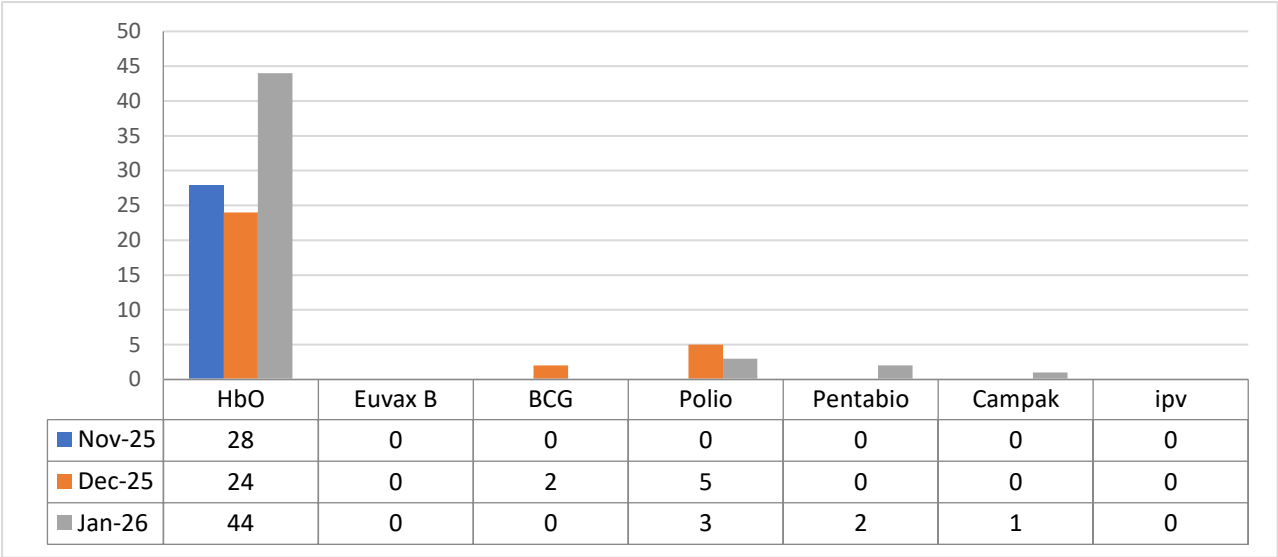
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponpek Januari 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	HbO	28	24	44
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	0	2	0
3	Polio	0	5	3
4	Pentabio	0	0	2
5	Campak	0	0	1
6	IPV	0	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Januari 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Januari 2026 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 44 bayi, sedangkan pada bulan Desember sebanyak 24 bayi, dan November sebanyak 28 bayi. Hal ini dikarenakan minimnya ketidakterersediaan vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Januari 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
4. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Januari 2026 dan November 2025, sedangkan bulan Desember 2025 ada 2 bayi.
5. Ada 1 bayi yang Imunisasi Campak bulan Desember, sedangkan 2 bulan sebelumnya tidak ada.
6. Ada 3 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Januari 2026, sedangkan bulan Desember sebanyak 5 bayi, dan bulan November tidak ada.
7. Ada 2 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Januari 2026 dan dan tidak ada pada 2 bulan sebelumnya. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

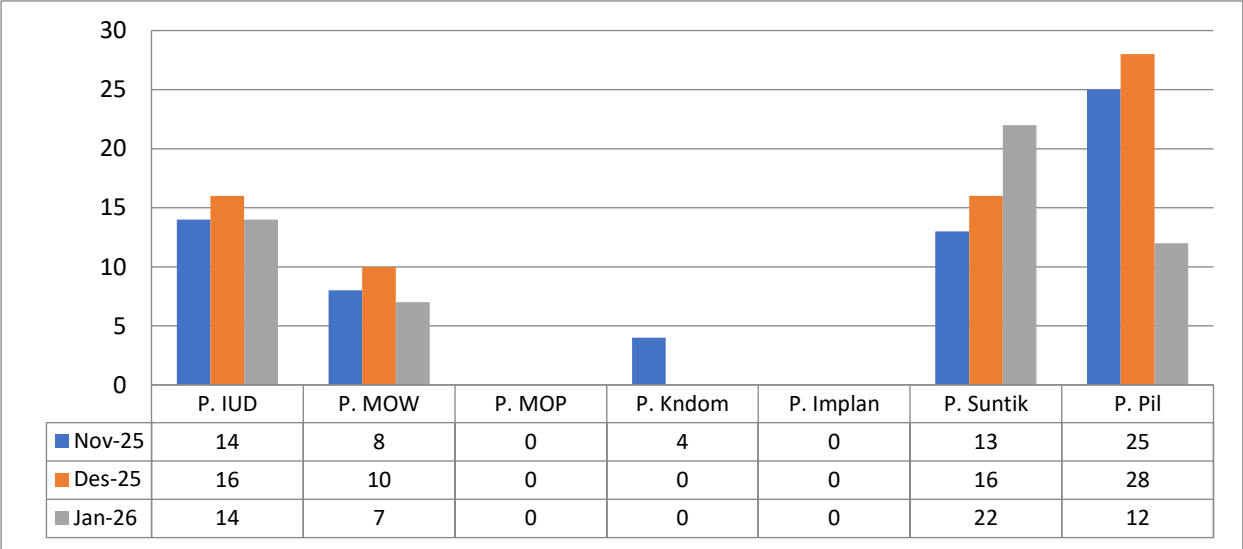
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayanan Keluarga berencana (KB) Ponek Januari 2026

No	Jenis	Jumlah Pasang		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	IUD	14	16	14
2	MOW	8	10	7
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	4	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	13	16	22
7	Pil	25	28	12

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2026



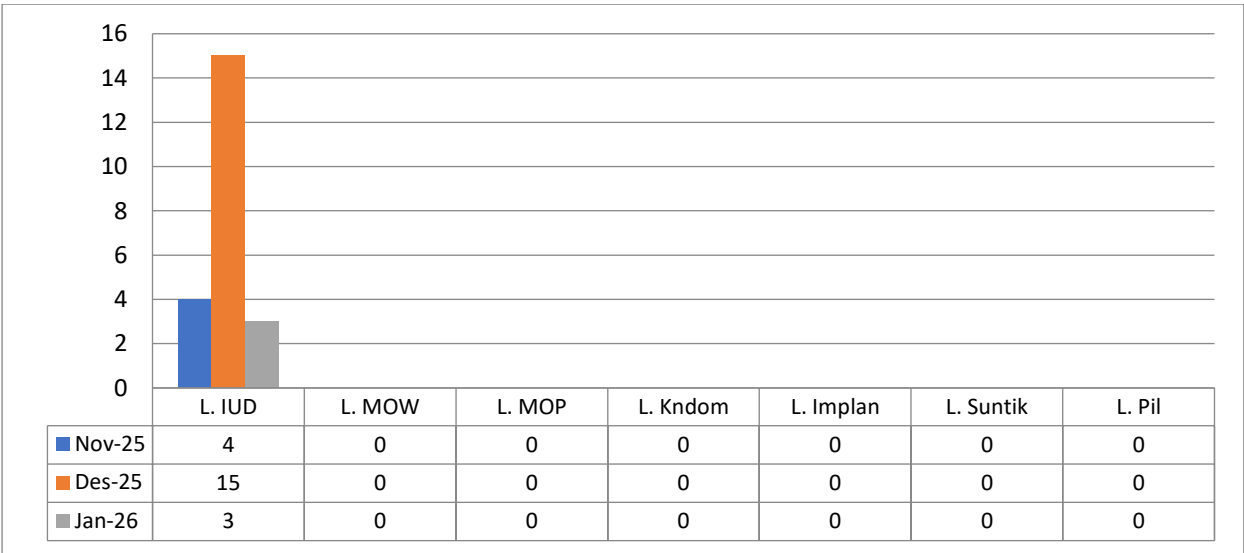
Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Januari 2026 sama dengan bulan November 2025, yaitu 14 akseptor, yang terdiri dari 9 akseptor IUD Nova T dan 5 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Januari 2026 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 7 pasien, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 10 pasien, dan November sebanyak 8 orang. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Tidak ada pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Januari 2026 dan Desember 2025, sedangkan pada bulan November yaitu 4 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 12 pengguna, sedangkan pada bulan Desember sebanyak 28 pengguna, dan November sebanyak 25 pengguna.
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Januari sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 22 pengguna, sedangkan bulan Desember 2025 sebanyak 16 pengguna, dan November sebanyak 13 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2026

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		November 2025	Desember 2025	Januari 2026
1	IUD	4	15	3
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0



- Analisis :**
1. Pelepasan KB IUD pada bulan Januari 2026 menurun yaitu 3 Akseptor, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 15 akseptor, dan November sebanyak 4 akseptor.
 2. Pelepasan KB Implan pada bulan Januari 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

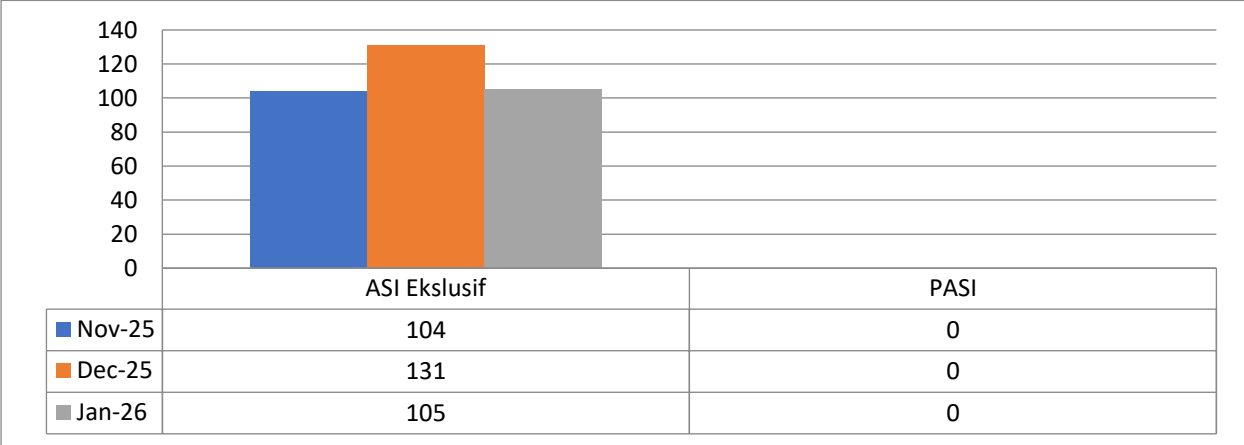
Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Januari 2026

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	Asi eksklusif	104	131	105
2	PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

- 1) Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Januari 2026 menurun yaitu 104 bayi, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 131 bayi, dan November sebanyak 104 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2) Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan Januari 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

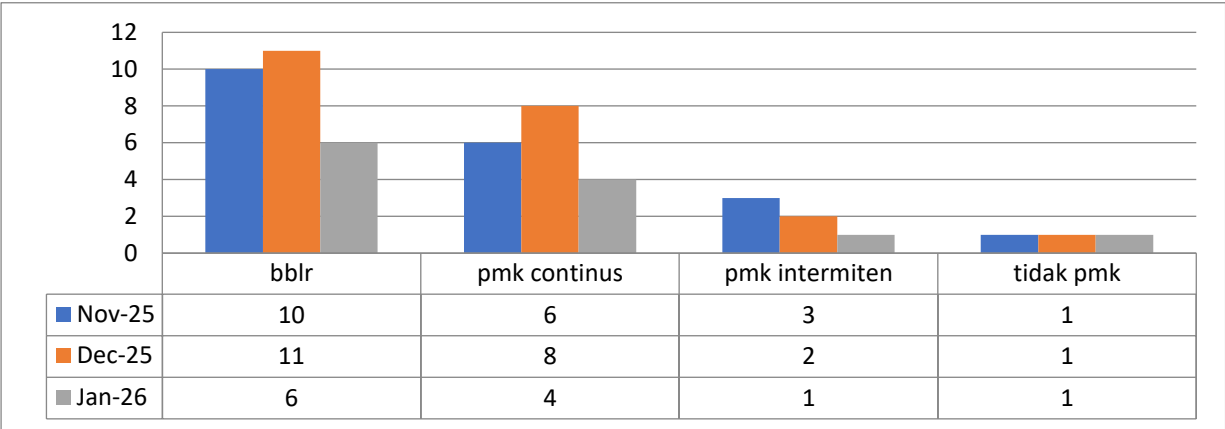
Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Januari 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2025
1	Bayi BBLR	10	11	6
2	PMK continuos	6	8	4
3	PMK Intermiten	3	2	1
4	Tidak PMK	1	1	1

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Janauri 2026



Analisis :

- 1) Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
- 2) Ada 1 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Januari 2026, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 2, dan November sebanyak 3. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
- 3) Sedangkan metode PMK continus pada bulan Januari 2026 sebanyak 4 bayi, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 8 bayi, dan November sebanyak 6 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
- 4) Ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Januari 2026 dan 2 bulan sebelumnya.

Berikut data bayi yang tidak dilakukan PMK :

Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
Ny Hazizah	RDS, BBLR, Pneumonia, NKB	C-PEP, inkubator, dan bayi dirujuk

Rencana dan Tindak Lanjut

Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN			KET
		Januari	Februari	Maret	
1.	Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB	2			
2	Pemberian Masker pada Keluarga TB+	0			
3	Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah	2			

Evaluasi :

- 1. Pada bulan Januari 2026 terdapat 4 pasien yang diberikan masker
- 2. Pada bulan Februari 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 3. Pada bulan Maret 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker

Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

**3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi
Bakteriologis Bulan Januari 2026**

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	01/01/2026	38 th	-	Positif	Positif	-
2	02/01/2026	36 th	-	Negatif	Negatif	Positif
3	10/01/2026	13th	Positif	-	Positif	-
4	12/01/2026	57th	-	Positif	Positif	-
5	12/01/2026	34th	-	Negatif	Positif	-
6	15/01/2026	63th	-	Negatif	Positif	-
7	18/01/2026	75th	-	Negatif	Positif	-
8	18/01/2026	22th	-	Positif	Positif	-
9	20/01/2026	65th	-	Positif	Negatif	-
10	28/01/2026	54th	-	Positif	Positif	-
11						
12						
13						
	Total		1	5	8	1

Analisis :

- 1. Pada bulan Januari 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 10 pasien dan pasien negatif sejumlah 26 pasien
- 2. Pada bulan Februari 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien
- 3. Pada bulan Maret 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

No	Unit	Jumlah Pasien		
		Januari	Februari	Maret
1.	Poli Paru	7		
2	Poli Bedah			
3	Poli IPD			
4	Poli Anak	1		

5	Irna 2C			
6	ICU			
7	IGD			
8	Irna 2A			
9	Irna 3C anak			
10	Irna 3A			
11	Irna 4A			
12	Maternitas 4C			
13	Irna 5C	2		
14	Irna 6A			
15	Irna 7A			
16	Irna 8A			
	Total			

Analisis :

1. Pada bulan Januari 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 10 pasien dan pasien negatif sejumlah 26 pasien
2. Pada bulan Februari 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien
3. Pada bulan Maret 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB di faskes terdekat.

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			Jumlah Total Pasien TB
		Januari	Februari	Maret	Total
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	63			
2	Pasien RFC (OAT Protolan)	3			
3	Pasien RFT	10			

Analisis:

1. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan Januari mencapai 63 pasien, di bulan Februari 0 pasien, dan di bulan Maret 0 pasien.
2. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan Januari 3 pasien, di bulan Februari 0 pasien dan di bulan Maret 0 pasien.
3. Jumlah keseluruhan kunjungandi poli pasien RFT di bulan Januari 10 pasien, di bulan Februari 0 pasien dan di bulan Maret 0 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	10		

Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

- Rencana dan Tindak Lanjut**
1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB keluarga wajib melakukan skrining di faskes terdekat agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH).
 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun dan dewasa yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB.

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian imunisasi BCG	0	0	0

- Evakuasi :**
1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari
 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Februari
 3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Maret

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Januari 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Tn. G	V		
		Ny.S	V		
		Tn. M.Z	V		
		Tn. J	V		
		Ny. N	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. S	V		
		Ny.E	V		

		Ny.R	V		
		Ny.T	V		
3.	dr. Fiona Paramitha. Sp.A	An. M.N	V		
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed				

Analisis :
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95	100%	100%	
2	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah	100%	100%	
3	Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort	100%	100%	

Analisis:
 Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

No	Penempatan Paien TB	Jumlah Pasien		
		Januari	Februari	Maret
1.	Penempatan pasien TB IGD	100%		
2	Penempatan pasien TB Poli Paru	100%		
3	Penempatan pasien TB di IRNA 5c	100%		

Analisis:
 Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Januari 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Januari	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny.E	V	-	1	PKM Ardimulyo	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
	Poli Paru	Ny.T	V	-	1	PKM Pakis	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C	Tn. R	V	-	1	PKM Singosari	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

- Analisis :**
1. Pada bulan Januari 2026 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 2. Pada bulan Februari 2026 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit karena pasien dengan
 3. Pada bulan Maret 2026 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP karena.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			ED
		Januari	Februari	Maret	
1.	OAT Anak	1			01/27
2.	OAT Harian Dewasa	5			11/26
3.	Ethambutol 250 mg	0			0
4.	Ethambutol 400 mg	112			05/26

5.	Pirazinamid 500 mg	556			05/27
6.	Isoniazid 300 mg	790			02/26
7.	Rimfapicin 450 mg	790			03/28
8.	Rimfapicin 300 mg	0			0

Analisis :
 Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

No	Unit	Jenis TB	Jumlah Pasien					
			Januari		Februari		Maret	
			Anak	Dewasa	Anak	Anak	Dewasa	Anak
1.		Pasien paru	1					
2.		Pasien Ekstra paru	8	1				

- Evaluasi :**
1. Pada bulan Januari 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 9 pasien paru
 2. Pada bulan Februari 2026 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru
 3. Pada bulan Maret 2026 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru

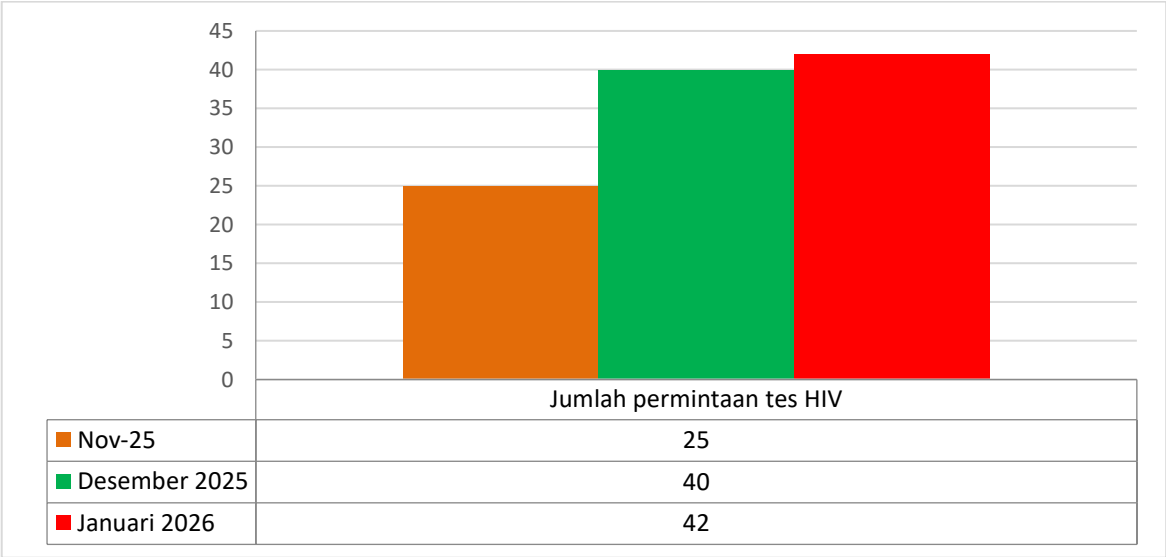
Rencana dan Tindak Lanjut :
 Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Permintaan Test HIV	25	40	42

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan November 2025 sebanyak 25 pasien pada bulan Desember 2025 sebanyak 40 pasien Sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 42 pasien.
Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

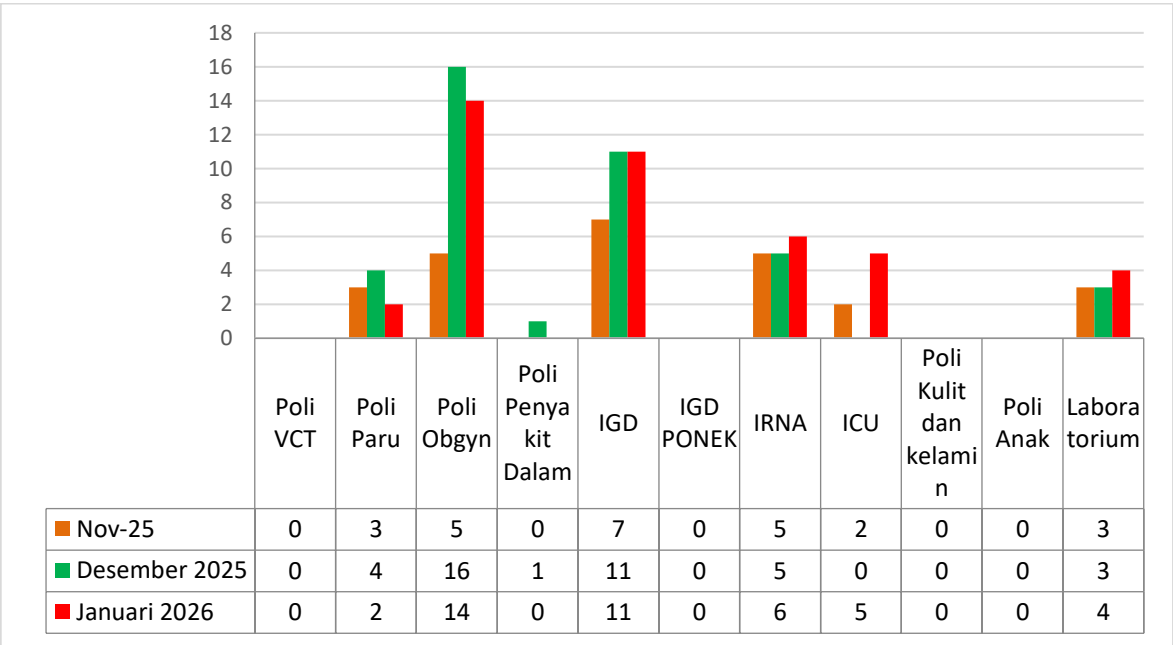
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.18 Asal Permintaan Tes HIV

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	3	4	2
3	Poli Obgyn	5	16	14
4	Poli Penyakit Dalam	0	1	0
5	IGD	7	11	11
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	5	5	6
8	ICU	2	0	5
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	3	3	4

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan Januari 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan November sebanyak 5

pasien, pada bulan Desember 14 pasien Sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 14 pasien.

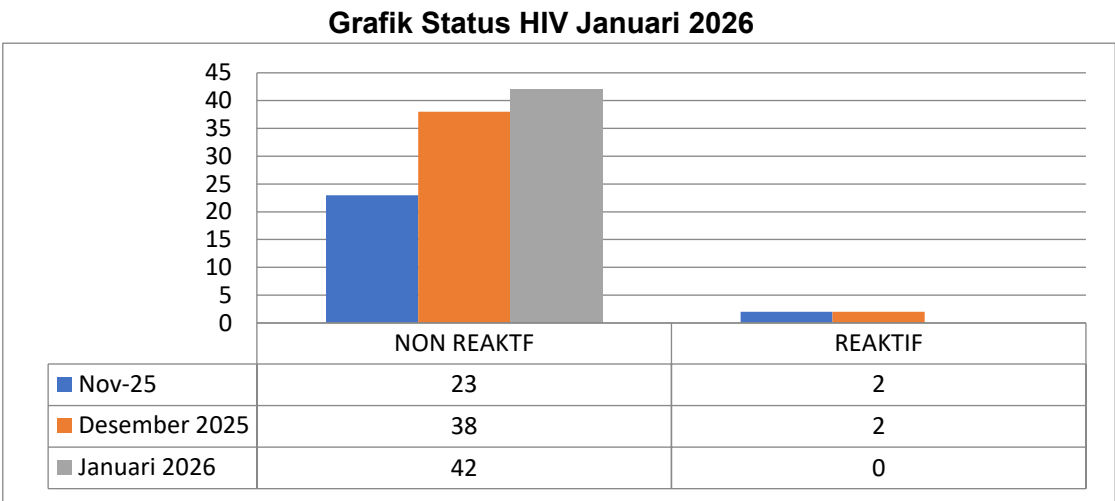
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Non Reaktif	23	38	42
2	Reaktif	2	2	0



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan November 2025 sebanyak 2 pasien dari IGD dan rawat inap. pada bulan Desember 2025 sebanyak 2 pasien dari IGD dan IRNA Sedangkan pada bulan Januari 2026 tidak ditemukan pasien yang reaktif HIV

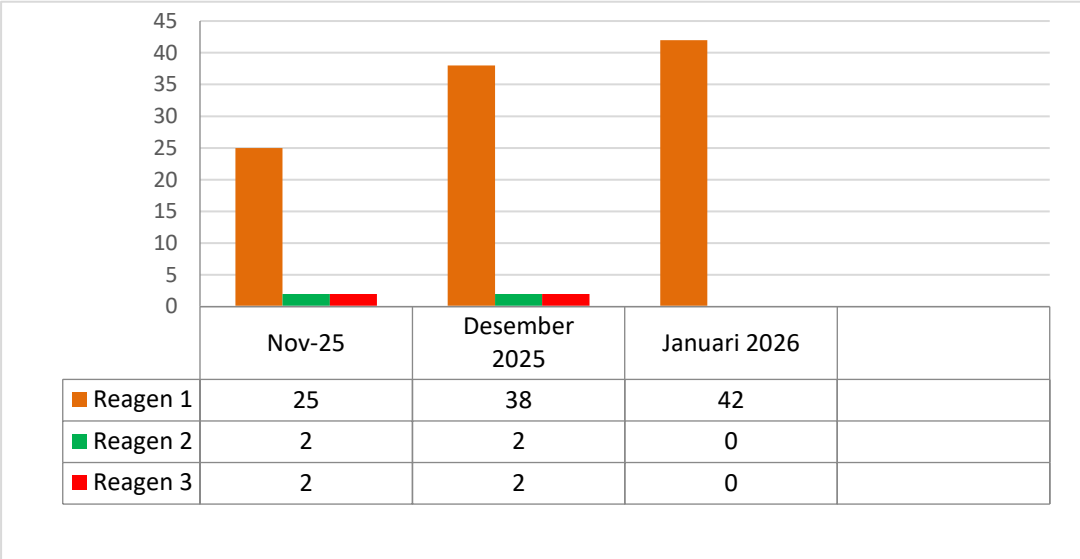
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.19 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Reagen 1	25	38	42
2	Reagen 2	2	2	0
3	Reagen 3	2	2	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Januari 2026



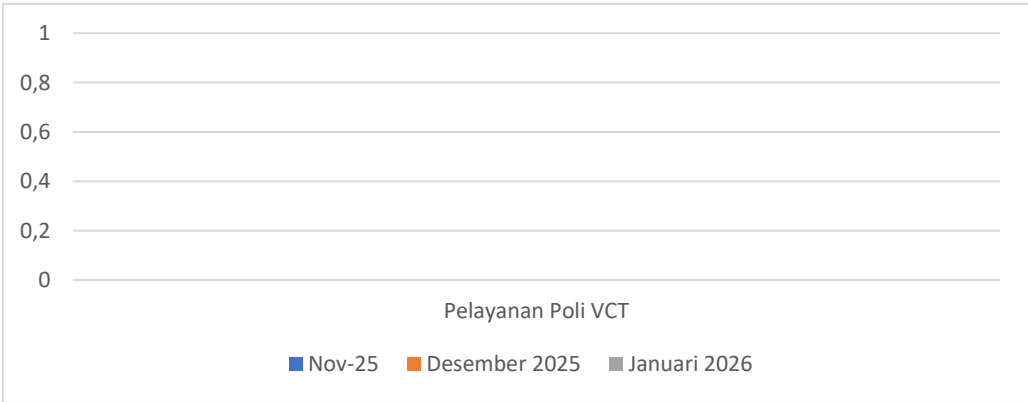
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan November 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien Pada bulan Desember 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien Sedangkan pada Bulan Januari 2026 hanya memakai reagen 1 saja karena tidak ada hasil reaktif HIV

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.20 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Januari 2026



Analisis pelayanan Poli VCT
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

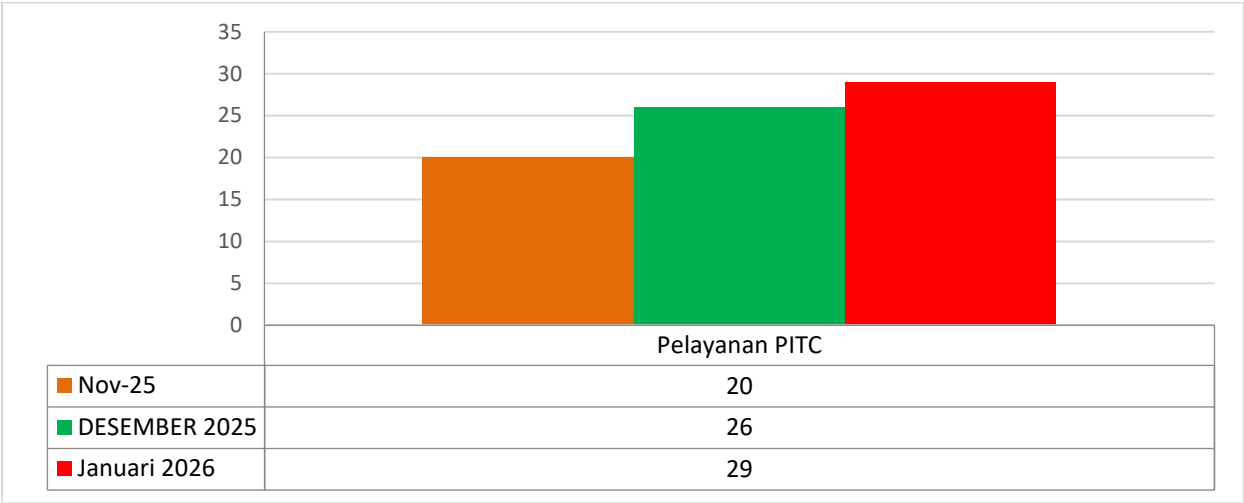
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenakan asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.21 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Pelayanan PITC	20	26	29

Grafik Pelayanan PITC Januari 2026



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan November 2025 sebanyak 20 pasien pada bulan Desember 2025 sebanyak 26 pasien . Sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 29 pasien

Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukkan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

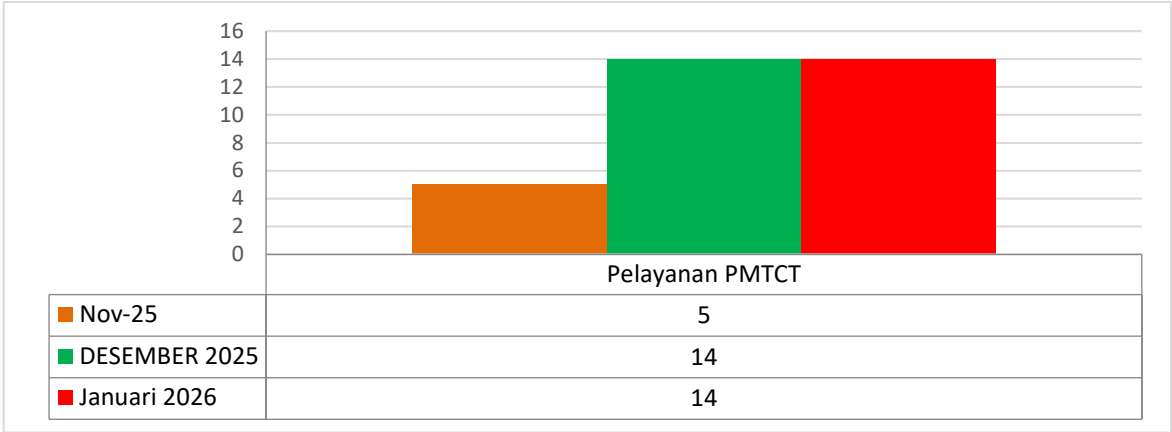
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjangiran pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.22 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Pelayanan PMTCT	5	14	14

Grafik Pelayanan PMTCT Januari 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan November sebanyak 5 pasien. pada bulan Desember 2025 sebanyak 14 pasien. Sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 14 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

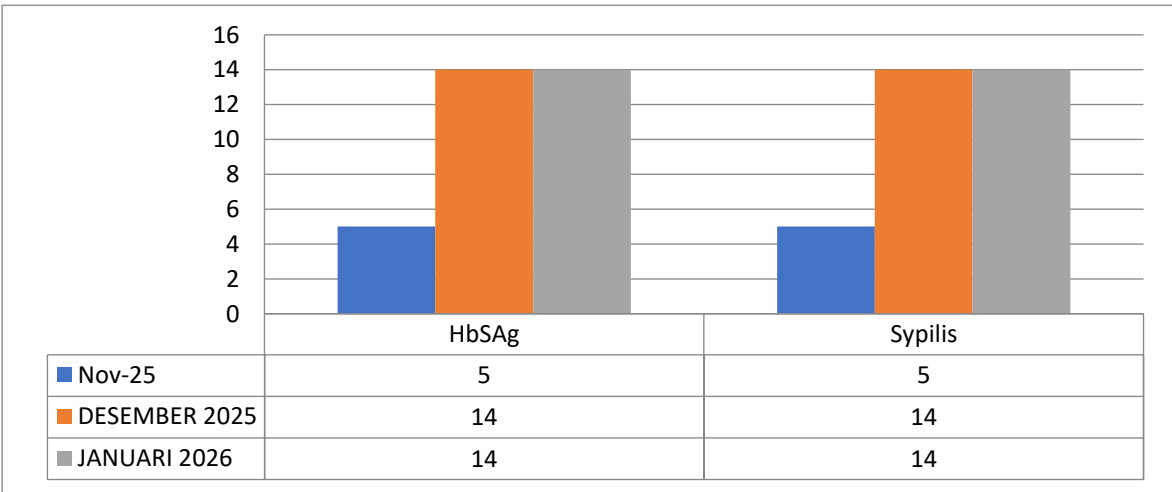
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.23 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	HbSAg	5	14	14
2	Sypilis	5	14	14

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Januari 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Syphilis pada bulan pada bulan November sebanyak 5 pasien. pada bulan Desember 2025 sebanyak 14 pasien. Sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 14 pasien Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Syphilis bisa dilakukan.

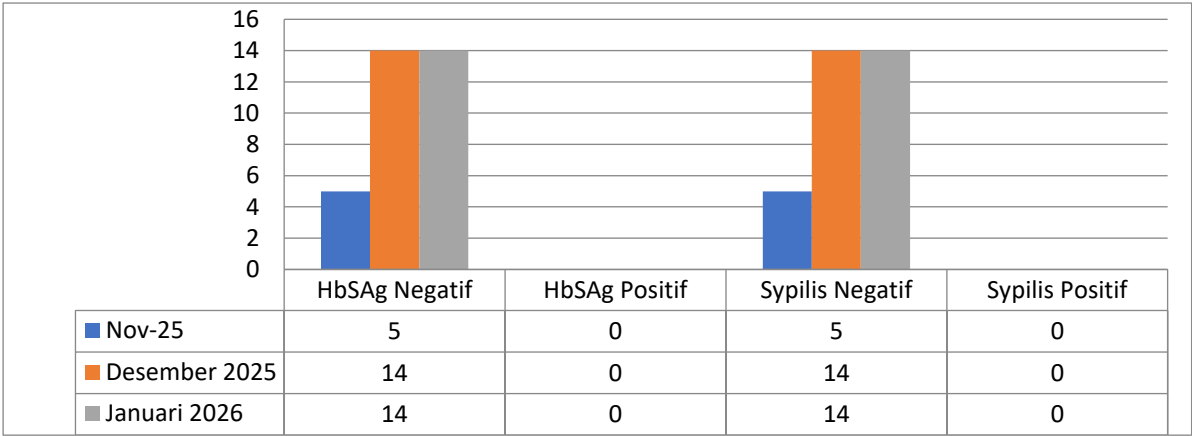
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.24 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	HbSAg			
	Negatif	5	14	14
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	5	14	14
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Januari 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan November, Desember 2025 dan Januari 2026 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Pada pasien HbSAg

Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit

Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.

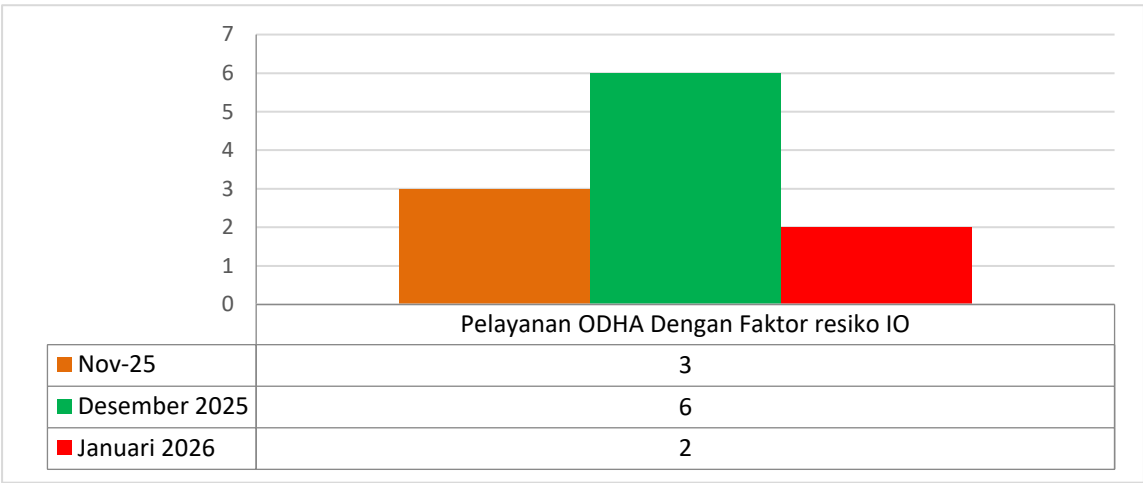
2. Pada pasien Sypilis

Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.25 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	3	6	2

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Januari 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. pada bulan November 2025 sebanyak 3 pasien. pada bulan Desember 2025 sebanyak 5 pasien. Sedangkan pada bulan Januari sebanyak 2 pasien

Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

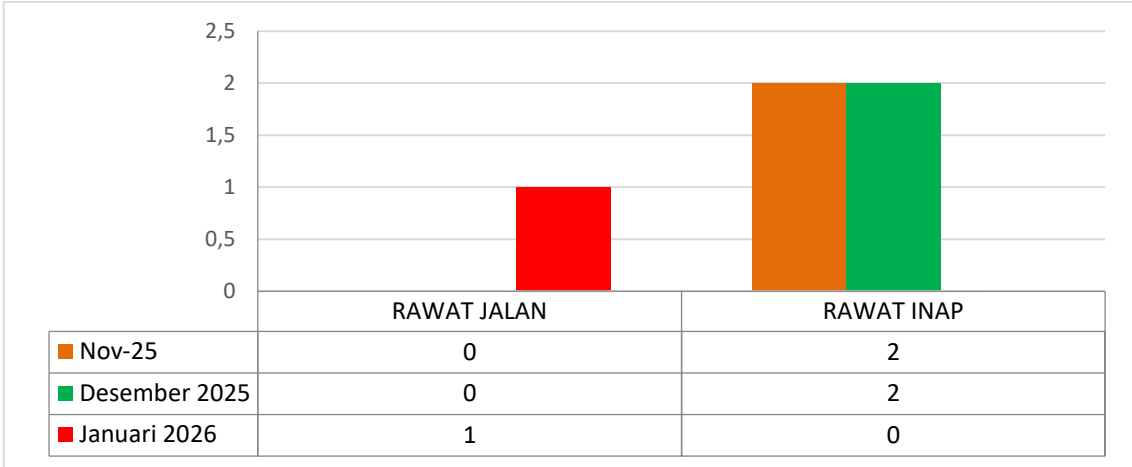
Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.

Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.26 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
1	Rawat Jalan	0	0	1
2	Rawat Inap	2	2	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Januari 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan oktober 2025 sebanyak 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap pada bulan November 2025 tidak ada pasien yang dilakukan rujuk baik dari rawat inap maupun rawat jalan. Sedangkan pada bulan desember 2025 terdapat sebanyak 2 pasien dirujuk melalui rawat inap.
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Januari 2026

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada

8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	November 2025	Desember 2025	Januari 2026
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1

	dan asam folat					
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	IRJA	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0

	program pemerintah mengenai pemberian vitamin A					
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

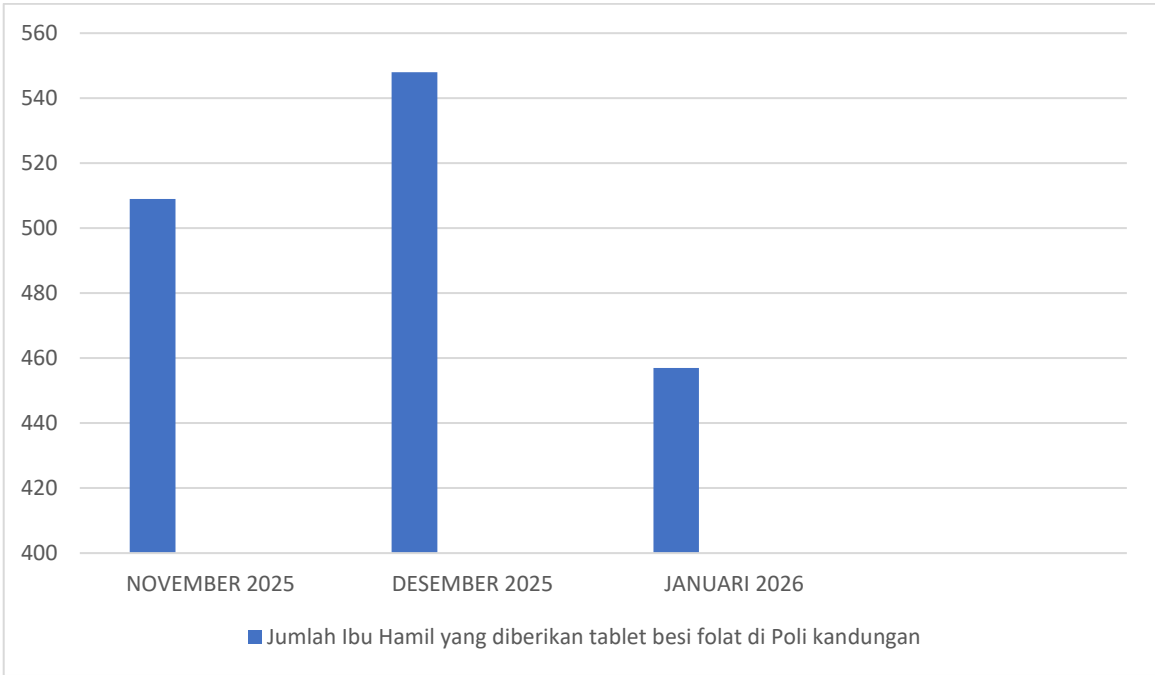
Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil

Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	November 2025	Desember 2025	Januari 2026
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	509	548	457

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Januari 2026



Analisis :

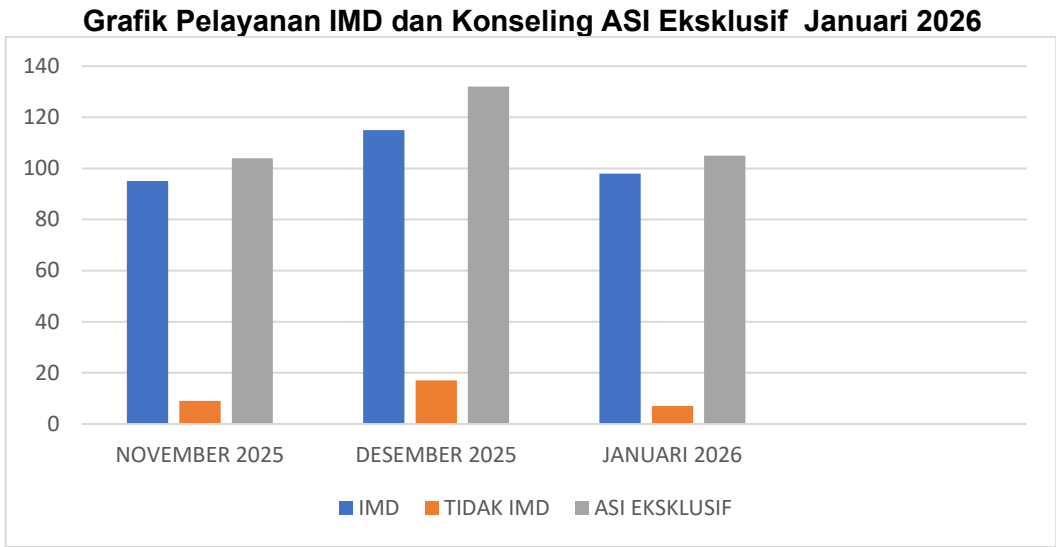
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat turun dari sebelumnya 548 di bulan Desember menjadi 457 pada bulan Januari yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2025	BULAN DESEMBER 2025	BULAN JANUARI 2026
1	IMD	95	115	98
2	Tidak IMD	9	17	7
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	104	132	105



- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Januari sebanyak 98 bayi.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Januari 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan penurunan jumlah pasien
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
 - 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif menurun pada bulan Januari 2026 yaitu sebanyak 105 pasien.

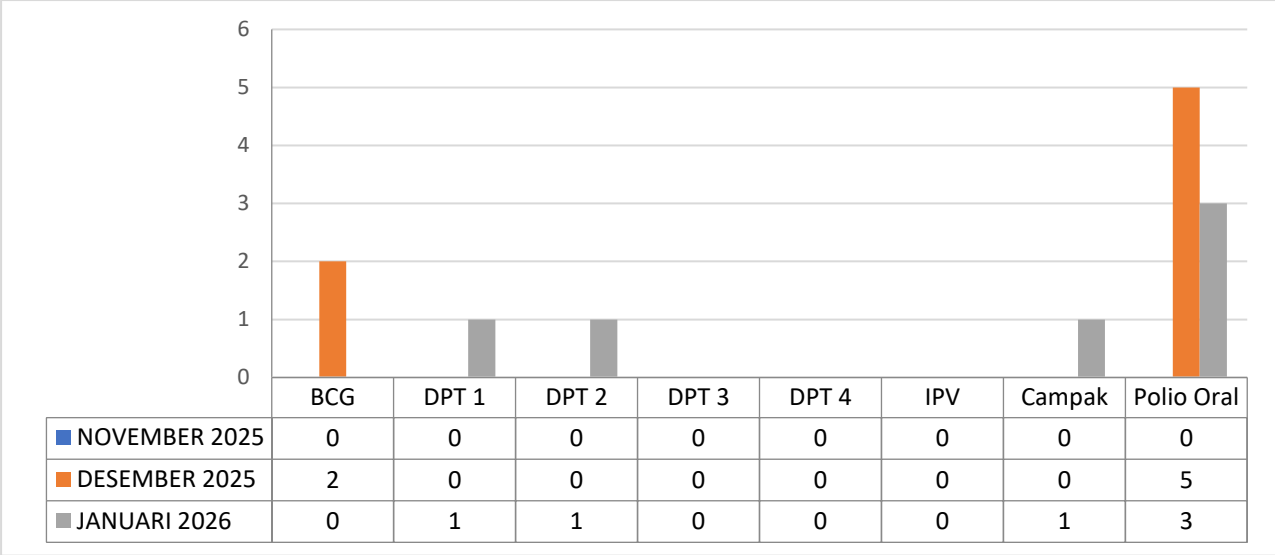
Rencana Tindak Lanjut:
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	BCG	0	2	0
2	DPT 1	0	0	1
3	DPT 2	0	0	1
4	DPT 3	0	0	0
5	DPT 4	0	0	0
5	IPV	0	0	0
6	Campak	0	0	1
7	Polio Oral	0	5	3

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Januari 2026



Analisis:

- 1. Pada bulan Januari sebanyak 1 balita melakukan imunisasi DPT 1, DPT 2, dan campak.
- 2. Sebanyak 3 balita melakukan imunisasi polio oral di Prima Husada Malang pada bulan Januari.
- 3. Pada bulan Januari tidak ada yang melakukan imunisasi BCG, DPT 3, DPT IV, IPV.

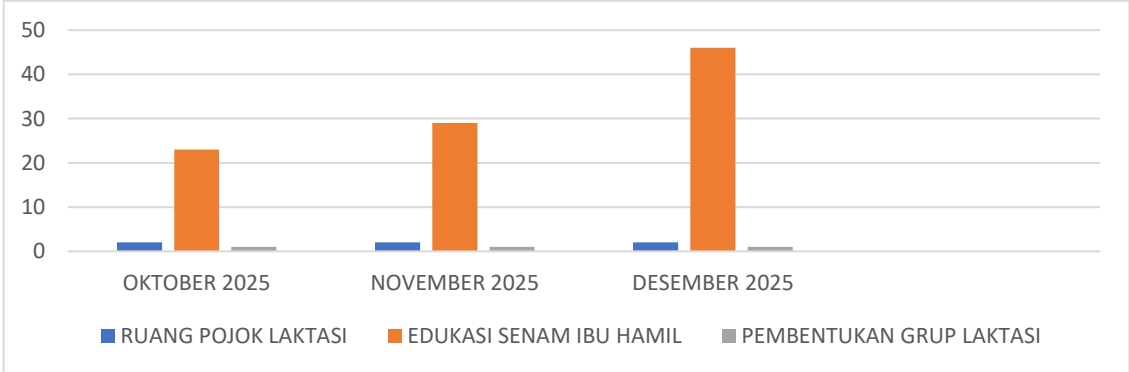
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	NOVEMBER 2025	DESEMBER 2025	JANUARI 2026
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	23	29	15
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Januari 2026



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan Januari edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Gizi Seimbang dan diet TKTP sebanyak 15 peserta, penyuluhan dilakukan di poli obgyn.

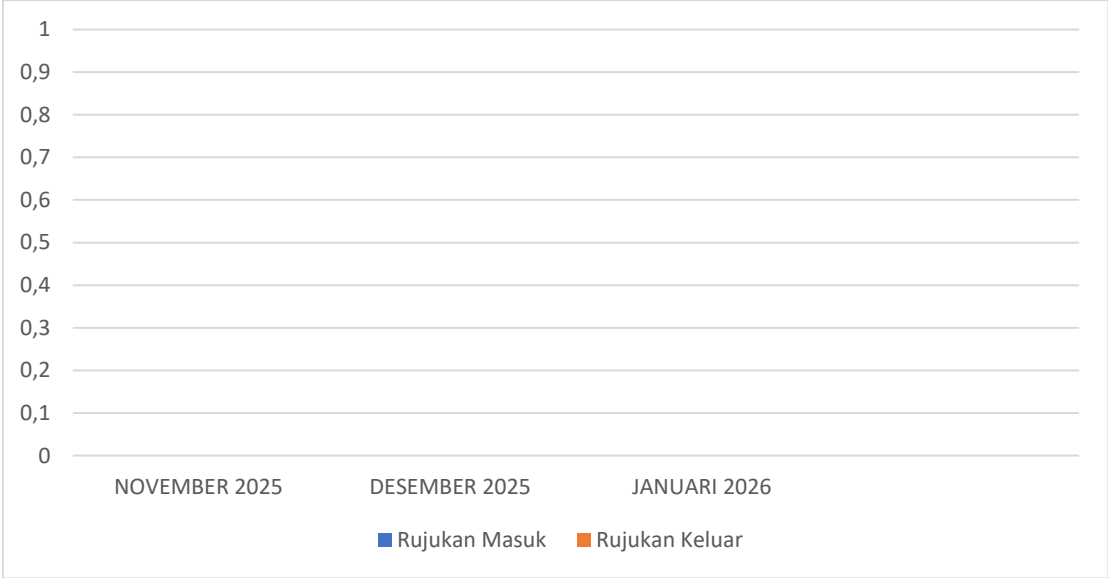
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Rujukan Masuk				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
Januari	-	-	-	-
Rujukan Keluar				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
Januari	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Januari 2026



Analisis :

Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS pada bulan Januari

Rencana Tindak Lanjut:

Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	November 2025	Desember 2025	Januari 2026
Jumlah Pasien Stunting	2	2	1
Jumlah Pasien Wasting	2	7	2

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Pada bulan Januari 2026 ditemukan sebanyak 2 balita berat badan kurang, 1 diantaranya termasuk dalam kategori stunting. Permasalahan yang ditemukan rata-rata balita kurang bervariasi dalam pola makannya, dan porsi makan tidak adekuat namun balita aktif. Selain itu, terdapat balita yang sakit dalam kurun waktu lama sehingga mengalami BB turun

Pemberian makanan tinggi energi dan tinggi protein di rumah sakit. Edukasi terhadap orang tua bagaimana dalam memberikan makanan gizi seimbang sesuai usia. Dan kolaborasi terhadap Ahli Gizi dan DPJP terus dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :

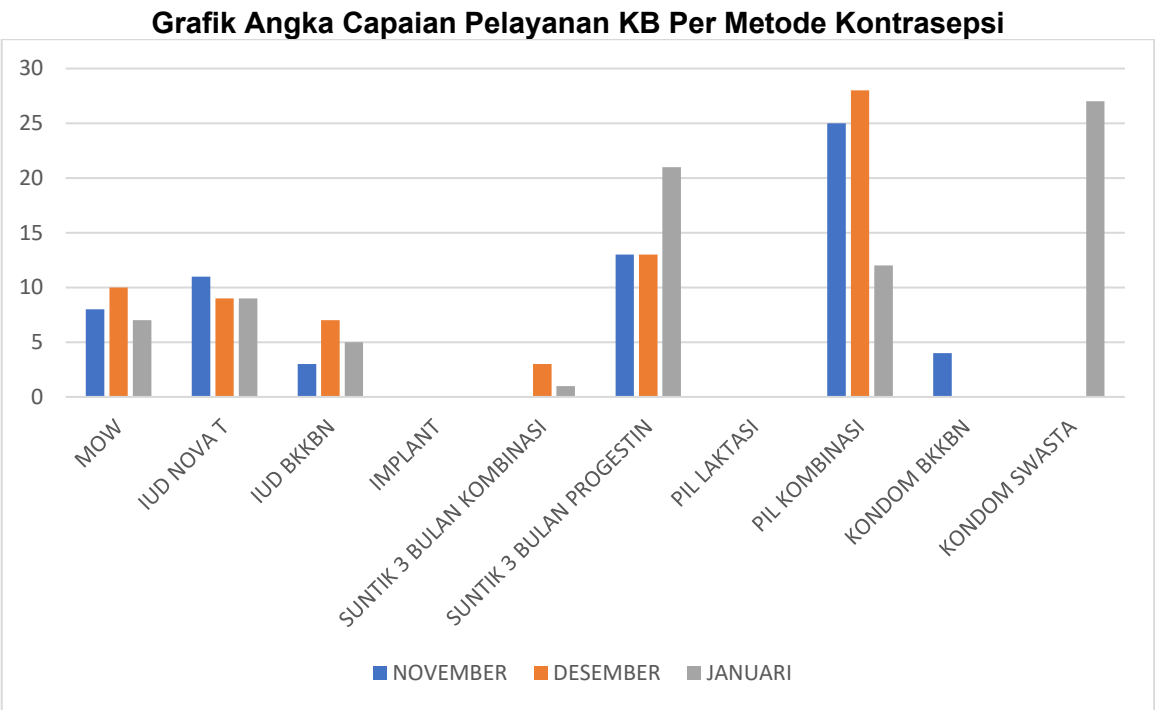
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan

3.1.2.5 KBRS

3.7.27 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2025	BULAN DESEMBER 2025	BULAN JANUARI 2026
1	MOW	8	10	7
2	IUD Nova T	11	9	9
3	IUD BKKBN	3	7	5

4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	0	3	1
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	13	13	21
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	25	12	12
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	4	0	0



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan November turun (8) pada Desember naik (10) Januari turun (7)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan November tetap 11 pada Desember turun (9) Januari tetap (9)
3. Peserta IUD BKKBN pada bulan November tetap (3) Desember naik (7) Januari turun (5)
4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan November turun (0) Desember naik (3) januari turun (1)
5. Peserta KB suntik progestin pada bulan November turun (13) Desember tetap (13) Januari naik (21)
6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan November turun (25) karena stok habis dan Desember naik (28) Januari turun (12) karena stok habis
7. Peserta KB Kondom BKKBN pada bulan November tetap (4) Desember turun karena stok habis (0) Januari (0) karena kosong dari BKKBN
8. Peserta KB Kondom swasta Januari (27) disediakan karena stok kondom dari BKKBN kosong

Analisis :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.

3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

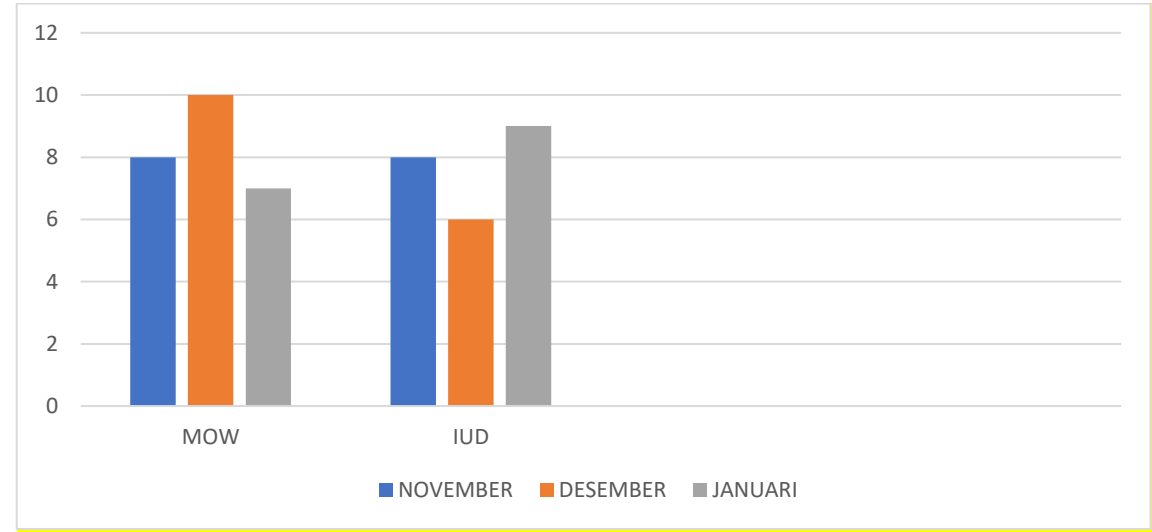
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

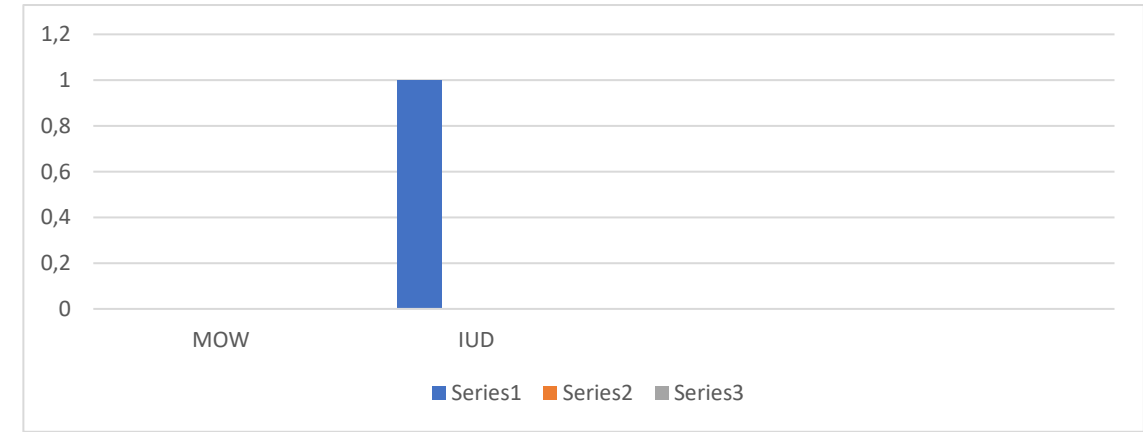
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2025	BULAN DESEMBER 2025	BULAN JANUARI 2026
1	MOW	8	10	7
2	IUD	8	6	9

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		Bulan November 2025	Bulan Desember 2025	Bulan Januari 2026
1	MOW	0	0	0
2	IUD	1	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan November-Desember - Januari meningkat
2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan November-Desember - Januari menetap.

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan 2026

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Januari 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Rizkia Afif	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	217127	Post Partum + Post Kuret	04/01/2026	06/01/2026	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	2	1,5	1,33
2	Princia D	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	242729	Abortus Incomplete	05/01/2026	06/01/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1,5	1,5	1
3	Della Ayu	P/21	dr. Humaira, Sp.OG	201506	Gravida SC	05/01/2026	07/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
4	Mitasari	P/30	dr. Aida, Sp.OG	133682	Kista Ovarium	11/01/2026	13/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
5	Nufaisah M	P/28	dr. Aida, Sp. OG	243470	IUVD	16/01/2025	17/01/2025	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
6	Maureen Danysha	P/26	dr. Aida, Sp.OG	034287	KPD	24/01/2026	26/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
7	Makrifatul S	P/18	dr. Humaira, Sp.OG	235521	Post SC + PEB	24/01/2026	26/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Evi Tamala	P/31	dr. Humaira, Sp.OG	241606	Post SC + KPD	28/01/2026	30/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
9	Elvira A	P/26	dr. Humaira, Sp.OG	071070	Post SC + Oligohidramnion	28/01/2026	30/01/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
10	Evi Tria	P/36	dr. Humaira, Sp.OG	041795	Post SC + BSC	28/01/2026	31/01/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
11	Abdul Rohim	P/58	dr. Anton, Sp.B	242896	TU Rectum	09/01/2026	11/01/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25

									Picyn		3x1,5	6	6	1
12	Ahmad Ashfa	L/15	dr.Zaki, Sp.B	243427	Gangrene pedis D	15/01/2026	17/01/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
13	Kholidah	P/60	dr. Anton, Sp.B	149637	TU Mamae D Post Biopsi	16/01/2026	18/01/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	6	6	1
14	M. Baihaki	L/33	dr. Oka, Sp.OT	243522	OF Calcaneus	17/01/2026	19/01/2026	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Wiyadi	L/71	dr.Zaki, Sp.B	212204	Hernia Scrontalis	18/01/2026	20/01/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
16	Sutomo	L/72	dr. Edi, Sp. U	189734	BPH Post TURP	19/01/2026	21/01/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
17	Siti Haniah	P/61	dr. Anton, Sp.B	243929	Gangrene gluteal post excisional debridement	25/01/2026	27/01/2026	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole po		3x0,25	0,75	2	0,375
18	Retno Wulan	P/52	dr. Arianto, Sp.B	244164	Vulnus Laceratum Ankle	28/01/2026	31/01/2026	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
19	Satria Destiyana	L/20	dr. Kuntadi, Sp. OT	001744	Fractur femur post orif	29/01/2026	31/01/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
20	Moch Soleh	L/69	dr. Pradana, Sp. U	243156	BPH Post TURP	29/01/2026	31/01/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
21	Lailatul Anisah	P/29	dr. Farid, Sp.N	242589	Obs konvulsi susp meningitis	02/01/2026	03/01/2026	2	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Clindamycin		4x0,6	1,8	1,2	1,5
22	Ula Trisnawati	P/43	dr. Andy, Sp.P	242695	Pneumoni	04/01/2026	08/01/2026	5	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Levofloxacin inj		1x0,75	2,25	0,3	7,5
23	Nawi	L/67	dr. Elvi, Sp.P	242851	COPD AE + PVC	07/01/2026	10/01/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
24	Elisya Diah	P/19	dr. Ardhi, Sp. Pd	242948	TF	08/01/2026	10/01/2026	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	1,5	1	1,5
25	Darti	P/60	dr. Ardhi, Sp. Pd	160066	ISK	09/01/2026	12/01/2026	4	Asam Pipemidat	1	2x0,4	2,4	0,8	3

26	Kasiyono	L/66	dr. Heri, Sp. Pd	102729	TF + CKD	09/01/2026	12/01/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	7	2	3,5
27	Abdul Mukti	L/48	dr. Elvi , Sp. P	239951	COPD AE	10/01/2026	13/01/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
28	Kukuh Budi	L/32	dr. Aji, Sp. Pd	243447	Cholelithiasis	16/01/2026	19/11/2026	4	Goforan	1	3x1	7	2	3,5
29	Suhaya	P/53	dr. Andy, Sp. P	240400	Pneumoni + acute respiratory failure + hipokalemi	16/01/2026	21/01/2026	6	Meropenem	1	3x1	12	3	4
30	Bayu P	L/62	dr. Mira, Sp. JP	244154	STEMI inferoposterior	28/01/2026	31/01/2026	4	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,2	0,8	1,5

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

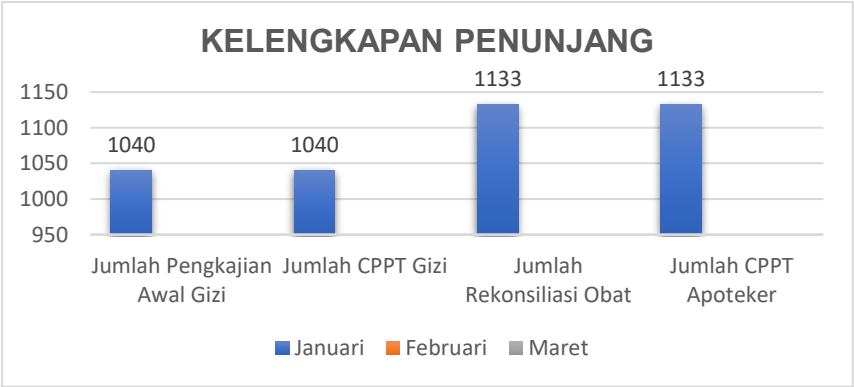
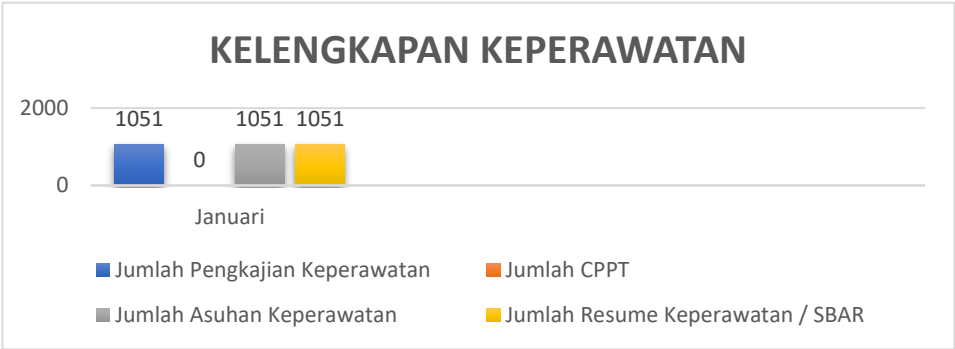
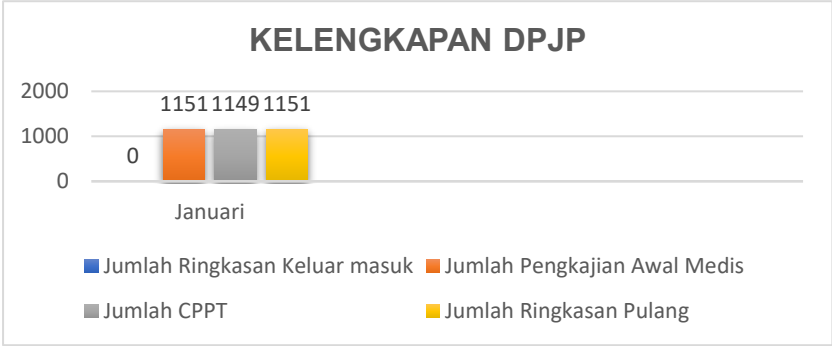
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Januari 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari																
Maret																
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR (Oktober)			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari																
Maret																
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari																
Maret																
April																
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Januari 2026



Analisis :

1. Ketidaklengkapan tertinggi poli per poli : IGD dan IRJA
2. Kelengkapan pengkajian keperawatan 97,18% pada Bulan Januari 2026
3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Januari 2026

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
2. Melakukan supervise secara berkala.
3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.28 Permasalah Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Persediaan labu darah ada miss komunikasi antara IKO dan Unit	P	Miss komunikasi dikarenakan alur komunikasi yang terputus antara unit, lab dan IKO
		D	Pastikan dan konsulkan pada anestesi atau operator apakah darah tersebut sifatnya persediaan saja tetapi tidak perlu dimasukkan segera atau cito yang harus dimasukkan saat durante op.
		S	Jika sifatnya cito dan kemungkinan dimasukkan saat durante, harus dilakukan permintaa crossmatch terlebih dahulu sehingga apabila ada permintaan bisa langsung ready tanpa menunggu corssmatch
		A	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan permintaan labu darah koordinasi dengan Kabid penunjang
2	Penginputan implant baru yang tidak terdaftar di master, sering lemah di Follow up ke pengadaan, sehingga baru diinput saat pasien akan KRS	P	Penginputan implant baru yang tidak terdaftar di master, sering lemah di Follow up ke pengadaan, sehingga baru diinput saat pasien akan KRS
		D	Sudah ada permintaan implant yang akan dipakai di grup konsinyasi, sehingga jika implant sudah digunakan harus segera lapor pengadaan dan pengadaan harus cepat menginput masternya
		S	Koordinasi dan follow up berkala terkait implant yang belum diinput sebelum pasien KRS
		A	Monitoring dan evaluasi antara IKO dan pengadaan terutama untuk pasien non BPJS yang pengesahannya harus diselesaikan di hari H.
3	Tidak dibawaikan hasil penunjang ke IKO	P	Tidak dibawaikan hasil penunjang ke IKO menandakan checklist pra operasi belum berjalan
		D	Monitoring dan supervisi karu dan tim IKO jika menerima pasien dari IGD maupun rawat inap
		S	Buat catatan staf yang tidak melakukan sesuai checklist

		A	Koordinasi dan sosialisasi kembali pada karu rawat jalan, rawat inap maupun IGD
--	--	---	---

3.7.29 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Anamnesa, pemeriksaan klinis, beberapa tidak sesuai diagnosa medis IGD, sehingga harus disesuaikan di akhir pada saat pasien sudah keluar dari IGD	P	Anamnesa, pemeriksaan klinis, beberapa tidak sesuai diagnosa medis IGD saat dihubungkan dengan pengkajian awal dan ringkasan pulang DPJP
		D	Khusus untuk pasien BPJS Kesehatan, saat rawat inap ada temuan diagnosa baru sehingga pengkodean disesuaikan dengan resources terbesar
		S	Kelengkapan anamesa perlu ditajamkan kembali melalui refreshment ilmu kegawatan dan morning report yang melibatkan dokter casemix, ka ins IGD dan dokter igd
		A	Monitoring dan koordinasi dengan verifitkator untuk temuan ketidaklengkapan dan ketidak sesuaian anamnesa pemfis dokter iGD untuk diajdikan mutu IGD
2	PR ERM dokter IGD terkait kesesuaian pemeriksaan fisik	P	Pengkajian anamnesa dan pemeriksaan fisik harus sinkron, karena untuk pengklaiman bpjs harus sesuai antara TTV dan klinis.
		D	Bagian yang sering terlewat adalah di pemfis bagian thorax : ronchi atau wheezing masih tertulis negative. Padahal dari anamnesa batuk grok grok lebih dari 1 minggu, respirasi meningkat
		S	Koordinasi dan mengingatkan dokter IGD agar lebih teliti kembali dalam penulisan pemfis
		A	Monitoring kelengkapan dan kesesuaian ERM koordinasi dengan kepala IGD dan verif
3	Sering terjadi miss pada pasien yang datang diantara operan shift	P	Pasien yang satang saat jam operan, petugas tidak tanggap sehingga pasien tidak segera dilakukan pemeriksaan
		D	Saat hand over, petugas selanjutnya bertanggungjawab untuk menerima pasien baru, sedangkan PJ shift melaporkan untuk tindakan lanjutan
		S	Kepala ruangan harus sosialisasi kembali terkait pembagian tugas / plotting perawat IGD dalam satu shift
		A	Monitoring dan supervisi karu ditingkatkan untuk meminimalisir komplain pasien di jam operan shift
5	Balasan advice dpjp diantara jam operan jaga beberapa kali tidak tersampaikan sehingga potensi menimbulkan IKP di rawat inap	P	Balasan advice dpjp diantara jam operan jaga beberapa kali tidak tersampaikan sehingga potensi menimbulkan IKP di rawat inap diantaranya terkait pemeriksaan penunjang, terapi obat, puasa, follow up rujukan dll.

		D	Apabila petugas mendapatkan balasan advice melalui WA, sedangkan pasien sudah ada di ruangan, silahkan langsung di cc kan ke ruangan terkait, jika tidak tahu ruangnya ada dimana, koordinasi dengan PJ shift dan cari di pencarian kamar
		S	Harus komunikasi dengan dpjp, menginformasikan bahwa pasien sudah dipindah ke ruangan
		A	Monitoring dan supervisi harus ditingkatkan untuk mengurangi mis komunikasi igd , dpjp dan ranap

3.7.30 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pemasangan infus pasien lodingan	P	Pasien lodingan belum terpasang infus, hanya diantar oleh perawat poli ke ruangan
		D	Perawat ruangan yang jaga terbatas 2 orang per shift, membuat cukup kewalahan jika harus mengambil bmhp ke apotik, kemudian melakukan tindakan infus
		S	Koordinasi dan rapat karu rawat jalan dan rawat inap untuk membuat SPO lodingan diinfus oleh perawat poli pada jam lodingan (pukul 08.30 dan 19.30)
		A	SPO lodingan sudah dibuat, monitoring pelaksanaan dan implementasi di lapangan
2.	HP ruangan sering tidak terhubung dengan WIFI, sehingga tidak mendukung proses tanda tangan digital pada ERM.	P	HP ruangan sering tidak terhubung dengan WIFI, sehingga tidak mendukung proses tanda tangan digital pada ERM
		D	Komunikasi dan koordinasi dengan IT dan Kabid umum, agar internet di NS harus stabil
		S	Apabila internet dan HP tidak support, harus diberikan alternatif lain seperti penginstallan di HP pribadi (Karu . PJ shift) hanya untuk back up tanda tangan jika jaringan lemah
		A	Monitoring dan supervisi dari bagian IT untuk kestabilan internet di seluruh ruangan NS rawat inap
3.	Saat visite pagi, petugas gizi dan apoteker datang bersamaan, sehingga penggunaan komputer harus bergantian. Hal ini kadang menghambat pelaporan kondisi pasien atau hasil penunjang.	P	Komputer rawat inap untuk fasilitas ERM adalah 2 tiap ruangan
		D	Visite oleh apoteker dan gizi adalah elektif dan bisa dikondisikan agar tidak bersamaan dengan visite DPJP
		S	Koordinasi dengan karu gizi dan kains apoteker agar bisa akses ERM lewat komputer selain di NS.
		A	Alternatif lain untuk computer, bisa kerjasama dengan Karu poli, karena beberapa poli ada yang tidak digunakan sehingga bisa untuk mencicil mengerjakan ERM
4	Ketidaksesuaian EWS pasien yang seharusnya masuk HCU, dimasukkan ke ruang biasa	P	Ketidaksesuaian EWS pasien yang seharusnya masuk HCU, dimasukkan ke ruang biasa dapat menyebabkan risiko kematian di ruang rawat inap meningkat.

		D	DPJP mempertimbangkan kondisi pasien yang masuk HCU atau ICU untuk pasien yang kompleks dan berisiko sangat tinggi , sehingga pasien dengan penurunan tensi, observasi RR ditaruh di ruang biasa dengan penggunaan monitor. Hal ini juga dikarenakan proporsi dan harga kamar HCU/ICU terlalu tinggi. Sehingga pertimbangannya bisa untuk pem.penunjang dan obat lainnya dibandingkan dengan membayar sewa kamar Rp. 500.000/ hari
		S	Karena jumlah perawat rawat inap yang terbatas, dan handel pasien ranap yang lain, observasi kurang maksimal
		A	Pengajuan dan review ruang HCU ke PT

3.7.31 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien kasus trauma khususnya KLL (pasien tidak pengurusan JR tetapi mendapat rujukan dari FKTP) sehingga pasien dilayani BPJS Kesehatan.	P	Pasien kasus trauma khususnya KLL (pasien tidak pengurusan JR tetapi mendapat rujukan dari FKTP) sehingga pasien dilayani BPJS Kesehatan di RS prima husada malang
		D	Skrining di poli, untuk kasus trauma yang ke poli bedah, ortopedi, bedah plastik, wajib menulis form kronologi
		S	Koordinasi dengan pendaftaran untuk mengkaji ulang perihal trauma pasien, jatuh dimana, KLL atau bukan, sehingga saatd I SEP sudah sesuai
		A	Pengkajian lebih teliti oleh perawat dan KIE pada pasien yang sudah terlanjur didaftar menggunakan bpjs di PHM. Hubungi PIC BPJS PHM (mb kiki) agar dikonfirmasi ke Faskes 1 agar lebih teliti dalam merujuk sehingga apabila tidak ada surat JR nya, maka tidak boleh dikeluarkan rujukan. Berikan waktu 3x24 jam untuk pasien agar melampirkan surat JR (KIE pengurusan terlebih dahulu), apabila pasien tidak berkenan maka pembayaran menjadi UMUM
2	Kebijakan konsul internal	P	Pasien poli yang mempunyai rujukan lebih dari satu, untuk kunjungan selanjutnya harus dilakukan konsul internal
		D	Potensi fragmentasi jika diidentifikasi pasien menggunakan 2 rujukan untuk kontrol ke RSPHM
		S	Jika pasien kronis, maka salah satu harus di PRB, jika pasien membutuhkan 2 DPJP sekaligus diberlakukan konsul internal (kecuali rujukan poli gigi), dan monitoring target untuk PRB atau stabilnya kapan
		A	Pasien yang mempunyai 2 rujukan, di list di grup pelayanan yang isinya PDF, Poli , farmasi dan Asce. Diharapkan jika ada pasien dengan 2 rujukan, salah satu harus ditarget dan di warning ke DPJP untuk PRB. Jika tidak bisa di PRB, harus disertakan

			alasannya.
3	Alur pasien ODC non bpjs masih belum jelas	P	Alur masih belum jelas setelah pasien daftar --> ke IGD untuk pasang infus dan pengambilan darah --> dijemput perawat poli untuk diantar ke IKO --> Perawat poli input BMHP yg digunakan di IGD --> Operan dengan perawat IKO dan hasil lab dilaporkan oleh Perawat IKO ke DPJP dan Anastesi (karena hasil lab belum jadi dan pasien menunggu di ruang premed)
		D	Rapat dan koordinasi dengan karu IGD, Karu IRJA dan Karu IKO
		S	Pembuatan SPO Alur pasien ODC NON BPJS (Umum atau asuransi)
		A	Monitoring dan supervisi pelaksanaan SPO di lapangan

3.8

Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	S1 Kesehatan Lingkungan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	39	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		21	14	7	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0

13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		5	3	2	0
14	IGD	Profesi Ners	22	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	1
		D3 Keperawatan		4	4	0	1
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
17	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
18	IRJA	Profesi Ners	29	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		16	14	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	17	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		10	6	4	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	8	1	0	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		7	6	1	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0

		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	39	13	7	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	11	4	2	2	0
		SMA		7	6	1	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
Total Karyawan			361	361	275	86	2
42	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	1
43	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0

60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			61	61	2	59	0
Total Keseluruhan			422	422	277	145	2

Keterangan :
Pada bulan Januari terdapat 2 staf resign unit IKO

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Januari 2026 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Januari 2026, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 08 Februari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/II/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025